

Bunga Rampai
**ASUHAN KEPERAWATAN
PADA LANSIA**
Dengan Gangguan Tidur

Susi Milwati • Resa Livia Nica • Nunung Nurhayati

Editor: Ratna Kusuma Astuti



BUNGA RAMPAI: ASUHAN KEPERAWATAN PADA LANSIA DENGAN GANGGUAN TIDUR

Penulis:

Dr. Susi Milwati, S.Kp., M.Pd.

Resa Livia Nica, S.Kep., Ns., M.Kes.

Ns. Nunung Nurhayati, S.Kep., M.Kep.

Editor:

Ratna Kusuma Astuti, S.Kep., Ns., M.Kep.



Bunga Rampai: Asuhan Keperawatan Pada Lansia Dengan Gangguan Tidur

Penulis:

Dr. Susi Milwati, S.Kp., M.Pd.
Resa Livia Nica, S.Kep., Ns., M.Kes.
Ns. Nunung Nurhayati, S.Kep., M.Kep.

Editor:

Ratna Kusuma Astuti, S.Kep., Ns., M.Kep.

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Helmi Syaukani, S.Pd.

ISBN: 978-634-7756-44-2

Cetakan Pertama: Juni, 2026

Hak Cipta 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2026

By Penerbit PT Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang Keras Menerjemahkan, Memfotokopi, Atau Memperbanyak Sebagian Atau Seluruh Isi Buku Ini Tanpa Izin Tertulis Dari Penerbit.

Website : Optimaluntuknegeri.Com

Instagram : [@Bimbel.Optimal](https://www.instagram.com/Bimbel.Optimal)

Tiktok : [@Maskokooo](https://www.tiktok.com/@Maskokooo)

PENERBIT:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta

Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025



PRAKATA



Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, karunia, dan kesehatan sehingga bunga rampai berjudul **“Asuhan Keperawatan pada Lansia dengan Gangguan Tidur”** ini dapat disusun dengan baik. Buku ini hadir sebagai salah satu bentuk kontribusi akademik dalam memperkaya wawasan, pengetahuan, serta keterampilan praktis bagi mahasiswa, dosen, perawat, tenaga kesehatan, maupun pihak-pihak yang memiliki perhatian terhadap peningkatan kualitas hidup lansia.

Lansia merupakan kelompok usia yang mengalami berbagai perubahan biologis, psikologis, sosial, dan spiritual sebagai bagian dari proses menua. Salah satu masalah yang sering dialami oleh lansia adalah gangguan tidur, baik berupa kesulitan memulai tidur, sering terbangun pada malam hari, tidur yang tidak nyenyak, maupun bangun terlalu dini. Gangguan tidur pada lansia tidak hanya berdampak pada rasa lelah, tetapi juga dapat memengaruhi fungsi kognitif, kestabilan emosi, daya tahan tubuh, risiko jatuh, serta kualitas hidup secara menyeluruh. Oleh karena itu, perawat memiliki peran penting dalam melakukan pengkajian, memberikan edukasi, serta menerapkan intervensi keperawatan yang tepat dan aman.

Bunga rampai ini membahas beberapa aspek penting dalam asuhan keperawatan pada lansia dengan gangguan tidur. Pembahasan diawali dengan **konsep dasar proses menua dan**

perubahan pola tidur lansia, sehingga pembaca dapat memahami hubungan antara penuaan dan perubahan kebutuhan istirahat tidur. Selanjutnya, buku ini menguraikan **faktor-faktor yang memengaruhi gangguan tidur pada lansia**, baik faktor fisik, psikologis, lingkungan, gaya hidup, maupun kondisi penyakit penyerta. Pembahasan kemudian dilengkapi dengan **intervensi nonfarmakologis dalam meningkatkan kualitas tidur pada lansia**, yang menekankan pendekatan keperawatan holistik, aman, dan sesuai dengan kebutuhan individu lansia.

Penyusunan buku ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pentingnya asuhan keperawatan dalam menangani gangguan tidur pada lansia. Melalui pendekatan nonfarmakologis, perawat dapat membantu lansia membangun kebiasaan tidur yang lebih sehat, menciptakan lingkungan tidur yang nyaman, mengurangi kecemasan, serta meningkatkan kenyamanan fisik dan psikologis. Dengan demikian, asuhan keperawatan tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan tidur, tetapi juga pada upaya mempertahankan kemandirian, martabat, dan kualitas hidup lansia.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan bunga rampai ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu keperawatan gerontik serta menjadi referensi yang berguna dalam pendidikan, penelitian, dan praktik pelayanan keperawatan. Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran

yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ini pada masa mendatang.

Akhir kata, semoga bunga rampai ini dapat menjadi sumber inspirasi dan pengetahuan dalam memberikan asuhan keperawatan yang lebih bermutu, humanis, dan berpusat pada kebutuhan lansia, khususnya lansia yang mengalami gangguan tidur.

Juni 2026

Penulis



DAFTAR ISI



PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi

CHAPTER 1 KONSEP DASAR PROSES MENUA DAN PERUBAHAN POLA TIDUR LANSIA 1

Dr. Susi Milwati, S.Kp., M.Pd.	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Tujuan Pembelajaran.....	2
C. Konsep Lansia	2
D. Penggolongan Usia Lansia.....	5
E. Konsep Dasar Proses Menua.....	9
F. Teori Proses Menua	13
G. Konsep Dasar Tidur.....	20
H. Perubahan Pola Tidur Pada Lansia.....	25
I. Patofisiologi Gangguan Tidur pada Lansia	30
J. Perubahan Pola Tidur pada Lansia.....	30
K. Patofisiologi Gangguan Tidur pada Lansia	34
L. Manifestasi Klinis Gangguan Tidur Pada Lansia.....	38
M. Asuhan Keperawatan pada Lansia dengan Gangguan Tidur.....	42
N. Evidence Based Nursing pada Gangguan Tidur Lansia...	48
O. Ringkasan Bab.....	52
P. Glosarium.....	56
Q. Daftar Pustaka.....	61

CHAPTER 2 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI GANGGUAN TIDUR PADA LANSIA..... 64

Resa Livia Nica, S.Kep., Ns., M.Kes.....	64
A. Pendahuluan.....	64
B. Konsep Dasar Gangguan Tidur Pada Lansia.....	66
C. Jenis-Jenis Gangguan Tidur Pada Lansia	68
D. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Gangguan Tidur Pada Lansia.....	72
E. Simpulan	78
F. Referensi.....	79

CHAPTER 3 INTERVENSI NONFARMAKOLOGIS DALAM MENINGKATKAN KUALITAS TIDUR PADA LANSIA 82

Ns. Nunung Nurhayati, S.Kep., M.Kep.	82
A. Gangguan Tidur pada Lansia	82
B. Intervensi Nonfarmakologis pada Lansia	91
C. Evaluasi dan Outcome	108
D. Implikasi Praktik Keperawatan dan Pendekatan Interdisiplin	121
E. Kesimpulan.....	125
F. Referensi:.....	126

PROFIL PENULIS 136

CHAPTER 1

KONSEP DASAR PROSES MENUA DAN PERUBAHAN POLA TIDUR LANSIA

Dr. Susi Milwati, S.Kp., M.Pd.

A. Pendahuluan

Peningkatan angka harapan hidup merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan kesehatan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya jumlah populasi lanjut usia (lansia) setiap tahunnya. Menurut Badan Pusat Statistik, proporsi penduduk lansia di Indonesia terus mengalami peningkatan dan diperkirakan akan mencapai lebih dari 19% pada tahun 2045. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Indonesia sedang memasuki era aging population yang membutuhkan kesiapan sistem pelayanan kesehatan, terutama pelayanan keperawatan gerontik (Badan Pusat Statistik, 2024).

Lansia merupakan kelompok usia yang mengalami perubahan biologis, psikologis, sosial, dan spiritual akibat proses menua yang berlangsung secara bertahap dan progresif. Salah satu masalah kesehatan yang sering dialami lansia adalah gangguan pola tidur. Gangguan tidur pada lansia sering dianggap sebagai bagian normal dari proses menua, padahal kondisi tersebut dapat berdampak terhadap kesehatan fisik, mental, dan kualitas hidup lansia secara keseluruhan. Lansia yang mengalami gangguan tidur cenderung mengalami kelelahan, gangguan konsentrasi, perubahan suasana hati, hingga peningkatan risiko jatuh dan penyakit kronis (Potter et al., 2023).

Pemahaman mengenai konsep dasar lansia, proses menua, penggolongan usia lansia, teori tidur, perubahan pola tidur, serta asuhan keperawatan pada lansia dengan gangguan tidur sangat penting bagi mahasiswa dan tenaga kesehatan. Pemahaman tersebut menjadi dasar dalam memberikan pelayanan keperawatan yang komprehensif, holistik, dan berbasis evidence-based nursing pada lansia (Touhy & Jett, 2022).

B. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar lansia dan proses menua, menjelaskan penggolongan usia lansia, memahami teori tidur dan perubahan pola tidur pada lansia, mengidentifikasi faktor penyebab gangguan tidur pada lansia, serta memahami konsep asuhan keperawatan gerontik pada lansia dengan gangguan tidur berdasarkan pendekatan SDKI, SIKI, dan SLKI.

C. Konsep Lansia

Lanjut usia (lansia) merupakan tahap akhir dalam siklus kehidupan manusia yang ditandai dengan terjadinya proses penuaan secara alami, progresif, dan berkelanjutan. Penuaan merupakan suatu proses biologis yang tidak dapat dihindari oleh setiap individu dan berlangsung sejak seseorang lahir hingga memasuki usia lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Sementara itu, World Health Organization (WHO) mendefinisikan lansia sebagai kelompok individu yang mengalami perubahan fisiologis, psikologis, dan sosial akibat bertambahnya usia sehingga

memerlukan perhatian khusus dalam aspek kesehatan dan kesejahteraan (World Health Organization [WHO], 2022).

Peningkatan jumlah lansia terjadi secara global maupun nasional seiring meningkatnya angka harapan hidup dan kemajuan pelayanan kesehatan. Kondisi ini menyebabkan terjadinya perubahan struktur penduduk yang dikenal sebagai aging population. Indonesia termasuk negara yang mengalami peningkatan populasi lansia secara signifikan. Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia terus meningkat setiap tahun dan diperkirakan akan mencapai lebih dari 48 juta jiwa pada tahun 2035. Peningkatan populasi lansia memberikan dampak terhadap meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatan gerontik yang komprehensif dan berkesinambungan (Badan Pusat Statistik, 2024).

Lansia merupakan kelompok usia yang memiliki karakteristik khusus akibat proses menua yang memengaruhi hampir seluruh sistem tubuh. Seiring bertambahnya usia, tubuh mengalami penurunan kemampuan dalam memperbaiki kerusakan jaringan, mempertahankan homeostasis, dan beradaptasi terhadap stres lingkungan. Penurunan fungsi fisiologis tersebut menyebabkan lansia lebih rentan mengalami berbagai penyakit degeneratif seperti hipertensi, diabetes melitus, penyakit jantung koroner, osteoarthritis, osteoporosis, stroke, serta gangguan tidur. Selain itu, sistem imun pada lansia juga mengalami penurunan sehingga meningkatkan risiko infeksi dan memperlambat proses penyembuhan penyakit (Miller, 2021).

Perubahan yang terjadi pada lansia tidak hanya meliputi aspek biologis, tetapi juga aspek psikologis dan sosial. Pada aspek psikologis, lansia sering mengalami penurunan fungsi kognitif seperti daya ingat, konsentrasi,

dan kemampuan berpikir. Lansia juga rentan mengalami perubahan emosional berupa kecemasan, kesepian, stres, dan depresi akibat perubahan kondisi kesehatan, kehilangan pasangan hidup, maupun berkurangnya interaksi sosial. Sementara itu, pada aspek sosial, lansia sering mengalami perubahan peran dalam keluarga dan masyarakat akibat pensiun, keterbatasan fisik, serta ketergantungan terhadap orang lain dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kualitas hidup dan kesejahteraan lansia secara keseluruhan (Stanley & Beare, 2022).

Dalam keperawatan gerontik, lansia dipandang sebagai individu yang unik dan memiliki kebutuhan khusus sehingga memerlukan pendekatan pelayanan kesehatan yang holistik dan berpusat pada pasien. Pelayanan kesehatan pada lansia tidak hanya berfokus pada pengobatan penyakit, tetapi juga pada upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif untuk mempertahankan kemandirian serta meningkatkan kualitas hidup lansia. Pendekatan holistik dalam keperawatan gerontik mencakup pemenuhan kebutuhan biologis, psikologis, sosial, spiritual, dan lingkungan sehingga lansia dapat menjalani proses menua secara sehat dan bermakna (Touhy & Jett, 2022).

Konsep *healthy aging* atau penuaan sehat menjadi salah satu fokus utama dalam pelayanan gerontik modern. *Healthy aging* merupakan proses mempertahankan kemampuan fungsional agar lansia tetap sehat, aktif, mandiri, dan produktif meskipun mengalami proses penuaan. Konsep ini menekankan pentingnya gaya hidup sehat, aktivitas fisik teratur, nutrisi seimbang, dukungan keluarga, serta pengelolaan penyakit kronis untuk mempertahankan kualitas hidup lansia. Lansia yang mampu beradaptasi secara positif

terhadap perubahan akibat proses menua cenderung memiliki kesejahteraan fisik dan psikologis yang lebih baik dibandingkan lansia yang mengalami hambatan adaptasi (WHO, 2022).

Perawat memiliki peran penting dalam mendukung proses penuaan sehat melalui pemberian asuhan keperawatan yang komprehensif dan evidence-based. Peran perawat meliputi pemberian edukasi kesehatan, pemantauan kondisi fisik dan psikologis lansia, pencegahan komplikasi penyakit, dukungan emosional, serta pemberdayaan keluarga dalam merawat lansia. Dengan pendekatan keperawatan gerontik yang tepat, diharapkan lansia mampu mencapai kualitas hidup yang optimal, mempertahankan kemandirian, dan menjalani masa tua dengan sehat, aman, dan bermartabat (Hasifah, 2024).

D. Penggolongan Usia Lansia

Penggolongan usia lansia merupakan salah satu konsep penting dalam keperawatan gerontik karena setiap kelompok usia lanjut memiliki karakteristik, tingkat ketergantungan, kondisi kesehatan, dan kebutuhan pelayanan yang berbeda. Penggolongan ini membantu tenaga kesehatan dalam menentukan pendekatan asuhan keperawatan yang tepat sesuai dengan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan tingkat kemandirian lansia. Semakin bertambah usia seseorang, maka kemampuan tubuh dalam mempertahankan fungsi fisiologis akan semakin menurun sehingga risiko terjadinya penyakit degeneratif, gangguan mobilitas, dan ketergantungan terhadap orang lain menjadi lebih tinggi (Touhy & Jett, 2022).

Secara umum, penggolongan lansia dapat dibedakan berdasarkan usia kronologis, kondisi kesehatan, serta

kemampuan fungsional individu. World Health Organization (WHO) membagi kelompok usia lanjut menjadi beberapa kategori. Kelompok middle age atau usia pertengahan berada pada rentang usia 45–59 tahun. Pada tahap ini mulai terjadi perubahan fisiologis awal akibat proses penuaan, meskipun individu masih tergolong produktif dan mampu menjalankan aktivitas sehari-hari secara mandiri. Kelompok elderly berada pada rentang usia 60–74 tahun. Lansia pada tahap ini mulai mengalami penurunan fungsi organ secara bertahap seperti penurunan kekuatan otot, perubahan metabolisme, serta peningkatan risiko penyakit kronis. Namun, sebagian besar lansia pada kelompok ini masih mampu mempertahankan kemandirian dalam aktivitas sehari-hari (World Health Organization [WHO], 2022).

Kelompok old age berada pada rentang usia 75–89 tahun. Pada tahap ini, proses degeneratif tubuh semakin jelas terlihat dengan meningkatnya keterbatasan fisik, gangguan sensorik, penurunan fungsi kognitif, serta meningkatnya ketergantungan terhadap keluarga atau tenaga kesehatan. Lansia pada kelompok ini lebih rentan mengalami gangguan keseimbangan, risiko jatuh, gangguan tidur, dan penyakit kronis multipel. Sementara itu, kelompok very old age merupakan lansia usia ≥ 90 tahun yang umumnya mengalami penurunan fungsi tubuh lebih kompleks sehingga membutuhkan bantuan dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari dan pelayanan kesehatan jangka panjang (Mauk, 2023).

Selain penggolongan menurut WHO, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga membagi lansia menjadi tiga kelompok utama, yaitu pra lansia, lansia, dan lansia risiko tinggi. Pra lansia merupakan kelompok usia 45–59 tahun yang mulai mengalami proses penuaan namun masih

produktif secara sosial maupun ekonomi. Kelompok lansia adalah individu berusia ≥ 60 tahun, sedangkan lansia risiko tinggi merupakan lansia usia ≥ 70 tahun atau lansia dengan masalah kesehatan tertentu yang menyebabkan peningkatan ketergantungan terhadap orang lain. Lansia risiko tinggi membutuhkan perhatian khusus karena memiliki risiko lebih besar mengalami komplikasi kesehatan, penurunan fungsi tubuh, dan keterbatasan aktivitas sehari-hari (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023).

Penggolongan lansia juga dapat dilihat berdasarkan tingkat kemandirian fungsional. Lansia mandiri merupakan lansia yang masih mampu memenuhi kebutuhan aktivitas sehari-hari seperti makan, mandi, berpakaian, dan berjalan tanpa bantuan orang lain. Lansia semi mandiri memerlukan bantuan sebagian dalam melakukan aktivitas tertentu akibat penurunan kondisi fisik atau kognitif. Sementara itu, lansia tidak mandiri merupakan lansia yang sangat bergantung pada bantuan orang lain dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Penilaian tingkat kemandirian lansia biasanya dilakukan menggunakan instrumen Activity of Daily Living (ADL) untuk menentukan kebutuhan asuhan keperawatan dan tingkat dukungan keluarga yang diperlukan (Miller, 2021).

Dalam konsep gerontik modern, penggolongan lansia tidak hanya didasarkan pada usia kronologis, tetapi juga mempertimbangkan usia biologis, psikologis, dan sosial individu. Dua lansia dengan usia yang sama dapat memiliki kondisi kesehatan dan tingkat kemandirian yang berbeda tergantung gaya hidup, status nutrisi, aktivitas fisik, dukungan sosial, dan pengendalian penyakit kronis yang dimiliki. Oleh karena itu, pendekatan pelayanan kesehatan pada lansia harus bersifat individual dan holistik agar

kebutuhan kesehatan lansia dapat terpenuhi secara optimal (Stanley & Beare, 2022).

Tabel 1.1 Penggolongan Usia Lansia

Kelompok Usia	Rentang Usia	Karakteristik Umum
Middle Age / Pra Lansia	45–59 tahun	Mulai terjadi perubahan fisiologis awal, masih produktif dan mandiri
Elderly / Lansia Awal	60–74 tahun	Penurunan fungsi tubuh ringan–sedang, mulai muncul penyakit kronis
Old Age / Lansia Lanjut	75–89 tahun	Penurunan fisik dan kognitif lebih nyata, risiko ketergantungan meningkat
Very Old Age / Lansia Sangat Tua	≥90 tahun	Penurunan fungsi tubuh kompleks, membutuhkan bantuan dalam aktivitas sehari-hari

Sumber: World Health Organization (2022)

Tabel 1.2 Penggolongan Lansia Menurut Kementerian Kesehatan RI

Kategori	Rentang Usia	Keterangan
Pra Lansia	45–59 tahun	Mulai mengalami proses penuaan
Lansia	≥60 tahun	Mengalami perubahan fisik, psikologis, dan sosial akibat proses menua
Lansia Tinggi	Risiko ≥70 tahun atau memiliki penyakit tertentu	Memiliki risiko tinggi mengalami ketergantungan dan komplikasi kesehatan

Sumber: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2023)

E. Konsep Dasar Proses Menua

Proses menua (aging process) merupakan suatu proses biologis yang berlangsung secara alami, progresif, dan berkesinambungan sepanjang kehidupan manusia. Penuaan tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan berlangsung perlahan sejak seseorang memasuki masa dewasa hingga lanjut usia. Proses ini ditandai dengan menurunnya kemampuan sel, jaringan, dan organ tubuh dalam mempertahankan fungsi fisiologis secara optimal. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh dalam memperbaiki kerusakan jaringan dan mempertahankan keseimbangan internal tubuh atau homeostasis mengalami penurunan sehingga lansia menjadi lebih rentan terhadap penyakit degeneratif dan gangguan kesehatan lainnya (Miller, 2021).

Secara biologis, proses menua terjadi akibat akumulasi kerusakan sel tubuh yang berlangsung dalam waktu lama. Kerusakan tersebut dipengaruhi oleh faktor genetik, metabolisme, radikal bebas, gaya hidup, lingkungan, serta penyakit kronis yang dialami individu. Sel tubuh yang mengalami penuaan akan mengalami penurunan kemampuan regenerasi sehingga fungsi organ tubuh menjadi tidak optimal. Akibatnya, lansia mengalami penurunan daya tahan tubuh, penurunan kemampuan adaptasi terhadap stres, dan peningkatan risiko penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes melitus, penyakit jantung, osteoporosis, serta gangguan tidur (Touhy & Jett, 2022).

Proses menua menyebabkan perubahan fisiologis hampir pada seluruh sistem tubuh. Pada sistem kardiovaskular terjadi penurunan elastisitas pembuluh darah, penebalan dinding arteri, dan penurunan kemampuan kontraksi jantung. Kondisi ini menyebabkan lansia lebih rentan mengalami hipertensi, penurunan perfusi jaringan,

dan gangguan sirkulasi darah. Selain itu, denyut jantung menjadi kurang responsif terhadap aktivitas fisik sehingga lansia lebih mudah mengalami kelelahan saat melakukan aktivitas sehari-hari (Potter et al., 2023).

Pada sistem respirasi, proses menua menyebabkan penurunan elastisitas paru-paru dan kekuatan otot pernapasan sehingga kapasitas paru menurun. Lansia menjadi lebih mudah mengalami sesak napas dan penurunan toleransi aktivitas. Refleks batuk yang menurun juga meningkatkan risiko infeksi saluran pernapasan pada lansia (Stanley & Beare, 2022).

Perubahan pada sistem muskuloskeletal ditandai dengan penurunan massa otot, penurunan kepadatan tulang, dan berkurangnya fleksibilitas sendi. Kondisi tersebut menyebabkan lansia mudah mengalami kelemahan fisik, nyeri sendi, gangguan mobilitas, dan peningkatan risiko jatuh. Penurunan kekuatan otot juga menyebabkan lansia mengalami keterbatasan dalam melakukan aktivitas sehari-hari sehingga dapat meningkatkan ketergantungan terhadap orang lain (Mauk, 2023).

Pada sistem saraf, proses menua menyebabkan penurunan jumlah neuron dan kecepatan penghantaran impuls saraf. Lansia sering mengalami penurunan daya ingat, lambat dalam merespons stimulus, gangguan konsentrasi, dan perubahan pola tidur. Selain itu, penurunan fungsi sensorik seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, dan perabaan juga sering terjadi pada lansia sehingga dapat memengaruhi kemampuan lansia dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar (Tabloski, 2021).

Perubahan akibat proses menua juga terjadi pada sistem endokrin dan imunologis. Produksi hormon tertentu seperti melatonin, estrogen, testosteron, dan hormon

pertumbuhan mengalami penurunan sehingga memengaruhi metabolisme tubuh, ritme sirkadian, kualitas tidur, dan keseimbangan energi. Penurunan sistem imun menyebabkan tubuh lansia lebih rentan terhadap infeksi dan memperlambat proses penyembuhan luka dibandingkan individu usia muda (Miller, 2021).

Selain perubahan biologis, proses menua juga memengaruhi kondisi psikologis lansia. Lansia sering mengalami perubahan emosional akibat kehilangan pasangan hidup, pensiun, penurunan kondisi kesehatan, serta berkurangnya interaksi sosial. Kondisi tersebut dapat menyebabkan kecemasan, kesepian, stres, bahkan depresi apabila lansia tidak mampu beradaptasi dengan baik terhadap perubahan yang terjadi. Dukungan keluarga dan lingkungan sosial sangat penting dalam membantu lansia mempertahankan kesehatan mental dan kualitas hidupnya (Azhari et al., 2022).

Pada aspek sosial, lansia sering mengalami perubahan peran dalam keluarga dan masyarakat. Lansia yang sebelumnya aktif bekerja dan memiliki peran sosial penting dapat mengalami perasaan tidak berguna setelah memasuki masa pensiun. Berkurangnya interaksi sosial dan meningkatnya ketergantungan terhadap keluarga juga dapat memengaruhi harga diri dan kesejahteraan psikososial lansia. Oleh karena itu, lansia membutuhkan dukungan sosial yang baik agar tetap merasa dihargai dan memiliki makna dalam kehidupannya (Hasifah, 2024).

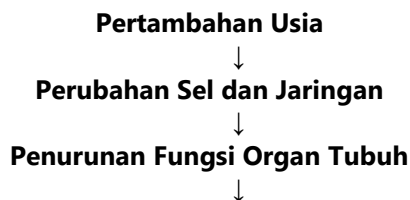
Beberapa teori telah dikembangkan untuk menjelaskan proses menua. Teori biologis menyatakan bahwa penuaan terjadi akibat kerusakan sel secara bertahap yang dipengaruhi faktor genetik dan lingkungan. Salah satu teori biologis yang banyak digunakan adalah teori radikal bebas

yang menjelaskan bahwa akumulasi radikal bebas dapat merusak sel tubuh dan mempercepat proses penuaan. Selain itu, teori wear and tear menjelaskan bahwa organ tubuh mengalami kerusakan akibat penggunaan terus-menerus selama kehidupan manusia sehingga kemampuan tubuh dalam memperbaiki kerusakan jaringan semakin menurun seiring bertambahnya usia (Touhy & Jett, 2022).

Teori psikososial menjelaskan bahwa keberhasilan lansia dalam menghadapi proses menua dipengaruhi oleh kemampuan individu dalam beradaptasi terhadap perubahan fisik, psikologis, dan sosial yang terjadi. Lansia yang mampu menerima perubahan secara positif dan mempertahankan hubungan sosial yang baik cenderung memiliki kualitas hidup yang lebih baik dibandingkan lansia yang mengalami kesulitan adaptasi (Stanley & Beare, 2022).

Dalam keperawatan gerontik, proses menua dipandang sebagai kondisi yang membutuhkan pendekatan pelayanan kesehatan secara holistik. Perawat memiliki peran penting dalam membantu lansia mempertahankan kesehatan fisik, psikologis, sosial, dan spiritual melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pendekatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup lansia, mempertahankan kemandirian, serta membantu lansia menjalani proses penuaan secara sehat dan bermartabat (Hasifah, 2024).

Alur Proses Menua



Penurunan Homeostasis dan Sistem Imun



Perubahan Fisik, Psikologis, dan Sosial



Meningkatnya Risiko Penyakit Degeneratif



Penurunan Kemandirian dan Kualitas Hidup Lansia

F. Teori Proses Menua

Proses menua merupakan fenomena kompleks yang melibatkan perubahan biologis, psikologis, sosial, dan spiritual yang berlangsung secara bertahap sepanjang kehidupan manusia. Hingga saat ini, belum terdapat satu teori tunggal yang mampu menjelaskan secara menyeluruh mengenai proses penuaan. Oleh karena itu, berbagai teori dikembangkan untuk membantu memahami penyebab, mekanisme, dan dampak proses menua terhadap individu lanjut usia. Teori-teori tersebut menjadi dasar penting dalam praktik keperawatan gerontik karena membantu tenaga kesehatan memahami perubahan yang dialami lansia serta menentukan pendekatan asuhan keperawatan yang tepat (Touhy & Jett, 2022).

Secara umum, teori proses menua dibagi menjadi tiga kelompok besar, yaitu teori biologis, teori psikologis, dan teori sosial. Ketiga kelompok teori tersebut saling berkaitan dalam menjelaskan perubahan yang terjadi pada lansia. Teori biologis lebih menekankan pada perubahan struktur dan fungsi tubuh, sedangkan teori psikologis dan sosial menjelaskan kemampuan lansia dalam beradaptasi terhadap perubahan kehidupan yang dialami selama proses penuaan (Mauk, 2023).

1. Teori Biologis

Teori biologis menjelaskan bahwa proses menua terjadi akibat perubahan dan kerusakan sel tubuh secara

bertahap yang dipengaruhi oleh faktor genetik, metabolisme, gaya hidup, serta lingkungan. Penuaan biologis menyebabkan penurunan kemampuan tubuh dalam memperbaiki kerusakan jaringan dan mempertahankan fungsi organ secara optimal. Akibatnya, lansia menjadi lebih rentan terhadap penyakit degeneratif, gangguan mobilitas, penurunan daya tahan tubuh, dan gangguan fungsi organ lainnya (Miller, 2021).

a. Teori Radikal Bebas (Free Radical Theory)

Teori radikal bebas merupakan salah satu teori biologis yang paling banyak digunakan dalam menjelaskan proses menua. Teori ini menyatakan bahwa selama proses metabolisme tubuh terbentuk molekul tidak stabil yang disebut radikal bebas. Radikal bebas memiliki elektron tidak berpasangan sehingga sangat reaktif dan dapat merusak membran sel, protein, DNA, serta jaringan tubuh lainnya. Kerusakan sel yang berlangsung terus-menerus menyebabkan penurunan fungsi organ dan mempercepat proses penuaan (Potter et al., 2023).

Akumulasi radikal bebas dalam tubuh dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti polusi, radiasi, merokok, stres, makanan tidak sehat, dan penyakit kronis. Tubuh sebenarnya memiliki sistem antioksidan alami untuk menetralkan radikal bebas, namun kemampuan tersebut menurun seiring bertambahnya usia. Oleh karena itu, lansia lebih rentan mengalami kerusakan sel dan penyakit degeneratif seperti hipertensi, diabetes melitus, penyakit jantung, kanker, dan gangguan neurodegeneratif (Tabloski, 2021).

Teori ini menjadi dasar penting dalam upaya promotif dan preventif pada lansia, terutama melalui penerapan

pola hidup sehat, konsumsi makanan kaya antioksidan, aktivitas fisik teratur, serta pengendalian faktor risiko penyakit kronis. Dalam keperawatan gerontik, pemahaman mengenai teori radikal bebas membantu perawat memberikan edukasi kesehatan untuk memperlambat proses penuaan dan meningkatkan kualitas hidup lansia (Touhy & Jett, 2022).

b. Teori *Wear and Tear*

Teori wear and tear atau teori aus dan rusak menjelaskan bahwa organ tubuh mengalami kerusakan akibat penggunaan terus-menerus selama kehidupan manusia. Sama seperti mesin yang digunakan dalam jangka waktu lama, tubuh manusia juga mengalami penurunan fungsi akibat akumulasi stres dan kerusakan jaringan yang berlangsung bertahun-tahun. Semakin bertambah usia, kemampuan tubuh memperbaiki kerusakan jaringan menjadi semakin menurun sehingga fungsi organ tidak lagi optimal (Stanley & Beare, 2022).

Kerusakan akibat proses wear and tear dapat terlihat pada berbagai sistem tubuh, seperti penurunan elastisitas pembuluh darah, penurunan massa otot, degenerasi sendi, dan penurunan fungsi paru-paru. Kondisi tersebut menyebabkan lansia lebih mudah mengalami kelelahan, gangguan mobilitas, nyeri sendi, serta peningkatan risiko jatuh dan ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari (Mauk, 2023).

Meskipun proses wear and tear tidak dapat dihindari sepenuhnya, kerusakan tubuh dapat diperlambat melalui gaya hidup sehat, aktivitas fisik rutin, nutrisi seimbang, serta pengendalian penyakit kronis. Oleh karena itu, perawat memiliki peran penting dalam

memberikan edukasi dan motivasi kepada lansia untuk mempertahankan fungsi tubuh secara optimal (Hasifah, 2024).

c. Teori Genetik

Teori genetik menyatakan bahwa proses menua telah diprogram secara biologis dalam tubuh manusia melalui kode genetik tertentu. Setiap individu memiliki batas usia biologis yang dipengaruhi oleh faktor keturunan dan genetik. Seiring bertambahnya usia, sel tubuh mengalami penurunan kemampuan membelah dan memperbaiki diri sehingga fungsi tubuh menurun secara bertahap (Miller, 2021).

Teori ini menjelaskan bahwa beberapa penyakit degeneratif yang sering dialami lansia, seperti hipertensi, diabetes melitus, dan penyakit Alzheimer, memiliki hubungan dengan faktor genetik. Namun demikian, faktor lingkungan dan gaya hidup juga berperan penting dalam menentukan kualitas proses penuaan seseorang (Tabloski, 2021).

d. Teori Immunologis

Teori imunologis menjelaskan bahwa proses menua terjadi akibat penurunan fungsi sistem imun tubuh. Seiring bertambahnya usia, kemampuan sistem imun dalam melawan infeksi dan memperbaiki kerusakan jaringan mengalami penurunan. Kondisi ini menyebabkan lansia lebih rentan terhadap infeksi, penyakit kronis, dan proses penyembuhan luka yang lebih lambat dibandingkan usia muda (Potter et al., 2023).

Penurunan sistem imun juga menyebabkan tubuh mengalami inflamasi kronis tingkat rendah yang berkontribusi terhadap munculnya penyakit

degeneratif pada lansia. Oleh karena itu, lansia membutuhkan pemantauan kesehatan yang lebih intensif untuk mencegah komplikasi penyakit (Touhy & Jett, 2022).

2. Teori Psikologis

Teori psikologis menjelaskan bahwa proses menua tidak hanya dipengaruhi oleh perubahan biologis, tetapi juga kemampuan individu dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan psikologis yang terjadi selama masa lanjut usia. Lansia yang mampu beradaptasi secara positif terhadap perubahan fisik, emosional, dan sosial cenderung memiliki kualitas hidup yang lebih baik dibandingkan lansia yang mengalami hambatan adaptasi (Stanley & Beare, 2022).

a. Teori Erikson

Erikson menjelaskan bahwa lansia berada pada tahap perkembangan integrity versus despair. Pada tahap ini, lansia melakukan refleksi terhadap kehidupan yang telah dijalani. Lansia yang mampu menerima pengalaman hidup secara positif akan mencapai integritas diri, merasa puas terhadap kehidupannya, dan lebih siap menghadapi kematian. Sebaliknya, lansia yang merasa gagal atau menyesali kehidupannya cenderung mengalami keputusasaan, depresi, dan kecemasan (Mauk, 2023).

Dalam praktik keperawatan, teori Erikson membantu perawat memahami kondisi emosional lansia dan memberikan dukungan psikologis agar lansia mampu menerima proses menua secara positif.

3. Teori Sosial

Teori sosial menjelaskan hubungan antara lansia dengan lingkungan sosialnya selama proses menua.

Perubahan sosial seperti pensiun, kehilangan pasangan hidup, dan berkurangnya interaksi sosial dapat memengaruhi kesejahteraan psikologis lansia (Touhy & Jett, 2022).

a. Teori Disengagement

Teori disengagement menjelaskan bahwa proses menua menyebabkan lansia secara bertahap menarik diri dari kehidupan sosial dan aktivitas masyarakat. Kondisi ini dianggap sebagai proses alami karena lansia mengalami penurunan kemampuan fisik dan energi sehingga interaksi sosial berkurang (Miller, 2021).

Namun, teori ini mendapat kritik karena tidak semua lansia ingin menarik diri dari lingkungan sosial. Banyak lansia tetap ingin aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat.

b. Teori Activity

Teori activity menjelaskan bahwa lansia yang tetap aktif secara fisik, sosial, dan mental cenderung memiliki kualitas hidup lebih baik dibandingkan lansia yang pasif. Aktivitas sosial dan fisik membantu lansia mempertahankan kesehatan fisik, fungsi kognitif, serta kesejahteraan emosional (Potter et al., 2023).

Teori ini menjadi dasar penting dalam program healthy aging dan active aging yang mendorong lansia untuk tetap produktif, aktif berinteraksi, dan terlibat dalam kegiatan sosial.

4. Implikasi Teori Proses Menua dalam Keperawatan

Pemahaman mengenai teori proses menua sangat penting dalam praktik keperawatan gerontik karena membantu perawat memahami perubahan yang terjadi pada lansia secara menyeluruh. Melalui pemahaman teori

biologis, psikologis, dan sosial, perawat dapat memberikan asuhan keperawatan yang holistik dan individual sesuai kebutuhan lansia (Hasifah, 2024).

Perawat berperan dalam membantu lansia mempertahankan kesehatan fisik, meningkatkan kemampuan adaptasi psikologis, serta mempertahankan interaksi sosial yang positif. Intervensi keperawatan seperti edukasi kesehatan, promosi gaya hidup sehat, dukungan emosional, terapi aktivitas, dan pemberdayaan keluarga sangat penting dalam membantu lansia mencapai kualitas hidup yang optimal (Touhy & Jett, 2022).

Alur Konsep Teori Proses Menua

Faktor Genetik + Lingkungan + Gaya Hidup



Kerusakan Sel Tubuh



Penurunan Fungsi Organ Tubuh



Perubahan Fisik, Psikologis, dan Sosial



Penurunan Kemandirian Lansia



Risiko Penyakit Degeneratif



Kebutuhan Asuhan Keperawatan Gerontik

G. Konsep Dasar Tidur

Tidur merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang memiliki peranan penting dalam mempertahankan kesehatan fisik, mental, emosional, dan kualitas hidup individu. Tidur adalah keadaan fisiologis yang bersifat reversible atau dapat kembali sadar, ditandai dengan menurunnya tingkat kesadaran, aktivitas motorik, respons terhadap rangsangan lingkungan, serta perubahan fungsi tubuh tertentu. Meskipun seseorang berada dalam kondisi tidak sadar selama tidur, otak tetap menjalankan berbagai fungsi penting yang berhubungan dengan pemulihan tubuh, pengaturan metabolisme, keseimbangan hormon, serta proses penyimpanan memori dan pembelajaran (Potter et al., 2023).

Tidur merupakan proses biologis yang sangat penting bagi tubuh karena selama tidur terjadi proses restorasi fisik dan psikologis. Pada saat tidur, tubuh melakukan perbaikan jaringan, pemulihan energi, sintesis protein, regulasi suhu tubuh, serta penguatan sistem imun. Selain itu, tidur juga berfungsi menjaga keseimbangan emosional dan fungsi kognitif seseorang. Individu yang mengalami gangguan tidur dalam waktu lama berisiko mengalami penurunan konsentrasi, gangguan memori, mudah lelah, perubahan suasana hati, hingga peningkatan risiko penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes melitus, obesitas, dan gangguan kardiovaskular (Miller, 2021).

Secara fisiologis, tidur diatur oleh sistem neurologis yang melibatkan batang otak, hipotalamus, dan neurotransmitter tertentu. Proses tidur dipengaruhi oleh ritme sirkadian, yaitu mekanisme biologis tubuh yang mengatur siklus tidur dan bangun selama 24 jam. Ritme sirkadian dipengaruhi oleh cahaya, aktivitas fisik, suhu

lingkungan, serta hormon melatonin yang diproduksi oleh kelenjar pineal. Pada malam hari, produksi melatonin meningkat sehingga tubuh merasa mengantuk, sedangkan pada siang hari produksi melatonin menurun sehingga individu menjadi lebih terjaga dan aktif (Tabloski, 2021).

Tidur terdiri atas dua fase utama, yaitu Non-Rapid Eye Movement (NREM) dan Rapid Eye Movement (REM). Kedua fase tersebut berlangsung secara bergantian membentuk satu siklus tidur yang normal. Dalam satu malam, seseorang umumnya mengalami empat hingga enam siklus tidur dengan durasi sekitar 90–110 menit setiap siklusnya (Potter et al., 2023).

1. Fase Non-Rapid Eye Movement (NREM)

Fase NREM merupakan fase tidur yang paling banyak dialami selama tidur malam dan berfungsi dalam pemulihan fisik tubuh. Fase ini dibagi menjadi beberapa tahap, mulai dari tidur ringan hingga tidur dalam.

a. Tahap N1 (Tidur Ringan)

Tahap N1 merupakan tahap awal seseorang mulai tertidur. Pada tahap ini, individu masih mudah terbangun oleh suara atau rangsangan ringan. Aktivitas otot mulai menurun, mata bergerak lambat, dan denyut jantung mulai melambat. Tahap ini biasanya berlangsung singkat, sekitar beberapa menit (Mauk, 2023).

b. Tahap N2

Tahap N2 merupakan fase tidur yang lebih dalam dibandingkan tahap N1. Pada tahap ini, suhu tubuh menurun, denyut jantung melambat, dan aktivitas otak mulai menurun. Individu menjadi lebih sulit dibangunkan dibandingkan tahap sebelumnya.

Sebagian besar waktu tidur seseorang berada pada tahap ini (Potter et al., 2023).

c. Tahap N3 (Deep Sleep)

Tahap N3 disebut juga tidur dalam atau slow wave sleep. Pada tahap ini tubuh berada dalam kondisi relaksasi maksimal dan sangat sulit dibangunkan. Tahap ini sangat penting untuk pemulihan fisik, perbaikan jaringan tubuh, pertumbuhan sel, serta penguatan sistem imun. Pada lansia, fase tidur dalam mengalami penurunan sehingga kualitas tidur menjadi lebih rendah dan tidur lebih mudah terganggu (Tabloski, 2021).

2. Fase Rapid Eye Movement (REM)

Fase REM merupakan fase tidur yang ditandai dengan gerakan mata cepat, peningkatan aktivitas otak, mimpi, serta peningkatan denyut jantung dan pernapasan. Pada fase ini, otak aktif memproses memori, emosi, dan pembelajaran. REM memiliki peran penting dalam fungsi kognitif dan kesehatan psikologis seseorang (Miller, 2021).

Meskipun aktivitas otak meningkat pada fase REM, otot tubuh mengalami relaksasi hampir total sehingga tubuh tidak bergerak aktif saat bermimpi. Gangguan pada fase REM dapat menyebabkan gangguan konsentrasi, perubahan suasana hati, dan penurunan fungsi kognitif (Stanley & Beare, 2022).

3. Fungsi Tidur

Tidur memiliki berbagai fungsi penting bagi kesehatan tubuh, baik secara fisik maupun psikologis. Selama tidur, tubuh melakukan pemulihan energi dan memperbaiki sel-sel tubuh yang mengalami kerusakan. Tidur juga membantu menjaga keseimbangan

metabolisme, meningkatkan daya tahan tubuh, serta menjaga fungsi otak dan kesehatan mental (Potter et al., 2023).

Pada aspek psikologis, tidur berperan dalam menjaga stabilitas emosi, meningkatkan kemampuan berpikir, memperbaiki konsentrasi, dan membantu proses pembelajaran. Individu yang mengalami kekurangan tidur cenderung lebih mudah marah, cemas, stres, dan mengalami penurunan produktivitas (Touhy & Jett, 2022).

4. Faktor yang Mempengaruhi Tidur

Kualitas dan pola tidur seseorang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi usia, kondisi kesehatan, stres psikologis, kelelahan, nyeri, dan penggunaan obat-obatan tertentu. Sementara itu, faktor eksternal meliputi lingkungan tidur, pencahayaan, kebisingan, suhu ruangan, pola aktivitas, dan gaya hidup (Mauk, 2023).

Usia merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi pola tidur. Seiring bertambahnya usia, terjadi perubahan fisiologis pada sistem saraf dan produksi hormon melatonin yang menyebabkan lansia lebih sulit memulai tidur, lebih sering terbangun pada malam hari, dan mengalami penurunan kualitas tidur (Tabloski, 2021).

Selain itu, penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes melitus, nyeri sendi, penyakit jantung, dan gangguan pernapasan juga dapat mengganggu pola tidur lansia. Faktor psikologis seperti kecemasan, kesepian, dan depresi turut berperan dalam menyebabkan gangguan tidur pada lansia (Stanley & Beare, 2022).

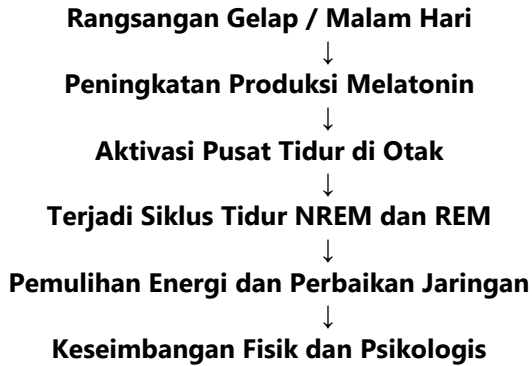
5. Kebutuhan Tidur pada Lansia

Kebutuhan tidur setiap individu berbeda tergantung usia dan kondisi kesehatan. Pada lansia, kebutuhan tidur umumnya berkisar antara 5–7 jam per hari. Namun, kualitas tidur lebih penting dibandingkan durasi tidur itu sendiri. Lansia yang memiliki kualitas tidur baik akan merasa segar saat bangun tidur, memiliki energi yang cukup, serta mampu menjalankan aktivitas sehari-hari dengan optimal (Mauk, 2023).

Perubahan pola tidur pada lansia merupakan bagian dari proses menua yang fisiologis. Lansia cenderung tidur lebih awal dan bangun lebih pagi dibandingkan usia dewasa muda. Selain itu, lansia lebih sering terbangun pada malam hari akibat perubahan fase tidur, peningkatan frekuensi berkemih, nyeri, atau gangguan kesehatan lainnya (Potter et al., 2023).

Gangguan tidur pada lansia tidak boleh dianggap sebagai kondisi normal sepenuhnya karena dapat berdampak terhadap kesehatan fisik dan psikologis. Kurangnya kualitas tidur dapat menyebabkan lansia mudah lelah, mengalami gangguan konsentrasi, penurunan daya tahan tubuh, serta peningkatan risiko jatuh dan depresi. Oleh karena itu, kualitas tidur pada lansia perlu mendapatkan perhatian khusus dalam pelayanan keperawatan gerontik (Touhy & Jett, 2022).

Alur Fisiologi Tidur



H. Perubahan Pola Tidur Pada Lansia

Perubahan pola tidur pada lansia merupakan salah satu perubahan fisiologis yang umum terjadi sebagai bagian dari proses menua. Tidur pada lansia mengalami perubahan baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Lansia cenderung mengalami penurunan durasi tidur malam, peningkatan frekuensi terbangun pada malam hari, serta penurunan kualitas tidur secara keseluruhan. Selain itu, lansia lebih mudah mengalami kantuk pada siang hari akibat tidur malam yang tidak efektif dan tidak mencapai fase tidur dalam secara optimal. Kondisi ini menyebabkan banyak lansia merasa tidak segar ketika bangun tidur dan mengalami kelelahan saat menjalankan aktivitas sehari-hari (World Health Organization [WHO], 2022).

Perubahan pola tidur pada lansia terjadi akibat perubahan fisiologis pada sistem saraf pusat dan ritme sirkadian tubuh. Ritme sirkadian merupakan mekanisme biologis yang mengatur siklus tidur dan bangun selama 24 jam. Pada lansia, ritme sirkadian mengalami perubahan sehingga waktu tidur menjadi lebih maju dibandingkan usia dewasa muda. Lansia cenderung tidur lebih awal pada malam

hari dan bangun lebih dini pada pagi hari. Perubahan ini dikenal sebagai *advanced sleep phase syndrome* yang sering ditemukan pada kelompok lanjut usia (Tabloski, 2021).

Salah satu faktor utama yang menyebabkan perubahan pola tidur pada lansia adalah penurunan produksi hormon melatonin. Melatonin merupakan hormon yang diproduksi oleh kelenjar pineal dan berfungsi mengatur siklus tidur serta rasa kantuk. Pada lansia, produksi melatonin mengalami penurunan sehingga menyebabkan lansia lebih sulit memulai tidur dan lebih mudah terbangun pada malam hari. Penurunan melatonin juga menyebabkan kualitas tidur menjadi lebih ringan dan tidak nyenyak (Potter et al., 2023).

Selain perubahan hormonal, lansia juga mengalami perubahan struktur tidur. Pada usia lanjut terjadi penurunan fase tidur dalam atau *deep sleep* (NREM tahap N3) dan peningkatan fase tidur ringan. Akibatnya, lansia menjadi lebih sensitif terhadap suara, cahaya, dan gangguan lingkungan lainnya selama tidur. Lansia juga lebih sering mengalami fragmentasi tidur, yaitu kondisi tidur yang sering terputus akibat sering terbangun pada malam hari (Mauk, 2023).

Perubahan pola tidur pada lansia dipengaruhi oleh berbagai faktor fisik, psikologis, sosial, dan lingkungan. Faktor fisik yang sering memengaruhi tidur lansia adalah adanya penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes melitus, osteoarthritis, penyakit jantung, gangguan pernapasan, dan gangguan neurologis. Nyeri sendi, sesak napas, batuk kronis, dan peningkatan frekuensi berkemih pada malam hari (*nokturia*) menjadi penyebab utama gangguan tidur pada lansia. Kondisi tersebut menyebabkan lansia sering terbangun dan kesulitan untuk tidur kembali (Hutabarat et al., 2024).

Penggunaan obat-obatan tertentu juga dapat memengaruhi kualitas tidur lansia. Beberapa jenis obat seperti diuretik, antihipertensi, bronkodilator, dan antidepresan dapat menyebabkan efek samping berupa insomnia, sering berkemih pada malam hari, atau gangguan pola tidur lainnya. Oleh karena itu, pengkajian penggunaan obat sangat penting dilakukan dalam asuhan keperawatan pada lansia dengan gangguan tidur (Touhy & Jett, 2022).

Selain faktor fisik, perubahan pola tidur pada lansia juga dipengaruhi oleh faktor psikologis. Lansia yang mengalami kecemasan, stres, kesepian, depresi, atau kehilangan pasangan hidup sering mengalami kesulitan tidur. Kondisi psikologis yang tidak stabil menyebabkan aktivitas otak meningkat sehingga lansia sulit merasa rileks saat akan tidur. Gangguan emosional yang berlangsung lama dapat memperburuk kualitas tidur dan meningkatkan risiko insomnia kronis pada lansia (Stanley & Beare, 2022).

Faktor lingkungan turut berperan dalam perubahan pola tidur lansia. Lingkungan tidur yang bising, pencahayaan yang terlalu terang, suhu ruangan yang tidak nyaman, serta tempat tidur yang kurang nyaman dapat menyebabkan lansia sulit tidur. Lansia juga lebih sensitif terhadap perubahan lingkungan dibandingkan usia muda sehingga membutuhkan suasana tidur yang tenang dan nyaman untuk memperoleh kualitas tidur yang baik (Potter et al., 2023).

Perubahan pola tidur pada lansia dapat menimbulkan berbagai dampak terhadap kesehatan fisik dan psikologis. Lansia yang mengalami gangguan tidur cenderung mengalami kelelahan, penurunan konsentrasi, gangguan memori, perubahan suasana hati, serta penurunan kemampuan melakukan aktivitas sehari-hari. Gangguan tidur juga dapat meningkatkan risiko jatuh akibat menurunnya

keseimbangan dan koordinasi tubuh. Dalam jangka panjang, kualitas tidur yang buruk dapat memperburuk penyakit kronis dan meningkatkan risiko depresi pada lansia (Miller, 2021).

Gangguan tidur yang paling sering dialami lansia adalah insomnia. Insomnia pada lansia ditandai dengan kesulitan memulai tidur, sering terbangun pada malam hari, terbangun terlalu pagi, dan tidak merasa segar setelah tidur. Selain insomnia, lansia juga dapat mengalami sleep apnea, restless leg syndrome, dan gangguan tidur akibat penggunaan obat-obatan tertentu. Kondisi tersebut memerlukan perhatian khusus karena dapat memengaruhi kualitas hidup lansia secara keseluruhan (Tabloski, 2021).

Dalam keperawatan gerontik, perubahan pola tidur pada lansia perlu mendapatkan perhatian secara komprehensif melalui pengkajian pola tidur, identifikasi faktor penyebab, dan pemberian intervensi yang tepat. Perawat memiliki peran penting dalam membantu lansia meningkatkan kualitas tidur melalui edukasi sleep hygiene, menciptakan lingkungan tidur yang nyaman, mengatur jadwal tidur yang teratur, serta memberikan dukungan psikologis kepada lansia dan keluarga. Pendekatan nonfarmakologis seperti relaksasi, terapi musik, aromaterapi, dan latihan fisik ringan terbukti efektif dalam membantu meningkatkan kualitas tidur lansia (Hasifah, 2024).

Alur Perubahan Pola Tidur pada Lansia





I. Patofisiologi Gangguan Tidur pada Lansia

Gangguan tidur pada lansia terjadi akibat perubahan fisiologis pada sistem neurologis dan hormonal. Penurunan fungsi nukleus suprachiasmaticus di hipotalamus menyebabkan gangguan ritme sirkadian sehingga siklus tidur dan bangun menjadi tidak teratur. Selain itu, penurunan produksi hormon melatonin menyebabkan lansia mengalami kesulitan memulai tidur dan mempertahankan tidur dalam waktu lama (Miller, 2021).

Perubahan neurotransmitter seperti serotonin dan dopamin juga memengaruhi kualitas tidur lansia. Gangguan pada neurotransmitter tersebut menyebabkan tidur menjadi lebih dangkal dan mudah terganggu. Selain itu, peningkatan penyakit kronis dan penggunaan obat-obatan tertentu dapat memperburuk gangguan tidur pada lansia (Touhy & Jett, 2022).

J. Perubahan Pola Tidur pada Lansia

Perubahan pola tidur pada lansia merupakan salah satu perubahan fisiologis yang umum terjadi sebagai bagian dari proses menua. Tidur pada lansia mengalami perubahan baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Lansia cenderung mengalami penurunan durasi tidur malam, peningkatan frekuensi terbangun pada malam hari, serta penurunan kualitas tidur secara keseluruhan. Selain itu, lansia lebih mudah mengalami kantuk pada siang hari akibat tidur malam yang tidak efektif dan tidak mencapai fase tidur dalam secara optimal. Kondisi ini menyebabkan banyak lansia merasa tidak segar ketika bangun tidur dan mengalami kelelahan saat menjalankan aktivitas sehari-hari (World Health Organization [WHO], 2022).

Perubahan pola tidur pada lansia terjadi akibat perubahan fisiologis pada sistem saraf pusat dan ritme sirkadian tubuh. Ritme sirkadian merupakan mekanisme biologis yang mengatur siklus tidur dan bangun selama 24 jam. Pada lansia, ritme sirkadian mengalami perubahan sehingga waktu tidur menjadi lebih maju dibandingkan usia dewasa muda. Lansia cenderung tidur lebih awal pada malam hari dan bangun lebih dini pada pagi hari. Perubahan ini dikenal sebagai *advanced sleep phase syndrome* yang sering ditemukan pada kelompok lanjut usia (Tabloski, 2021).

Salah satu faktor utama yang menyebabkan perubahan pola tidur pada lansia adalah penurunan produksi hormon melatonin. Melatonin merupakan hormon yang diproduksi oleh kelenjar pineal dan berfungsi mengatur siklus tidur serta rasa kantuk. Pada lansia, produksi melatonin mengalami penurunan sehingga menyebabkan lansia lebih sulit memulai tidur dan lebih mudah terbangun pada malam hari. Penurunan melatonin juga menyebabkan kualitas tidur menjadi lebih ringan dan tidak nyenyak (Potter et al., 2023).

Selain perubahan hormonal, lansia juga mengalami perubahan struktur tidur. Pada usia lanjut terjadi penurunan fase tidur dalam atau *deep sleep* (NREM tahap N3) dan peningkatan fase tidur ringan. Akibatnya, lansia menjadi lebih sensitif terhadap suara, cahaya, dan gangguan lingkungan lainnya selama tidur. Lansia juga lebih sering mengalami fragmentasi tidur, yaitu kondisi tidur yang sering terputus akibat sering terbangun pada malam hari (Mauk, 2023).

Perubahan pola tidur pada lansia dipengaruhi oleh berbagai faktor fisik, psikologis, sosial, dan lingkungan. Faktor fisik yang sering memengaruhi tidur lansia adalah adanya penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes melitus,

osteoarthritis, penyakit jantung, gangguan pernapasan, dan gangguan neurologis. Nyeri sendi, sesak napas, batuk kronis, dan peningkatan frekuensi berkemih pada malam hari (nokturia) menjadi penyebab utama gangguan tidur pada lansia. Kondisi tersebut menyebabkan lansia sering terbangun dan kesulitan untuk tidur kembali (Hutabarat et al., 2024).

Penggunaan obat-obatan tertentu juga dapat memengaruhi kualitas tidur lansia. Beberapa jenis obat seperti diuretik, antihipertensi, bronkodilator, dan antidepresan dapat menyebabkan efek samping berupa insomnia, sering berkemih pada malam hari, atau gangguan pola tidur lainnya. Oleh karena itu, pengkajian penggunaan obat sangat penting dilakukan dalam asuhan keperawatan pada lansia dengan gangguan tidur (Touhy & Jett, 2022).

Selain faktor fisik, perubahan pola tidur pada lansia juga dipengaruhi oleh faktor psikologis. Lansia yang mengalami kecemasan, stres, kesepian, depresi, atau kehilangan pasangan hidup sering mengalami kesulitan tidur. Kondisi psikologis yang tidak stabil menyebabkan aktivitas otak meningkat sehingga lansia sulit merasa rileks saat akan tidur. Gangguan emosional yang berlangsung lama dapat memperburuk kualitas tidur dan meningkatkan risiko insomnia kronis pada lansia (Stanley & Beare, 2022).

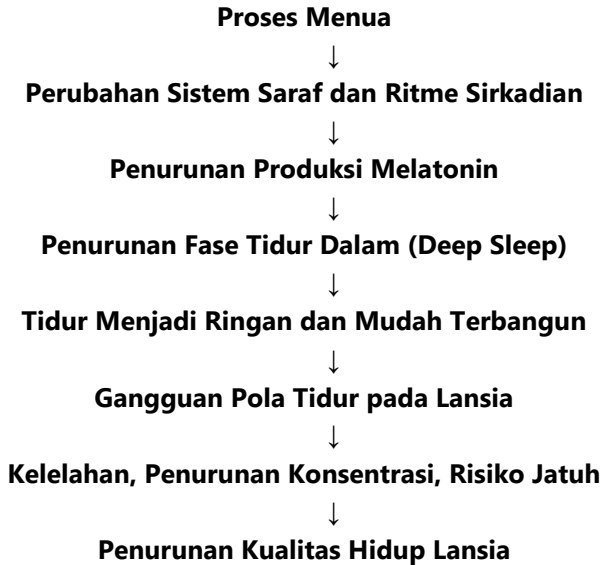
Faktor lingkungan turut berperan dalam perubahan pola tidur lansia. Lingkungan tidur yang bising, pencahayaan yang terlalu terang, suhu ruangan yang tidak nyaman, serta tempat tidur yang kurang nyaman dapat menyebabkan lansia sulit tidur. Lansia juga lebih sensitif terhadap perubahan lingkungan dibandingkan usia muda sehingga membutuhkan suasana tidur yang tenang dan nyaman untuk memperoleh kualitas tidur yang baik (Potter et al., 2023).

Perubahan pola tidur pada lansia dapat menimbulkan berbagai dampak terhadap kesehatan fisik dan psikologis. Lansia yang mengalami gangguan tidur cenderung mengalami kelelahan, penurunan konsentrasi, gangguan memori, perubahan suasana hati, serta penurunan kemampuan melakukan aktivitas sehari-hari. Gangguan tidur juga dapat meningkatkan risiko jatuh akibat menurunnya keseimbangan dan koordinasi tubuh. Dalam jangka panjang, kualitas tidur yang buruk dapat memperburuk penyakit kronis dan meningkatkan risiko depresi pada lansia (Miller, 2021).

Gangguan tidur yang paling sering dialami lansia adalah insomnia. Insomnia pada lansia ditandai dengan kesulitan memulai tidur, sering terbangun pada malam hari, terbangun terlalu pagi, dan tidak merasa segar setelah tidur. Selain insomnia, lansia juga dapat mengalami sleep apnea, restless leg syndrome, dan gangguan tidur akibat penggunaan obat-obatan tertentu. Kondisi tersebut memerlukan perhatian khusus karena dapat memengaruhi kualitas hidup lansia secara keseluruhan (Tabloski, 2021).

Dalam keperawatan gerontik, perubahan pola tidur pada lansia perlu mendapatkan perhatian secara komprehensif melalui pengkajian pola tidur, identifikasi faktor penyebab, dan pemberian intervensi yang tepat. Perawat memiliki peran penting dalam membantu lansia meningkatkan kualitas tidur melalui edukasi sleep hygiene, menciptakan lingkungan tidur yang nyaman, mengatur jadwal tidur yang teratur, serta memberikan dukungan psikologis kepada lansia dan keluarga. Pendekatan nonfarmakologis seperti relaksasi, terapi musik, aromaterapi, dan latihan fisik ringan terbukti efektif dalam membantu meningkatkan kualitas tidur lansia (Hasifah, 2024).

Alur Perubahan Pola Tidur pada Lansia



K. Patofisiologi Gangguan Tidur pada Lansia

Gangguan tidur pada lansia merupakan kondisi yang terjadi akibat perubahan fisiologis, neurologis, hormonal, psikologis, dan lingkungan yang berlangsung selama proses menua. Proses penuaan menyebabkan perubahan pada mekanisme pengaturan tidur di otak sehingga pola tidur lansia menjadi berbeda dibandingkan usia dewasa muda. Gangguan tidur pada lansia tidak hanya dipengaruhi oleh faktor usia, tetapi juga dipengaruhi oleh penyakit kronis, perubahan psikososial, penggunaan obat-obatan, serta perubahan fungsi organ tubuh yang terjadi secara progresif (Potter et al., 2023).

Secara fisiologis, tidur diatur oleh sistem saraf pusat terutama pada area hipotalamus yang mengandung nukleus suprachiasmaticus (SCN). Nukleus suprachiasmaticus

berfungsi sebagai pusat pengatur ritme sirkadian tubuh yang mengontrol siklus tidur dan bangun selama 24 jam. Pada lansia terjadi penurunan fungsi nukleus suprachiasmaticus akibat degenerasi sel saraf sehingga ritme sirkadian menjadi terganggu. Kondisi ini menyebabkan siklus tidur dan bangun tidak teratur, lansia lebih cepat merasa mengantuk pada malam hari, dan lebih sering terbangun pada dini hari (Miller, 2021).

Gangguan ritme sirkadian pada lansia juga berkaitan dengan penurunan sensitivitas tubuh terhadap cahaya. Pada usia lanjut, kemampuan retina dalam menerima cahaya mengalami penurunan sehingga stimulasi terhadap pusat pengatur tidur di hipotalamus menjadi kurang optimal. Akibatnya, regulasi siklus tidur dan bangun menjadi terganggu dan menyebabkan lansia lebih mudah mengalami insomnia serta gangguan kualitas tidur (Tabloski, 2021).

Selain perubahan neurologis, gangguan tidur pada lansia juga dipengaruhi oleh perubahan hormonal, terutama penurunan produksi hormon melatonin. Melatonin merupakan hormon yang diproduksi oleh kelenjar pineal dan berfungsi mengatur rasa kantuk serta mempertahankan ritme sirkadian tubuh. Produksi melatonin meningkat pada malam hari untuk membantu tubuh memulai tidur. Namun, pada lansia produksi melatonin mengalami penurunan sehingga menyebabkan kesulitan memulai tidur, tidur menjadi lebih dangkal, serta mudah terbangun pada malam hari (Touhy & Jett, 2022).

Perubahan hormon lain seperti penurunan hormon pertumbuhan, estrogen, dan testosteron juga memengaruhi kualitas tidur lansia. Penurunan hormon-hormon tersebut menyebabkan penurunan metabolisme tubuh, perubahan suasana hati, penurunan energi, serta gangguan

termoregulasi yang dapat mengganggu kenyamanan tidur lansia (Stanley & Beare, 2022).

Gangguan tidur pada lansia juga dipengaruhi oleh perubahan neurotransmitter di otak. Neurotransmitter seperti serotonin, dopamin, gamma aminobutyric acid (GABA), dan asetilkolin memiliki peran penting dalam mengatur proses tidur dan bangun. Penurunan kadar serotonin dan dopamin menyebabkan tidur menjadi lebih dangkal dan mudah terganggu. Selain itu, penurunan aktivitas neurotransmitter GABA menyebabkan lansia lebih sulit mencapai keadaan relaksasi sehingga mengalami kesulitan memulai tidur (Potter et al., 2023).

Proses menua juga menyebabkan perubahan struktur tidur pada lansia. Lansia mengalami penurunan fase tidur dalam atau deep sleep (NREM tahap N3) serta peningkatan fase tidur ringan. Kondisi tersebut menyebabkan lansia lebih mudah terbangun akibat suara, cahaya, nyeri, atau rangsangan lingkungan lainnya. Selain itu, fase Rapid Eye Movement (REM) juga mengalami perubahan sehingga proses pemulihan psikologis dan fungsi memori menjadi kurang optimal (Mauk, 2023).

Penyakit kronis yang sering dialami lansia turut memperburuk gangguan tidur. Hipertensi, diabetes melitus, penyakit jantung, osteoarthritis, penyakit paru obstruktif kronik (PPOK), dan gangguan neurologis seperti stroke atau demensia dapat menyebabkan lansia mengalami nyeri, sesak napas, batuk, atau peningkatan frekuensi berkemih pada malam hari. Kondisi tersebut menyebabkan tidur menjadi tidak nyenyak dan sering terputus (Hutabarat et al., 2024).

Gangguan psikologis juga memiliki peran penting dalam patofisiologi gangguan tidur pada lansia. Lansia yang mengalami stres, kecemasan, depresi, kesepian, atau

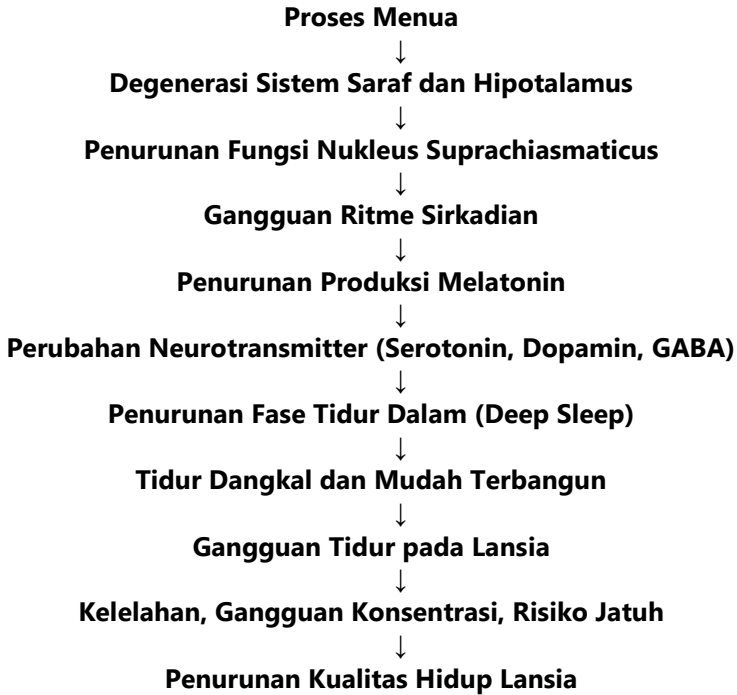
kehilangan pasangan hidup cenderung mengalami peningkatan aktivitas sistem saraf simpatis sehingga tubuh sulit mencapai kondisi relaksasi. Akibatnya, lansia mengalami kesulitan memulai tidur dan kualitas tidur menjadi buruk (Hasifah, 2024).

Penggunaan obat-obatan tertentu dapat memperburuk gangguan tidur pada lansia. Obat diuretik dapat menyebabkan lansia sering berkemih pada malam hari, sedangkan obat bronkodilator, kortikosteroid, dan beberapa jenis antidepresan dapat menyebabkan insomnia. Selain itu, penggunaan obat tidur jangka panjang dapat mengganggu siklus tidur normal dan meningkatkan risiko ketergantungan pada lansia (Touhy & Jett, 2022).

Gangguan tidur yang berlangsung lama dapat menyebabkan berbagai dampak fisiologis dan psikologis pada lansia. Kurangnya kualitas tidur menyebabkan penurunan daya tahan tubuh, gangguan konsentrasi, penurunan memori, kelelahan, gangguan keseimbangan, serta peningkatan risiko jatuh. Dalam jangka panjang, gangguan tidur kronis dapat memperburuk penyakit kardiovaskular, meningkatkan risiko depresi, dan menurunkan kualitas hidup lansia secara keseluruhan (Miller, 2021).

Dalam praktik keperawatan gerontik, pemahaman mengenai patofisiologi gangguan tidur sangat penting untuk membantu perawat mengidentifikasi penyebab gangguan tidur dan menentukan intervensi yang tepat. Pendekatan holistik yang mencakup aspek biologis, psikologis, sosial, dan lingkungan diperlukan untuk membantu meningkatkan kualitas tidur lansia dan mempertahankan kualitas hidupnya (Potter et al., 2023).

Alur Patofisiologi Gangguan Tidur pada Lansia



L. Manifestasi Klinis Gangguan Tidur Pada Lansia

Gangguan tidur pada lansia merupakan kondisi yang sering terjadi akibat perubahan fisiologis proses menua, penyakit kronis, faktor psikologis, maupun lingkungan. Manifestasi klinis gangguan tidur pada lansia dapat muncul dalam berbagai bentuk dan tingkat keparahan yang berbeda pada setiap individu. Keluhan utama yang paling sering dialami lansia adalah kesulitan memulai tidur (sleep onset insomnia), sering terbangun pada malam hari, tidur tidak nyenyak, terbangun terlalu dini pada pagi hari, serta kesulitan untuk tidur kembali setelah terbangun. Kondisi ini

menyebabkan waktu tidur efektif menjadi berkurang dan kualitas tidur menurun secara signifikan (Potter et al., 2023).

Lansia dengan gangguan tidur umumnya mengeluhkan tidur yang terasa dangkal dan mudah terganggu oleh suara, cahaya, nyeri, atau keinginan berkemih pada malam hari. Lansia sering kali merasa bahwa tidur yang dialami tidak memberikan rasa segar ketika bangun di pagi hari. Akibatnya, lansia mengalami kelelahan fisik, penurunan energi, dan rasa lemas sepanjang hari. Keluhan tersebut dapat memengaruhi kemampuan lansia dalam menjalankan aktivitas sehari-hari secara mandiri (Mauk, 2023).

Manifestasi klinis gangguan tidur pada lansia tidak hanya berdampak pada kondisi fisik, tetapi juga memengaruhi fungsi psikologis dan kognitif. Kurangnya kualitas tidur menyebabkan lansia mengalami gangguan konsentrasi, penurunan daya ingat, kesulitan berpikir, serta lambat dalam mengambil keputusan. Kondisi ini terjadi karena tidur memiliki peran penting dalam proses konsolidasi memori dan pemulihan fungsi otak. Gangguan tidur yang berlangsung terus-menerus dapat mempercepat penurunan fungsi kognitif pada lansia dan meningkatkan risiko demensia (Tabloski, 2021).

Secara emosional, lansia yang mengalami gangguan tidur cenderung lebih mudah marah, sensitif, cemas, gelisah, dan mengalami perubahan suasana hati. Kurang tidur menyebabkan keseimbangan neurotransmitter di otak terganggu sehingga lansia lebih rentan mengalami stres dan depresi. Lansia juga dapat mengalami penurunan motivasi, menarik diri dari lingkungan sosial, serta kehilangan minat terhadap aktivitas yang sebelumnya disukai (Touhy & Jett, 2022).

Manifestasi klinis lain yang sering muncul adalah rasa mengantuk berlebihan pada siang hari (daytime sleepiness). Lansia yang tidak mendapatkan tidur malam yang berkualitas akan lebih sering tertidur pada siang hari, terutama saat duduk santai atau melakukan aktivitas ringan. Kondisi ini dapat menyebabkan pola tidur menjadi semakin tidak teratur dan memperburuk gangguan tidur pada malam hari (Stanley & Beare, 2022).

Gangguan tidur pada lansia juga dapat memengaruhi keseimbangan dan kemampuan mobilitas. Lansia yang mengalami kurang tidur cenderung mengalami penurunan koordinasi tubuh, gangguan refleks, dan penurunan kewaspadaan sehingga meningkatkan risiko jatuh. Risiko jatuh pada lansia merupakan masalah serius karena dapat menyebabkan cedera, fraktur, kehilangan kemandirian, bahkan meningkatkan angka mortalitas pada kelompok usia lanjut (Potter et al., 2023).

Selain itu, gangguan tidur kronis dapat memperburuk kondisi penyakit kronis yang telah dimiliki lansia. Kurang tidur dapat meningkatkan tekanan darah, memperburuk kontrol gula darah pada pasien diabetes melitus, meningkatkan risiko penyakit jantung, serta menurunkan sistem imun tubuh. Lansia dengan kualitas tidur buruk juga cenderung mengalami proses penyembuhan yang lebih lambat ketika sakit (Miller, 2021).

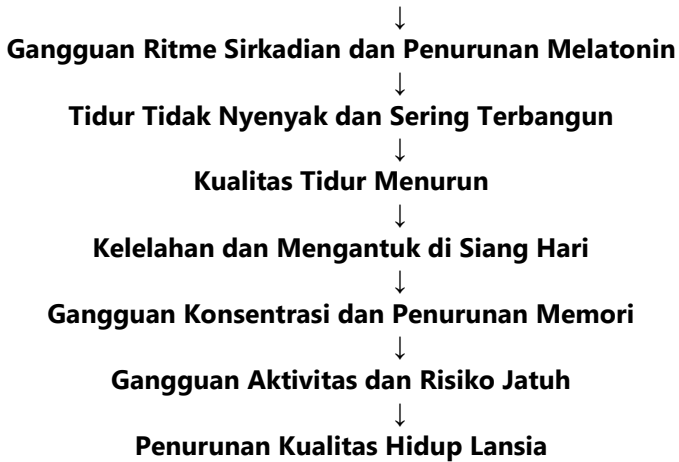
Beberapa manifestasi klinis gangguan tidur yang sering ditemukan pada lansia meliputi insomnia, sleep apnea, restless leg syndrome, dan gangguan tidur akibat nyeri kronis. Insomnia merupakan gangguan tidur yang paling sering terjadi dan ditandai dengan kesulitan tidur atau mempertahankan tidur. Sleep apnea ditandai dengan henti napas sementara saat tidur yang menyebabkan lansia sering

terbangun dan merasa lelah pada siang hari. Restless leg syndrome menyebabkan rasa tidak nyaman pada tungkai sehingga lansia sulit tidur dan sering menggerakkan kaki saat malam hari (Tabloski, 2021).

Gangguan tidur yang berlangsung dalam waktu lama dapat menyebabkan penurunan kualitas hidup lansia secara menyeluruh. Lansia menjadi lebih tergantung pada orang lain dalam melakukan aktivitas sehari-hari, mengalami penurunan interaksi sosial, serta memiliki risiko lebih tinggi mengalami gangguan mental dan emosional. Oleh karena itu, gangguan tidur pada lansia perlu mendapatkan perhatian serius dalam pelayanan kesehatan dan asuhan keperawatan gerontik (Hasifah, 2024).

Dalam praktik keperawatan, pengkajian manifestasi klinis gangguan tidur sangat penting dilakukan untuk membantu menentukan penyebab dan tingkat keparahan gangguan tidur pada lansia. Pengkajian meliputi pola tidur, lama tidur, frekuensi terbangun pada malam hari, faktor yang mengganggu tidur, penggunaan obat-obatan, serta dampak gangguan tidur terhadap aktivitas sehari-hari. Dengan pengkajian yang komprehensif, perawat dapat merencanakan intervensi yang tepat untuk meningkatkan kualitas tidur dan kualitas hidup lansia (Potter et al., 2023).

Alur Manifestasi Klinis Gangguan Tidur pada Lansia
Perubahan Fisiologis Proses Menua



M. Asuhan Keperawatan pada Lansia dengan Gangguan Tidur

Asuhan keperawatan pada lansia dengan gangguan tidur merupakan proses pelayanan keperawatan yang dilakukan secara sistematis, holistik, dan berkesinambungan untuk membantu lansia memenuhi kebutuhan istirahat dan tidur secara optimal. Gangguan tidur pada lansia dapat memengaruhi kesehatan fisik, psikologis, sosial, dan kualitas hidup sehingga membutuhkan penanganan yang komprehensif. Dalam keperawatan gerontik, pendekatan asuhan keperawatan tidak hanya berfokus pada gangguan tidur itu sendiri, tetapi juga mempertimbangkan faktor penyebab, kondisi kesehatan lansia, lingkungan, serta dukungan keluarga yang dimiliki lansia (Touhy & Jett, 2022).

Asuhan keperawatan pada lansia dengan gangguan tidur dilakukan melalui tahapan proses keperawatan yang meliputi pengkajian, diagnosis keperawatan, perencanaan,

implementasi, dan evaluasi. Proses keperawatan yang sistematis membantu perawat memberikan intervensi yang tepat sesuai kebutuhan dan kondisi lansia sehingga kualitas tidur dan kualitas hidup lansia dapat meningkat (Potter et al., 2023).

1. Pengkajian Keperawatan

Pengkajian merupakan tahap awal dalam asuhan keperawatan yang bertujuan mengumpulkan data secara menyeluruh mengenai kondisi lansia. Pada lansia dengan gangguan tidur, pengkajian harus dilakukan secara komprehensif meliputi aspek biologis, psikologis, sosial, spiritual, dan lingkungan. Pengkajian yang baik sangat penting untuk membantu perawat mengidentifikasi faktor penyebab gangguan tidur serta menentukan intervensi yang sesuai (SDKI DPP PPNI, 2021).

Pengkajian pola tidur meliputi kebiasaan tidur lansia, waktu tidur dan bangun, lama tidur, frekuensi terbangun pada malam hari, kualitas tidur, penggunaan obat tidur, serta adanya keluhan seperti sulit tidur, mimpi buruk, mendengkur, atau rasa mengantuk berlebihan pada siang hari. Perawat juga perlu mengkaji perubahan pola tidur yang dialami lansia dan dampaknya terhadap aktivitas sehari-hari (Mauk, 2023).

Selain pola tidur, pengkajian kondisi fisik perlu dilakukan untuk mengetahui adanya penyakit kronis yang dapat memengaruhi tidur, seperti hipertensi, diabetes melitus, osteoarthritis, gagal jantung, gangguan pernapasan, atau nyeri kronis. Pemeriksaan tanda-tanda vital, tingkat nyeri, pola eliminasi, dan penggunaan obat-obatan juga penting dilakukan karena beberapa jenis obat dapat menyebabkan gangguan tidur pada lansia (Hutabarat et al., 2024).

Pengkajian psikologis bertujuan mengidentifikasi adanya kecemasan, stres, depresi, kesepian, atau kehilangan pasangan hidup yang dapat memengaruhi kualitas tidur lansia. Lansia dengan masalah emosional sering mengalami insomnia dan kesulitan mempertahankan tidur. Oleh karena itu, komunikasi terapeutik sangat penting dalam menggali kondisi psikologis lansia secara mendalam (Stanley & Beare, 2022).

Pengkajian lingkungan juga perlu dilakukan karena lingkungan tidur yang bising, pencahayaan yang terlalu terang, suhu ruangan yang tidak nyaman, serta tempat tidur yang kurang nyaman dapat mengganggu kualitas tidur lansia. Dukungan keluarga dan kebiasaan tidur lansia juga perlu dikaji untuk membantu menentukan intervensi keperawatan yang efektif (Potter et al., 2023).

2. Diagnosis Keperawatan

Berdasarkan hasil pengkajian, perawat dapat menetapkan diagnosis keperawatan sesuai Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (SDKI). Diagnosis keperawatan yang sering muncul pada lansia dengan gangguan tidur antara lain gangguan pola tidur, insomnia, kelelahan, intoleransi aktivitas, ansietas, dan risiko jatuh. Diagnosis tersebut umumnya berhubungan dengan perubahan fisiologis akibat proses menua, penyakit kronis, nyeri, stres psikologis, perubahan lingkungan, dan penggunaan obat-obatan tertentu (SDKI DPP PPNI, 2021).

Diagnosis gangguan pola tidur ditandai dengan keluhan sulit tidur, sering terbangun pada malam hari, tidur tidak nyenyak, dan merasa tidak puas setelah tidur. Diagnosis insomnia muncul ketika lansia mengalami

kesulitan memulai atau mempertahankan tidur yang berlangsung secara terus-menerus sehingga memengaruhi fungsi sehari-hari. Sementara itu, diagnosis kelelahan dan intoleransi aktivitas muncul akibat kurangnya kualitas tidur yang menyebabkan lansia mudah lelah dan mengalami penurunan energi (SLKI DPP PPNI, 2021).

3. Perencanaan Keperawatan

Perencanaan keperawatan dilakukan berdasarkan masalah yang ditemukan dan disusun sesuai kebutuhan lansia. Tujuan utama asuhan keperawatan pada lansia dengan gangguan tidur adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas tidur, mengurangi gangguan tidur, meningkatkan kenyamanan, serta membantu lansia mempertahankan aktivitas sehari-hari secara optimal (SIKI DPP PPNI, 2021).

Kriteria hasil yang diharapkan meliputi lansia mampu tidur dengan durasi yang cukup, frekuensi terbangun pada malam hari berkurang, merasa segar saat bangun tidur, tingkat kelelahan menurun, dan mampu melakukan aktivitas sehari-hari dengan lebih baik. Selain itu, lansia diharapkan mampu memahami faktor-faktor yang memengaruhi tidur dan menerapkan pola tidur sehat dalam kehidupan sehari-hari (SLKI DPP PPNI, 2021).

4. Implementasi Keperawatan

Implementasi keperawatan pada lansia dengan gangguan tidur dapat dilakukan melalui pendekatan nonfarmakologis maupun kolaboratif sesuai kondisi lansia. Pendekatan nonfarmakologis menjadi pilihan utama karena lebih aman dan efektif dalam jangka panjang dibandingkan penggunaan obat tidur secara terus-menerus (Touhy & Jett, 2022).

Salah satu intervensi penting adalah edukasi sleep hygiene. Perawat memberikan pendidikan kesehatan mengenai pentingnya menjaga pola tidur yang teratur, tidur dan bangun pada jam yang sama setiap hari, serta menghindari tidur terlalu lama pada siang hari. Lansia juga dianjurkan mengurangi konsumsi kafein, teh, rokok, dan makanan berat menjelang tidur karena dapat mengganggu kualitas tidur (Potter et al., 2023).

Perawat juga perlu membantu menciptakan lingkungan tidur yang nyaman dan tenang. Pengaturan pencahayaan, suhu ruangan, kebisingan, dan kenyamanan tempat tidur dapat membantu lansia lebih mudah tidur. Lansia dianjurkan menggunakan pakaian yang nyaman dan melakukan aktivitas relaksasi sebelum tidur agar tubuh lebih rileks (Mauk, 2023).

Teknik relaksasi terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas tidur lansia. Relaksasi napas dalam, meditasi ringan, terapi musik, dan aromaterapi lavender dapat membantu mengurangi kecemasan dan meningkatkan rasa nyaman sebelum tidur. Evidence-based nursing terbaru menunjukkan bahwa terapi nonfarmakologis tersebut efektif meningkatkan kualitas tidur pada lansia tanpa menimbulkan efek samping yang berbahaya (SIKI DPP PPNI, 2021).

Aktivitas fisik ringan seperti senam lansia, berjalan santai, dan peregangan juga dianjurkan untuk membantu meningkatkan kualitas tidur. Aktivitas fisik dapat membantu tubuh merasa lebih rileks dan memperbaiki ritme sirkadian tubuh. Namun, olahraga berat menjelang waktu tidur sebaiknya dihindari karena dapat meningkatkan stimulasi tubuh dan mengganggu tidur (Tabloski, 2021).

Perawat juga memiliki peran penting dalam memberikan dukungan emosional melalui komunikasi terapeutik. Lansia yang mengalami kecemasan, kesepian, atau stres memerlukan perhatian dan dukungan psikologis agar merasa lebih tenang dan nyaman. Dukungan keluarga sangat penting dalam membantu lansia mempertahankan pola tidur yang sehat dan meningkatkan kenyamanan psikologisnya (Hasifah, 2024).

Apabila gangguan tidur berkaitan dengan penyakit kronis atau penggunaan obat tertentu, perawat perlu melakukan kolaborasi dengan dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Kolaborasi dilakukan dalam pengelolaan nyeri, evaluasi penggunaan obat-obatan, serta penanganan gangguan kesehatan yang mendasari masalah tidur lansia (Potter et al., 2023).

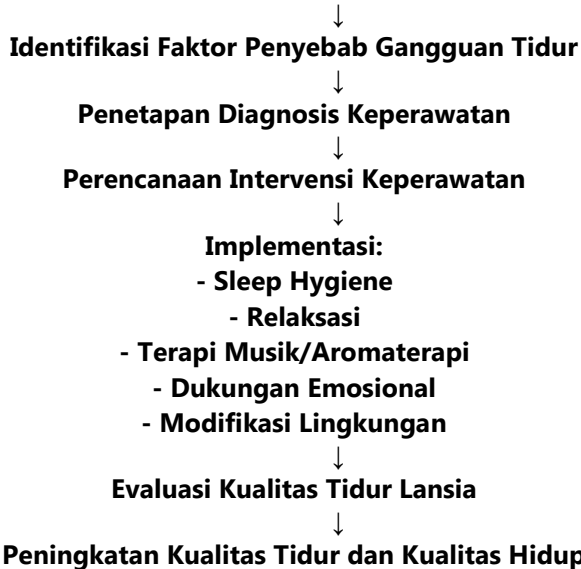
5. Evaluasi Keperawatan

Evaluasi dilakukan untuk menilai keberhasilan intervensi keperawatan yang telah diberikan. Evaluasi meliputi perubahan pola tidur, kualitas tidur, tingkat kelelahan, kemampuan aktivitas sehari-hari, dan kondisi emosional lansia. Intervensi dikatakan berhasil apabila lansia mampu tidur lebih nyenyak, frekuensi terbangun berkurang, merasa segar saat bangun tidur, serta menunjukkan peningkatan kualitas hidup (SLKI DPP PPNI, 2021).

Perawat perlu melakukan evaluasi secara berkelanjutan karena gangguan tidur pada lansia sering dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat berubah sewaktu-waktu. Pendekatan yang konsisten dan dukungan keluarga sangat penting untuk mempertahankan keberhasilan intervensi keperawatan pada lansia dengan gangguan tidur (Touhy & Jett, 2022).

Alur Asuhan Keperawatan Lansia dengan Gangguan Tidur

Pengkajian Pola Tidur Lansia



N. Evidence Based Nursing pada Gangguan Tidur Lansia

Evidence Based Nursing (EBN) merupakan pendekatan praktik keperawatan yang mengintegrasikan hasil penelitian ilmiah terbaik, pengalaman klinis perawat, serta kebutuhan dan preferensi pasien dalam pemberian asuhan keperawatan. Pada lansia dengan gangguan tidur, penerapan evidence based nursing sangat penting untuk memastikan bahwa intervensi yang diberikan aman, efektif, dan sesuai dengan kondisi lansia. Pendekatan berbasis bukti membantu perawat memilih intervensi nonfarmakologis maupun kolaboratif yang terbukti mampu meningkatkan kualitas tidur dan kualitas hidup lansia secara optimal (Potter et al., 2023).

Gangguan tidur pada lansia merupakan masalah kesehatan yang sering terjadi dan berdampak terhadap kondisi fisik, psikologis, sosial, serta kemampuan lansia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, berbagai penelitian telah dikembangkan untuk menemukan intervensi yang efektif dalam mengatasi gangguan tidur pada lansia. Saat ini, pendekatan nonfarmakologis lebih direkomendasikan sebagai terapi utama karena relatif aman, minim efek samping, dan efektif meningkatkan kualitas tidur lansia dibandingkan penggunaan obat tidur jangka panjang (Touhy & Jett, 2022).

Salah satu intervensi evidence based nursing yang banyak digunakan pada lansia dengan gangguan tidur adalah terapi musik relaksasi. Terapi musik terbukti membantu menurunkan tingkat kecemasan, mengurangi stres, memberikan rasa nyaman, serta meningkatkan relaksasi sebelum tidur. Musik dengan tempo lambat dan irama yang menenangkan dapat menurunkan aktivitas sistem saraf simpatis sehingga tubuh menjadi lebih rileks dan mudah memasuki fase tidur. Penelitian menunjukkan bahwa lansia yang mendapatkan terapi musik relaksasi mengalami peningkatan kualitas tidur secara signifikan, ditandai dengan berkurangnya frekuensi terbangun pada malam hari dan meningkatnya rasa segar saat bangun tidur (Annisa et al., 2024).

Selain terapi musik, aromaterapi lavender juga menjadi intervensi nonfarmakologis yang terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas tidur lansia. Lavender mengandung senyawa linalool dan linalyl acetate yang memiliki efek sedatif dan relaksasi pada sistem saraf pusat. Penggunaan aromaterapi lavender sebelum tidur membantu menurunkan kecemasan, memperlambat denyut jantung, serta

memberikan efek tenang sehingga lansia lebih mudah tidur dan tidur menjadi lebih nyenyak (Mauk, 2023).

Teknik relaksasi napas dalam juga terbukti efektif dalam membantu lansia mengatasi gangguan tidur. Teknik ini dilakukan dengan mengatur pola pernapasan secara perlahan dan teratur untuk membantu tubuh mencapai kondisi relaksasi. Latihan napas dalam dapat menurunkan ketegangan otot, mengurangi kecemasan, serta membantu menstabilkan denyut jantung dan tekanan darah. Lansia yang melakukan relaksasi napas dalam secara rutin sebelum tidur menunjukkan peningkatan kualitas tidur dan penurunan keluhan insomnia (Hasifah, 2024).

Intervensi lain yang direkomendasikan dalam evidence based nursing adalah sleep hygiene. Sleep hygiene merupakan upaya menjaga kebiasaan tidur yang sehat untuk meningkatkan kualitas tidur. Intervensi sleep hygiene meliputi pengaturan jadwal tidur yang konsisten, tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari, membatasi tidur siang yang berlebihan, menghindari konsumsi kafein, nikotin, dan makanan berat sebelum tidur, serta menciptakan lingkungan tidur yang nyaman dan tenang (Touhy & Jett, 2022).

Lingkungan tidur yang nyaman memiliki pengaruh besar terhadap kualitas tidur lansia. Penelitian menunjukkan bahwa pengurangan kebisingan, pencahayaan yang redup, suhu ruangan yang nyaman, serta penggunaan tempat tidur yang bersih dan nyaman dapat membantu lansia memperoleh tidur yang lebih baik. Selain itu, membatasi penggunaan televisi atau telepon genggam sebelum tidur juga dapat membantu meningkatkan kualitas tidur karena paparan cahaya dari layar elektronik dapat menghambat produksi melatonin (Potter et al., 2023).

Aktivitas fisik ringan seperti senam lansia, yoga, peregangan, dan berjalan santai juga terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas tidur pada lansia. Aktivitas fisik membantu meningkatkan sirkulasi darah, mengurangi stres, serta memperbaiki ritme sirkadian tubuh. Lansia yang rutin melakukan aktivitas fisik pada pagi atau sore hari cenderung memiliki pola tidur yang lebih baik dibandingkan lansia yang kurang aktif (Tabloski, 2021).

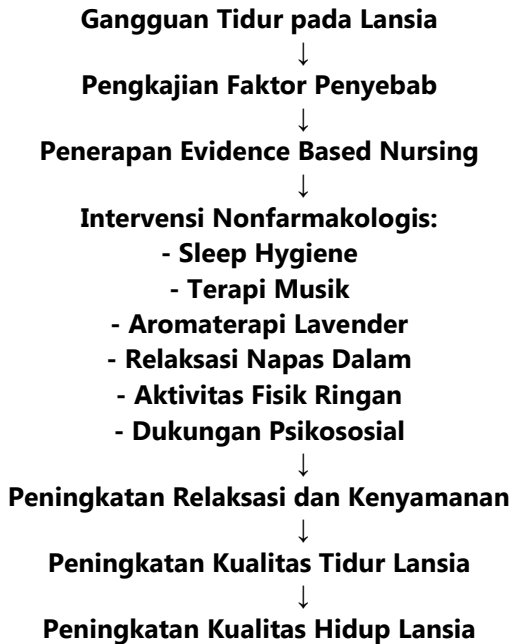
Pendekatan psikososial juga menjadi bagian penting dalam evidence based nursing pada gangguan tidur lansia. Dukungan emosional, komunikasi terapeutik, dan keterlibatan keluarga terbukti membantu mengurangi kecemasan dan rasa kesepian yang sering dialami lansia. Lansia yang mendapatkan dukungan sosial yang baik cenderung memiliki kualitas tidur yang lebih baik dibandingkan lansia yang mengalami isolasi sosial (Stanley & Beare, 2022).

Penggunaan terapi farmakologis pada lansia dengan gangguan tidur perlu dilakukan secara hati-hati karena berisiko menimbulkan efek samping seperti ketergantungan, gangguan keseimbangan, risiko jatuh, dan penurunan fungsi kognitif. Oleh karena itu, intervensi nonfarmakologis berbasis evidence lebih diutamakan dalam praktik keperawatan gerontik. Apabila terapi farmakologis diperlukan, penggunaannya harus berdasarkan evaluasi medis dan dilakukan dalam jangka waktu yang terbatas (Miller, 2021).

Dalam praktik keperawatan, penerapan evidence based nursing membantu perawat memberikan intervensi yang lebih efektif dan terukur dalam mengatasi gangguan tidur lansia. Perawat perlu terus memperbarui pengetahuan mengenai hasil penelitian terbaru agar mampu memberikan

pelayanan keperawatan yang berkualitas dan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan (Hasifah, 2024).

Alur Evidence Based Nursing pada Gangguan Tidur Lansia



O. Ringkasan Bab

Lanjut usia merupakan tahap akhir dalam siklus kehidupan manusia yang ditandai dengan proses menua yang berlangsung secara alami, progresif, dan tidak dapat dihindari. Proses penuaan menyebabkan perubahan pada berbagai sistem tubuh, baik secara biologis, psikologis, sosial, maupun spiritual. Perubahan tersebut menyebabkan lansia mengalami penurunan kemampuan tubuh dalam mempertahankan homeostasis sehingga lebih rentan terhadap berbagai penyakit degeneratif dan masalah kesehatan kronis. Selain perubahan fisik, lansia juga

menghadapi perubahan peran sosial, penurunan fungsi psikologis, serta perubahan kondisi emosional yang dapat memengaruhi kualitas hidupnya (Miller, 2021).

Penggolongan usia lansia membantu tenaga kesehatan dalam menentukan pendekatan pelayanan dan asuhan keperawatan sesuai tingkat kemandirian serta kondisi kesehatan lansia. Semakin bertambah usia seseorang, maka risiko penurunan fungsi organ, gangguan mobilitas, ketergantungan, dan masalah kesehatan lainnya juga semakin meningkat. Oleh karena itu, pelayanan kesehatan pada lansia memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup serta kemandirian lansia (WHO, 2022).

Salah satu masalah kesehatan yang sering dialami lansia adalah gangguan tidur. Tidur merupakan kebutuhan dasar manusia yang memiliki fungsi penting dalam pemulihan energi, perbaikan jaringan tubuh, menjaga fungsi imun, serta mempertahankan kesehatan fisik dan psikologis. Pada lansia terjadi perubahan pola tidur akibat perubahan ritme sirkadian, penurunan produksi hormon melatonin, perubahan neurotransmitter, serta penurunan fase tidur dalam. Kondisi tersebut menyebabkan lansia lebih mudah mengalami kesulitan tidur, sering terbangun pada malam hari, tidur tidak nyenyak, dan mengantuk pada siang hari (Potter et al., 2023).

Gangguan tidur pada lansia tidak hanya dipengaruhi oleh proses fisiologis penuaan, tetapi juga oleh penyakit kronis, nyeri, penggunaan obat-obatan, stres psikologis, kecemasan, depresi, serta lingkungan tidur yang kurang nyaman. Gangguan tidur yang berlangsung dalam jangka panjang dapat menyebabkan kelelahan, gangguan konsentrasi, penurunan memori, peningkatan risiko jatuh,

penurunan daya tahan tubuh, hingga memperburuk penyakit kronis yang dimiliki lansia. Dampak tersebut dapat menyebabkan penurunan kualitas hidup dan meningkatkan ketergantungan lansia terhadap orang lain (Tabloski, 2021).

Patofisiologi gangguan tidur pada lansia berkaitan dengan perubahan neurologis dan hormonal yang terjadi selama proses menua. Penurunan fungsi nukleus suprachiasmaticus di hipotalamus menyebabkan gangguan ritme sirkadian, sedangkan penurunan produksi melatonin menyebabkan lansia mengalami kesulitan memulai dan mempertahankan tidur. Selain itu, perubahan neurotransmitter seperti serotonin, dopamin, dan GABA turut memengaruhi kualitas tidur lansia sehingga tidur menjadi lebih dangkal dan mudah terganggu (Touhy & Jett, 2022).

Manifestasi klinis gangguan tidur pada lansia dapat berupa insomnia, sering terbangun pada malam hari, tidur tidak nyenyak, mudah lelah, mengantuk pada siang hari, penurunan konsentrasi, perubahan suasana hati, hingga gangguan aktivitas sehari-hari. Jika tidak ditangani dengan baik, gangguan tidur dapat menyebabkan masalah fisik, psikologis, dan sosial yang lebih berat pada lansia (Mauk, 2023).

Dalam praktik keperawatan gerontik, perawat memiliki peran penting dalam memberikan asuhan keperawatan yang holistik kepada lansia dengan gangguan tidur. Asuhan keperawatan dilakukan melalui proses pengkajian, penetapan diagnosis keperawatan, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Pengkajian yang komprehensif meliputi pola tidur, kondisi fisik, psikologis, sosial, spiritual, serta lingkungan lansia sangat penting untuk menentukan intervensi yang tepat (SDKI DPP PPNI, 2021).

Intervensi keperawatan pada lansia dengan gangguan tidur lebih diutamakan menggunakan pendekatan nonfarmakologis melalui evidence based nursing. Intervensi tersebut meliputi sleep hygiene, teknik relaksasi, terapi musik, aromaterapi lavender, aktivitas fisik ringan, modifikasi lingkungan tidur, serta dukungan emosional dan komunikasi terapeutik. Pendekatan tersebut terbukti efektif membantu meningkatkan kualitas tidur lansia tanpa menimbulkan efek samping yang berbahaya seperti penggunaan obat tidur jangka panjang (Hasifah, 2024).

Dukungan keluarga juga memiliki peran penting dalam membantu lansia mempertahankan pola tidur yang sehat dan meningkatkan kenyamanan psikologisnya. Kolaborasi antara perawat, keluarga, dan tenaga kesehatan lainnya diperlukan untuk memberikan pelayanan yang optimal dan berkelanjutan pada lansia dengan gangguan tidur (Stanley & Beare, 2022).

Dengan memahami konsep dasar lansia, proses menua, perubahan pola tidur, patofisiologi gangguan tidur, manifestasi klinis, serta asuhan keperawatan berbasis evidence, perawat diharapkan mampu memberikan pelayanan gerontik yang profesional, komprehensif, dan berpusat pada kebutuhan lansia. Pendekatan holistik dalam keperawatan gerontik menjadi kunci penting dalam meningkatkan kualitas tidur, mempertahankan kemandirian, dan meningkatkan kualitas hidup lansia secara menyeluruh (Potter et al., 2023).

P. Glosarium

Activity Daily Living (ADL)

Kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri seperti makan, mandi, berpakaian, berjalan, dan toileting.

Aging Process (Proses Menua)

Proses biologis alami yang berlangsung secara bertahap dan progresif sepanjang kehidupan manusia yang ditandai dengan penurunan fungsi tubuh dan kemampuan adaptasi terhadap lingkungan.

Ansietas

Perasaan khawatir, takut, atau gelisah yang tidak jelas penyebabnya dan dapat memengaruhi kondisi psikologis maupun kualitas tidur seseorang.

Aromaterapi Lavender

Terapi nonfarmakologis menggunakan aroma bunga lavender untuk memberikan efek relaksasi, mengurangi kecemasan, dan meningkatkan kualitas tidur.

Asuhan Keperawatan Gerontik

Pelayanan keperawatan yang diberikan kepada lansia secara holistik meliputi aspek biologis, psikologis, sosial, dan spiritual untuk meningkatkan kualitas hidup lansia.

Circadian Rhythm (Ritme Sirkadian)

Siklus biologis tubuh selama 24 jam yang mengatur waktu tidur, bangun, suhu tubuh, dan berbagai fungsi fisiologis lainnya.

Deep Sleep

Fase tidur dalam pada tahap NREM yang berperan penting dalam pemulihan fisik dan perbaikan jaringan tubuh.

Demensia

Gangguan fungsi kognitif progresif yang ditandai dengan penurunan daya ingat, kemampuan berpikir, dan perubahan perilaku.

Depresi

Gangguan suasana hati yang ditandai dengan perasaan sedih berkepanjangan, kehilangan minat, dan penurunan motivasi dalam aktivitas sehari-hari.

Diagnosis Keperawatan

Keputusan klinis mengenai respons individu, keluarga, atau komunitas terhadap masalah kesehatan yang menjadi dasar dalam pemberian intervensi keperawatan.

Evidence Based Nursing (EBN)

Pendekatan praktik keperawatan yang mengintegrasikan hasil penelitian ilmiah terbaik, pengalaman klinis, dan kebutuhan pasien dalam pemberian asuhan keperawatan.

GABA (*Gamma Aminobutyric Acid*)

Neurotransmitter di otak yang berfungsi menghambat aktivitas saraf dan membantu tubuh mencapai kondisi relaksasi serta tidur.

Gangguan Pola Tidur

Kondisi terganggunya kuantitas dan kualitas tidur yang menyebabkan individu tidak merasa segar atau cukup istirahat.

Gerontik

Cabang ilmu kesehatan yang mempelajari proses penuaan dan pelayanan kesehatan pada lansia.

Hipertensi

Kondisi peningkatan tekanan darah di atas nilai normal yang sering terjadi pada lansia dan dapat memengaruhi kualitas tidur.

Homeostasis

Kemampuan tubuh mempertahankan keseimbangan kondisi internal agar tetap stabil.

Insomnia

Gangguan tidur yang ditandai dengan kesulitan memulai tidur, mempertahankan tidur, atau bangun terlalu dini.

Intervensi Keperawatan

Tindakan yang dilakukan perawat untuk membantu pasien mencapai tujuan kesehatan yang telah ditetapkan.

Kelelahan

Kondisi menurunnya energi fisik dan mental akibat aktivitas berlebihan atau kurangnya istirahat.

Kualitas Hidup

Tingkat kesejahteraan seseorang yang meliputi kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual.

Lansia

Individu yang telah berusia 60 tahun ke atas dan mengalami proses penuaan secara fisiologis.

Lavender

Tanaman herbal yang digunakan dalam aromaterapi karena memiliki efek menenangkan dan membantu meningkatkan kualitas tidur.

Melatonin

Hormon yang diproduksi oleh kelenjar pineal dan berfungsi mengatur siklus tidur dan bangun.

Neurotransmitter

Zat kimia penghantar impuls saraf di otak yang berperan dalam pengaturan tidur, suasana hati, dan fungsi tubuh lainnya.

Nonfarmakologis

Pendekatan terapi tanpa menggunakan obat-obatan, misalnya relaksasi, terapi musik, dan aromaterapi.

NREM (*Non-Rapid Eye Movement*)

Fase tidur yang terdiri dari tidur ringan hingga tidur dalam dan berfungsi dalam pemulihan fisik tubuh.

Nukleus Suprachiasmaticus (SCN)

Bagian hipotalamus yang berfungsi sebagai pusat pengatur ritme sirkadian tubuh.

Osteoarthritis

Penyakit degeneratif pada sendi yang menyebabkan nyeri dan kekakuan sehingga dapat mengganggu tidur lansia.

Patofisiologi

Perubahan fungsi tubuh yang terjadi akibat suatu penyakit atau gangguan kesehatan.

Penuaan Fisiologis

Perubahan alami pada tubuh akibat bertambahnya usia tanpa adanya proses penyakit.

Proses Keperawatan

Metode sistematis dalam pemberian asuhan keperawatan yang meliputi pengkajian, diagnosis, perencanaan, implementasi, dan evaluasi.

Rapid Eye Movement (REM)

Fase tidur yang ditandai dengan gerakan mata cepat, aktivitas otak meningkat, dan mimpi.

Relaksasi Napas Dalam

Teknik mengatur pernapasan secara perlahan dan teratur untuk membantu tubuh menjadi rileks.

Risk of Fall (Risiko Jatuh)

Kondisi yang meningkatkan kemungkinan seseorang mengalami jatuh akibat gangguan keseimbangan atau kelemahan fisik.

SDKI (Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia)

Standar nasional yang digunakan perawat di Indonesia dalam menetapkan diagnosis keperawatan.

SIKI (Standar Intervensi Keperawatan Indonesia)

Standar nasional yang digunakan sebagai pedoman tindakan atau intervensi keperawatan.

Sleep Apnea

Gangguan tidur yang ditandai dengan henti napas sementara saat tidur.

Sleep Hygiene

Kebiasaan dan perilaku yang mendukung terciptanya kualitas tidur yang baik dan sehat.

SLKI (Standar Luaran Keperawatan Indonesia)

Standar nasional yang digunakan untuk mengukur hasil atau luaran keperawatan.

Terapi Musik

Intervensi menggunakan musik untuk membantu relaksasi, mengurangi stres, dan meningkatkan kualitas tidur.

Tidur

Keadaan fisiologis reversible yang ditandai dengan penurunan kesadaran dan aktivitas tubuh untuk pemulihan fisik dan mental.

Very Old Age

Kelompok usia lansia sangat tua dengan usia ≥ 90 tahun menurut klasifikasi WHO.

World Health Organization (WHO)

Organisasi kesehatan dunia yang berada di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Q. Daftar Pustaka

- Annisa, A. S., Khairani, K., & Nurhasanah, N. (2024). *Asuhan keperawatan pada lansia dengan hipertensi*. Indonesian Journal of Health Science, 4(6), 640–646.
- Azhari, A. A., et al. (2022). *Asuhan keperawatan lansia dengan demensia*. Jurnal Keperawatan Cikini, 3(2).

- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik penduduk lanjut usia 2024*. Badan Pusat Statistik Indonesia.
- Hasifah, H. (2024). *Peran keperawatan gerontik dalam meningkatkan kualitas hidup lansia*. Jurnal Multidisipliner Bharasumba, 3(1).
- Hutabarat, A. F., et al. (2024). *Asuhan keperawatan gerontik pada lansia dengan diabetes melitus tipe II*. Prosiding Forum Ilmiah Mahasiswa.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Profil kesehatan Indonesia 2023*. Kementerian Kesehatan RI.
- Mauk, K. L. (2023). *Gerontological nursing: Competencies for care* (5th ed.). Jones & Bartlett Learning.
- Miller, C. A. (2021). *Nursing for wellness in older adults* (9th ed.). Wolters Kluwer.
- Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P., & Hall, A. (2023). *Fundamentals of nursing* (11th ed.). Elsevier.
- SDKI DPP PPNI. (2021). *Standar diagnosis keperawatan Indonesia* (Edisi 1 revisi). Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.
- SIKI DPP PPNI. (2021). *Standar intervensi keperawatan Indonesia* (Edisi 1 revisi). Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.
- SLKI DPP PPNI. (2021). *Standar luaran keperawatan Indonesia* (Edisi 1 revisi). Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.
- Stanley, M., & Beare, P. G. (2022). *Buku ajar keperawatan gerontik* (Edisi Indonesia). EGC.

- Tabloski, P. A. (2021). *Gerontological nursing* (4th ed.). Pearson Education.
- Touhy, T. A., & Jett, K. F. (2022). *Ebersole and Hess' gerontological nursing & healthy aging* (6th ed.). Elsevier.
- World Health Organization. (2022). *Ageing and health*. World Health Organization.

CHAPTER 2

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI GANGGUAN TIDUR PADA LANSIA

Resa Livia Nica, S.Kep., Ns., M.Kes.

A. Pendahuluan

Lanjut usia (lansia) merupakan kelompok populasi yang mengalami peningkatan signifikan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Peningkatan angka harapan hidup dan kemajuan pelayanan kesehatan menyebabkan jumlah lansia terus bertambah setiap tahunnya. Kondisi tersebut membawa konsekuensi terhadap meningkatnya masalah kesehatan pada lansia, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun spiritual. Salah satu masalah kesehatan yang paling sering ditemukan pada lansia adalah gangguan tidur. Gangguan tidur menjadi masalah penting dalam keperawatan gerontik karena dapat memengaruhi kualitas hidup, kemampuan fungsional, kesehatan mental, dan risiko penyakit kronis pada lansia (Faridho, 2025).

Tidur merupakan kebutuhan fisiologis dasar yang memiliki fungsi penting dalam proses pemulihan tubuh, keseimbangan metabolisme, fungsi imun, serta kesehatan psikologis. Pada lansia terjadi perubahan fisiologis akibat proses penuaan yang menyebabkan perubahan pola tidur. Lansia umumnya mengalami penurunan durasi tidur malam, berkurangnya fase tidur dalam (*deep sleep*), lebih sering terbangun pada malam hari, serta bangun lebih awal pada pagi hari. Perubahan tersebut menyebabkan lansia lebih

rentan mengalami gangguan tidur dibandingkan kelompok usia dewasa lainnya (Asrini, 2024).

Secara global, prevalensi gangguan tidur pada lansia terus meningkat. Hasil *systematic review* dan *meta-analysis* yang dilakukan oleh Canever et al. (2024) menunjukkan bahwa kualitas tidur buruk dan insomnia merupakan masalah tidur yang paling sering dialami kelompok lansia di berbagai negara. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa gangguan tidur pada lansia berkaitan erat dengan peningkatan risiko gangguan fisik maupun psikologis.

Gangguan tidur pada lansia dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat multifaktorial. Faktor fisiologis seperti proses degeneratif sistem saraf, penurunan hormon melatonin, penyakit kronis, dan nyeri kronis menjadi penyebab utama gangguan tidur. Selain itu, faktor psikologis seperti kecemasan, depresi, stres, dan kesepian juga dapat memperburuk kualitas tidur lansia. Faktor lingkungan seperti kebisingan, pencahayaan yang tidak nyaman, suhu ruangan, serta gaya hidup seperti konsumsi kafein dan kurangnya aktivitas fisik turut berkontribusi terhadap gangguan tidur pada lansia (Leba, 2023).

Gangguan tidur yang tidak ditangani dengan baik dapat menyebabkan berbagai komplikasi kesehatan. Kurang tidur kronis pada lansia dapat meningkatkan risiko hipertensi, penyakit jantung, diabetes mellitus, penurunan fungsi imun, gangguan memori, depresi, hingga peningkatan risiko jatuh. Selain itu, kualitas tidur yang buruk juga berhubungan dengan penurunan fungsi kognitif dan kualitas hidup lansia secara keseluruhan (Hasibuan & Hasna, 2021).

Dalam praktik keperawatan gerontik, pemahaman mengenai faktor-faktor yang memengaruhi gangguan tidur pada lansia sangat penting agar tenaga kesehatan mampu

melakukan pengkajian, pencegahan, dan intervensi secara tepat. Berbagai pendekatan nonfarmakologis seperti *sleep hygiene*, terapi relaksasi, aktivitas fisik, terapi musik, dan *Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia* (CBT-I) terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas tidur lansia (Faridah et al., 2024).

B. Konsep Dasar Gangguan Tidur Pada Lansia

Tidur merupakan kebutuhan fisiologis dasar manusia yang berfungsi mempertahankan keseimbangan fisik, mental, emosional, dan fungsi kognitif. Gangguan tidur adalah kondisi terganggunya kualitas, kuantitas, maupun pola tidur yang menyebabkan individu tidak memperoleh tidur yang adekuat sehingga memengaruhi aktivitas sehari-hari dan kualitas hidup. Pada lansia, gangguan tidur menjadi masalah kesehatan yang sering ditemukan akibat perubahan fisiologis proses menua serta adanya faktor penyakit penyerta (Asrini, 2024).

Gangguan tidur pada lansia dapat berupa insomnia, hypersomnia, sleep apnea, restless leg syndrome, gangguan ritme sirkadian, serta sering terbangun di malam hari. Insomnia merupakan bentuk gangguan tidur yang paling banyak dialami lansia, ditandai dengan kesulitan memulai tidur, mempertahankan tidur, atau bangun terlalu dini dan sulit tidur kembali (Faridho, 2025).

Menurut American Academy of Sleep Medicine, kualitas tidur yang buruk pada lansia dapat berdampak terhadap fungsi kognitif, status emosional, metabolisme tubuh, dan kesehatan jantung. Tidur yang tidak adekuat juga meningkatkan risiko depresi, kecemasan, gangguan memori, serta penurunan kemampuan fungsional pada lansia (Canever et al., 2024).

Tidur terdiri atas dua fase utama yaitu Non-Rapid Eye Movement (NREM) dan Rapid Eye Movement (REM). Fase NREM terbagi menjadi beberapa tahap mulai dari tidur ringan hingga tidur dalam (deep sleep), sedangkan fase REM berhubungan dengan aktivitas mimpi dan pemulihan fungsi otak. Pada lansia terjadi perubahan fisiologis sistem tidur akibat proses degeneratif pada sistem saraf pusat. Lansia mengalami penurunan fase tidur dalam (NREM tahap 3 dan 4), peningkatan frekuensi terbangun pada malam hari, serta penurunan efisiensi tidur. Kondisi tersebut menyebabkan lansia merasa mudah lelah dan mengantuk pada siang hari (Leba, 2023).

Perubahan fisiologis tidur pada lansia juga dipengaruhi oleh penurunan produksi hormon melatonin. Melatonin merupakan hormon yang berperan dalam mengatur ritme sirkadian atau siklus tidur-bangun. Penurunan hormon ini menyebabkan lansia mengalami perubahan pola tidur dan lebih rentan terhadap insomnia (Asrini, 2024).

Proses penuaan menyebabkan perubahan normal terhadap pola tidur lansia. Beberapa perubahan pola tidur yang sering ditemukan meliputi:

1. Waktu tidur malam lebih pendek
2. Tidur lebih awal pada malam hari
3. Bangun lebih awal pada pagi hari
4. Sering terbangun di malam hari
5. Penurunan kualitas tidur
6. Meningkatnya tidur siang

Lansia umumnya membutuhkan waktu tidur sekitar 6–7 jam per hari, namun kualitas tidur lebih penting dibandingkan kuantitas tidur. Perubahan pola tidur pada lansia sering kali dianggap normal, padahal kondisi tersebut dapat berkembang menjadi gangguan tidur apabila

menimbulkan ketidaknyamanan dan gangguan fungsi sehari-hari (Hasibuan & Hasna, 2021).

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa perubahan pola tidur pada lansia berkaitan dengan perubahan *neurodegeneratif*, penurunan fungsi *neurotransmitter*, serta adanya penyakit kronis yang menyertai proses menua (Yogi et al., 2025).

C. Jenis-Jenis Gangguan Tidur Pada Lansia

1. Insomnia

Insomnia merupakan gangguan tidur yang paling sering dialami oleh lansia. Insomnia adalah kondisi kesulitan memulai tidur, mempertahankan tidur, atau bangun terlalu dini dan tidak dapat tidur kembali. Lansia dengan insomnia umumnya mengeluhkan tidur tidak nyenyak, mudah terbangun di malam hari, serta merasa lelah saat bangun pagi (Faridho, 2025).

Secara fisiologis, insomnia pada lansia berkaitan dengan penurunan hormon melatonin, perubahan ritme sirkadian, dan penurunan fase tidur dalam. Selain itu, faktor psikologis seperti stres, kecemasan, depresi, dan kesepian juga berperan besar dalam terjadinya insomnia (Leba, 2023).

Gejala insomnia pada lansia meliputi;

- a. Sulit memulai tidur
- b. Sering terbangun di malam hari
- c. Tidur terasa tidak nyenyak
- d. Bangun terlalu pagi
- e. Mengantuk dan lemas di siang hari
- f. Penurunan konsentrasi

Insomnia yang berlangsung kronis dapat menyebabkan penurunan fungsi kognitif, depresi, risiko jatuh, dan penurunan kualitas hidup lansia (Asrini, 2024).

2. *Obstructive Sleep Apnea (OSA)*

Obstructive Sleep Apnea (OSA) adalah gangguan tidur yang ditandai dengan berhentinya aliran napas secara berulang selama tidur akibat sumbatan saluran napas bagian atas. Gangguan ini menyebabkan penurunan kadar oksigen dan tidur menjadi tidak efektif (Canever et al., 2024).

Sleep apnea lebih sering terjadi pada lansia karena penurunan tonus otot saluran napas, obesitas, dan perubahan struktur anatomi tubuh akibat proses menua. Lansia dengan sleep apnea biasanya mengalami:

- a. Mendengkur keras
- b. Napas terhenti saat tidur
- c. Terbangun tiba-tiba sambil terengah-engah
- d. Sakit kepala pagi hari
- e. Mengantuk berlebihan di siang hari

Sleep apnea yang tidak ditangani dapat meningkatkan risiko hipertensi, stroke, penyakit jantung, diabetes mellitus, serta gangguan fungsi kognitif pada lansia (Yogi et al., 2025).

3. *Restless Leg Syndrome (RLS)*

Restless Leg Syndrome (RLS) atau sindrom kaki gelisah merupakan gangguan neurologis yang menyebabkan rasa tidak nyaman pada tungkai sehingga penderita merasa terdorong untuk terus menggerakkan kaki, terutama saat beristirahat atau menjelang tidur malam (Asrini, 2024).

Rasa tidak nyaman yang dirasakan dapat berupa:

- a. Kesemutan

- b. Nyeri ringan
- c. Sensasi tertarik
- d. Sensasi terbakar
- e. Rasa gatal pada tungkai

Gejala biasanya memburuk pada malam hari dan menyebabkan lansia sulit tidur atau sering terbangun. Faktor risiko RLS pada lansia meliputi anemia defisiensi besi, neuropati perifer, diabetes mellitus, dan penyakit ginjal kronik (Faridho, 2025).

4. Gangguan Ritme Sirkadian

Gangguan ritme sirkadian merupakan gangguan pada siklus biologis tidur dan bangun tubuh. Pada lansia, perubahan ritme sirkadian terjadi akibat penurunan sensitivitas tubuh terhadap cahaya dan perubahan fungsi hipotalamus yang mengatur pola tidur (Leba, 2023). Lansia dengan gangguan ritme sirkadian biasanya:

- a. Tidur lebih awal pada malam hari
- b. Bangun terlalu dini pada pagi hari
- c. Mengantuk pada sore hari
- d. Sulit mempertahankan tidur malam

Gangguan ritme sirkadian menyebabkan kualitas tidur menurun dan aktivitas sehari-hari menjadi terganggu (Hasibuan & Hasna, 2021).

5. *Hypersomnia*

Hypersomnia merupakan kondisi tidur berlebihan atau rasa kantuk berlebihan pada siang hari meskipun kebutuhan tidur malam sudah terpenuhi. Lansia dengan hypersomnia sering tertidur saat beraktivitas ringan seperti menonton televisi atau membaca (Asrini, 2024). Hypersomnia pada lansia dapat disebabkan oleh:

- a. Gangguan neurologis
- b. Efek samping obat

- c. Depresi
- d. Sleep apnea
- e. Penyakit metabolik

Kondisi ini dapat menyebabkan gangguan aktivitas sehari-hari, penurunan produktivitas, serta meningkatkan risiko jatuh pada lansia (Faridho, 2025).

6. Parasomnia

Parasomnia adalah gangguan tidur yang ditandai dengan perilaku abnormal saat tidur. Parasomnia dapat terjadi pada fase NREM maupun REM sleep. Pada lansia, parasomnia sering berkaitan dengan gangguan neurologis dan penggunaan obat-obatan tertentu (Canever et al., 2024). Jenis parasomnia meliputi:

- a. Berjalan saat tidur (sleepwalking)
- b. Berbicara saat tidur
- c. Night terror
- d. Mimpi buruk
- e. REM sleep behavior disorder

REM sleep behavior disorder sering ditemukan pada lansia dan ditandai dengan gerakan tubuh aktif saat bermimpi. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko cedera pada lansia dan pasangan tidur (Yogi et al., 2025).

7. *eriodic Limb Movement Disorder* (PLMD)

Periodic Limb Movement Disorder adalah gangguan tidur berupa gerakan berulang pada tungkai saat tidur yang terjadi secara tidak sadar. Gerakan biasanya berupa hentakan kaki atau fleksi tungkai yang berulang setiap beberapa detik (Asrini, 2024).

PLMD menyebabkan kualitas tidur menjadi buruk karena lansia sering mengalami micro-awakening atau terbangun singkat berulang kali selama tidur. Akibatnya

lansia merasa tidak segar saat bangun pagi dan mengantuk pada siang hari (Leba, 2023).

8. Nocturia yang Mengganggu Tidur

Nocturia adalah kondisi sering buang air kecil pada malam hari yang menyebabkan lansia berulang kali terbangun dari tidur. Kondisi ini sangat umum terjadi pada lansia akibat perubahan fungsi kandung kemih, pembesaran prostat, diabetes mellitus, maupun penggunaan diuretik (Hasibuan & Hasna, 2021).

Nocturia dapat menyebabkan:

- a. Fragmentasi tidur
- b. Penurunan kualitas tidur
- c. Risiko jatuh saat ke kamar mandi
- d. Kelelahan pada siang hari

D. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Gangguan Tidur Pada Lansia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor fisiologis, penyakit kronis, kondisi psikologis, gaya hidup, lingkungan, serta dukungan sosial memiliki hubungan erat dengan gangguan tidur pada lansia (Fu et al., 2025).

1. Faktor Fisiologis

a. Proses Penuaan

Penuaan merupakan faktor utama yang memengaruhi kualitas tidur lansia. Seiring bertambahnya usia, terjadi perubahan pada sistem neurologis yang mengatur siklus tidur dan bangun. Lansia mengalami penurunan fase tidur dalam (deep sleep), peningkatan frekuensi terbangun malam hari, serta penurunan efisiensi tidur (Asrini, 2024).

Penelitian oleh Canever et al. (2024) menunjukkan bahwa perubahan fisiologis akibat penuaan

menyebabkan lansia lebih rentan mengalami insomnia dan gangguan ritme sirkadian dibandingkan kelompok usia dewasa muda.

Selain itu, penurunan hormon melatonin akibat degenerasi kelenjar pineal menyebabkan lansia sulit mempertahankan tidur malam. Hormon melatonin berfungsi mengatur ritme sirkadian tubuh sehingga penurunannya berpengaruh terhadap pola tidur lansia (Leba, 2023).

b. Jenis Kelamin

Jenis kelamin juga memengaruhi kualitas tidur lansia. Penelitian menunjukkan bahwa lansia perempuan lebih sering mengalami gangguan tidur dibandingkan laki-laki. Hal ini berkaitan dengan perubahan hormonal, kondisi emosional, serta tingginya prevalensi kecemasan dan depresi pada perempuan lansia (Sarayar et al., 2024).

Perubahan hormon estrogen dan progesteron pada perempuan lanjut usia dapat memengaruhi regulasi tidur sehingga meningkatkan risiko insomnia.

c. Penyakit Kronis

Penyakit kronis merupakan faktor dominan yang memengaruhi gangguan tidur pada lansia. Lansia sering mengalami penyakit degeneratif yang menyebabkan ketidaknyamanan fisik dan mengganggu proses tidur. Beberapa penyakit yang sering berhubungan dengan gangguan tidur antara lain:

- 1) Hipertensi
- 2) Diabetes mellitus
- 3) Osteoarthritis
- 4) Penyakit jantung

5) Penyakit paru obstruktif kronik (PPOK)

6) Stroke

7) Penyakit neurologis

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa nyeri kronis akibat osteoarthritis dan penyakit muskuloskeletal menjadi salah satu penyebab utama insomnia pada lansia (Yogi et al., 2026).

Selain itu, lansia dengan hipertensi dan gangguan metabolik memiliki kualitas tidur yang lebih buruk dibandingkan lansia sehat (Puspita, 2025).

2. Faktor Psikologis

a. Kecemasan

Kecemasan merupakan faktor psikologis yang sangat memengaruhi kualitas tidur lansia. Lansia yang mengalami kecemasan cenderung mengalami kesulitan memulai tidur akibat pikiran berlebihan dan perasaan khawatir terhadap kondisi kesehatan maupun kehidupan sosialnya.

Penelitian Rahmawati (2022) menjelaskan bahwa kecemasan memiliki hubungan signifikan terhadap insomnia pada lansia. Semakin tinggi tingkat kecemasan, maka semakin buruk kualitas tidur yang dialami lansia.

b. Depresi

Depresi merupakan gangguan psikologis yang sering terjadi pada lansia akibat kehilangan pasangan hidup, kesepian, penyakit kronis, maupun penurunan fungsi tubuh. Lansia dengan depresi sering mengalami gangguan tidur berupa insomnia maupun hypersomnia (Faridho, 2025). Penelitian systematic review oleh Fu et al. (2025) menunjukkan bahwa

depresi menjadi salah satu faktor risiko utama gangguan tidur pada lansia komunitas.

c. Stres

Stres emosional dapat menyebabkan aktivasi sistem saraf simpatis sehingga tubuh sulit memasuki fase relaksasi untuk tidur. Kondisi stres yang berkepanjangan menyebabkan lansia mengalami tidur tidak nyenyak dan sering terbangun di malam hari.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa stres psikologis berhubungan dengan peningkatan gangguan tidur dan penurunan kualitas hidup pada lansia (Yogi et al., 2026).

3. Faktor Gaya Hidup

a. Aktivitas Fisik

Aktivitas fisik memiliki hubungan erat dengan kualitas tidur lansia. Lansia yang kurang aktif secara fisik cenderung mengalami gangguan tidur lebih tinggi dibandingkan lansia yang rutin berolahraga.

Aktivitas fisik ringan seperti jalan kaki, senam lansia, yoga, dan peregangan terbukti dapat meningkatkan kualitas tidur serta mengurangi insomnia pada lansia (Putri et al., 2024).

Kurangnya aktivitas fisik menyebabkan tubuh tidak mengalami kelelahan fisiologis yang cukup sehingga lansia sulit tidur pada malam hari.

b. Konsumsi Kafein

Konsumsi kopi, teh, minuman energi, dan makanan berkafein dapat memengaruhi kualitas tidur karena kafein bekerja sebagai stimulan sistem saraf pusat. Lansia yang mengonsumsi kafein pada sore atau malam hari cenderung mengalami kesulitan memulai tidur (Yogi et al., 2026).

4. Penggunaan Gadget Sebelum Tidur

Paparan cahaya biru dari televisi, telepon genggam, dan perangkat elektronik dapat menghambat produksi hormon melatonin sehingga mengganggu ritme sirkadian tubuh.

Penelitian terbaru menyebutkan bahwa kebiasaan penggunaan gadget sebelum tidur berhubungan dengan peningkatan insomnia dan kualitas tidur buruk pada lansia (Fu et al., 2025).

5. Faktor Lingkungan

Lingkungan tidur yang tidak nyaman dapat menyebabkan gangguan tidur pada lansia. Faktor lingkungan yang memengaruhi kualitas tidur meliputi:

- a. Kebisingan
- b. Suhu ruangan
- c. Pencahayaan
- d. Ventilasi
- e. Kenyamanan tempat tidur

Lansia memiliki sensitivitas lebih tinggi terhadap perubahan lingkungan sehingga lebih mudah terbangun akibat suara atau cahaya (Asrini, 2024).

Penelitian menunjukkan bahwa lingkungan tidur yang nyaman dapat meningkatkan efisiensi tidur dan menurunkan frekuensi terbangun malam hari pada lansia (Yogi et al., 2026).

6. Faktor Penggunaan Obat-obatan

Lansia umumnya mengalami polypharmacy akibat penyakit kronis multipel. Penggunaan obat tertentu dapat menyebabkan gangguan tidur sebagai efek samping. Obat-obatan yang dapat mengganggu tidur meliputi:

- a. Diuretik
- b. Kortikosteroid

- c. Bronkodilator
- d. Antidepresan tertentu
- e. Obat antihipertensi

Efek samping obat dapat berupa insomnia, sering buang air kecil malam hari, mimpi buruk, maupun rasa kantuk berlebihan pada siang hari (Faridho, 2025).

7. Faktor Sosial dan Dukungan Keluarga

Dukungan sosial dan keluarga memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan psikologis dan kualitas tidur lansia. Lansia yang tinggal sendiri atau kurang mendapatkan perhatian keluarga cenderung lebih mudah mengalami kesepian dan depresi yang berdampak terhadap kualitas tidur.

Penelitian terbaru menyebutkan bahwa dukungan emosional keluarga dapat meningkatkan rasa aman dan kenyamanan psikologis sehingga kualitas tidur lansia menjadi lebih baik (Yogi et al., 2026).

8. Faktor Spiritual

Kondisi spiritual yang baik membantu lansia mencapai ketenangan batin sehingga dapat meningkatkan kualitas tidur. Aktivitas spiritual seperti doa, dzikir, meditasi, dan ibadah rutin dapat membantu menurunkan kecemasan serta meningkatkan relaksasi sebelum tidur.

Pendekatan spiritual dalam keperawatan gerontik menjadi salah satu intervensi nonfarmakologis yang efektif dalam mengatasi gangguan tidur pada lansia (Faridah et al., 2024).

E. Simpulan

Gangguan tidur pada lansia merupakan masalah kesehatan yang sering terjadi dan bersifat multifaktorial. Proses penuaan menyebabkan perubahan fisiologis pada sistem saraf, ritme sirkadian, dan produksi hormon melatonin yang berdampak terhadap perubahan pola tidur lansia. Selain faktor fisiologis, gangguan tidur juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain seperti penyakit kronis, kondisi psikologis, gaya hidup, lingkungan, penggunaan obat-obatan, dukungan sosial, serta kondisi spiritual lansia.

Penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes mellitus, osteoarthritis, dan penyakit jantung menjadi faktor dominan yang menyebabkan gangguan tidur pada lansia. Faktor psikologis seperti kecemasan, depresi, dan stres juga memiliki hubungan yang kuat terhadap terjadinya insomnia dan kualitas tidur buruk. Selain itu, kebiasaan hidup yang kurang sehat seperti kurang aktivitas fisik, konsumsi kafein berlebihan, serta penggunaan gadget sebelum tidur turut memperburuk kualitas tidur lansia.

Lingkungan tidur yang tidak nyaman seperti kebisingan, pencahayaan berlebihan, dan suhu ruangan yang tidak sesuai dapat menyebabkan lansia lebih mudah terbangun pada malam hari. Penggunaan obat-obatan tertentu juga dapat memengaruhi pola tidur akibat efek samping yang ditimbulkan. Di sisi lain, dukungan keluarga dan kondisi spiritual yang baik dapat membantu meningkatkan kenyamanan psikologis serta kualitas tidur lansia.

Gangguan tidur yang tidak ditangani dengan baik dapat berdampak terhadap kesehatan fisik, psikologis, sosial, dan kualitas hidup lansia. Oleh karena itu, diperlukan upaya penatalaksanaan secara holistik melalui pendekatan

promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Intervensi nonfarmakologis seperti sleep hygiene, aktivitas fisik, terapi relaksasi, terapi musik, dan Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia (CBT-I) menjadi pendekatan yang efektif dalam meningkatkan kualitas tidur lansia.

Perawat gerontik memiliki peran penting dalam melakukan pengkajian kualitas tidur, mengidentifikasi faktor penyebab gangguan tidur, memberikan edukasi kesehatan, serta melakukan intervensi keperawatan yang komprehensif guna meningkatkan kualitas hidup lansia.

F. Referensi

- Asrini, S. (2024). Gangguan tidur pada lanjut usia (lansia). *Neurona: Majalah Kedokteran Neuro Sains Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia*, 41(1), 1–8. <https://doi.org/10.52386/neurona.v41i1.795>
- Canever, J. B., Zurman, G., Vogel, F., Sutil, D. V., Diz, J. B. M., Danielewicz, A. L., Moreira, B. S., Cimarosti, H. I., & Avelar, N. C. P. (2024). Worldwide prevalence of sleep problems in community-dwelling older adults: A systematic review and meta-analysis. *Sleep Medicine*, 119, 118–134. <https://doi.org/10.1016/j.sleep.2024.03.040>
- Faridah, I., Rekawati, E., & Sahar, J. (2024). CBT-I online efektif meningkatkan kualitas tidur lansia. *Journal of Telenursing (JOTING)*, 6(1), 990–997. <https://doi.org/10.31539/joting.v6i1.9559>
- Faridho, F. R. (2025). Gangguan tidur pada lansia: Tinjauan pustaka sistematis. *PREPOTIF: Jurnal Kesehatan*

- Masyarakat*, 9(1), 1482–1492.
<https://doi.org/10.31004/prepotif.v9i1.41880>
- Hasibuan, R. K., & Hasna, J. A. (2021). Gambaran kualitas tidur pada lansia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan*, 17(2), 187–195. <https://doi.org/10.24853/jkk.17.2.187-195>
- Ismiriyam, F. V., & Wulansari. (2024). Pengaruh sleep hygiene terhadap kualitas tidur lansia dengan insomnia. *Journal of Holistics and Health Sciences*, 7(1), 45–53.
- Jannah, D. S. M., & Hidajat, H. G. (2023). Analisis faktor penyebab dari gangguan tidur: Kajian psikologi lintas budaya. *Psyche 165 Journal*, 17(3), 214–223. <https://doi.org/10.35134/jpsy165.v17i3.372>
- Leba, I. P. R. P. (2023). Literature review: Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas tidur pada lansia. *Professional Health Journal*, 4(2sp), 166–177. <https://doi.org/10.54832/phj.v4i2sp.349>
- Putri, H. R. P., Luthfa, I., & Aspihan, M. (2024). Hubungan aktivitas fisik dengan kualitas tidur lansia di rumah pelayanan sosial lanjut usia. *Anakes: Jurnal Ilmiah Analis Kesehatan*, 10(2), 258–267.
- Rahmawati, D. (2022). Hubungan tingkat kecemasan dengan kejadian insomnia pada lansia. *Jurnal Keperawatan Gerontik Indonesia*, 5(2), 87–95.
- Sarayar, C. P., Pondaa, A., & Pondaag, L. (2024). Faktor-faktor yang berhubungan dengan kualitas tidur pada

- lansia di Kelurahan Lahendong Tomohon Selatan. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Manado*, 3(2), 55–63. <https://doi.org/10.64418/jikma.v3i2.139>
- Suputri, N. W. B. M., Putra, I. P. Y. A., & Dewi, A. A. N. T. N. (2024). Kualitas tidur berhubungan dengan fungsi kognitif pada lansia di Desa Guwang: Studi observasional. *Majalah Ilmiah Fisioterapi Indonesia*, 12(1), 15–21.
- Yogi, A., Sapitri, A., Safira, T. B., Aisyah, N. S., & Ariyanti, S. (2025). Literatur review: Analisis faktor yang mempengaruhi kualitas tidur pada lansia. *Jurnal Siti Rufaidah*, 4(1), 1–10.

CHAPTER 3

INTERVENSI NONFARMAKOLOGIS DALAM MENINGKATKAN KUALITAS TIDUR PADA LANSIA

Ns. Nunung Nurhayati, S.Kep., M.Kep.

A. Gangguan Tidur pada Lansia

1. Gangguan tidur pada lansia umum terjadi akibat perubahan fisiologis (penurunan deep sleep, gangguan ritme sirkadian).

Gangguan tidur pada lansia merupakan masalah yang cukup sering ditemukan dalam praktik keperawatan dan erat kaitannya dengan proses penuaan yang memengaruhi berbagai sistem tubuh. Seiring bertambahnya usia, terjadi perubahan pada pola dan struktur tidur, terutama penurunan fase tidur dalam (*deep sleep*) serta meningkatnya frekuensi terbangun pada malam hari. Selain itu, penurunan produksi hormon melatonin turut memengaruhi ritme sirkadian, sehingga lansia cenderung mengalami kesulitan untuk memulai maupun mempertahankan tidur yang optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa gangguan tidur pada lansia tidak dapat dipandang sebagai keluhan sederhana, melainkan bagian dari perubahan biologis yang kompleks (Tatineny et al., 2020; Adam et al., 2023; León-barriera et al., 2025).

Prevalensi gangguan tidur pada lansia tergolong tinggi dan memberikan dampak yang luas terhadap kondisi kesehatan. Berbagai penelitian menunjukkan

bahwa lebih dari separuh lansia mengalami gangguan tidur, bahkan angka tersebut dapat meningkat hingga sekitar 80% pada kelompok usia di atas 65 tahun. Tingginya angka kejadian ini mengindikasikan bahwa gangguan tidur merupakan masalah yang signifikan. Tidak hanya memengaruhi kualitas istirahat, kondisi ini juga berdampak pada fungsi kognitif, stabilitas emosional, serta meningkatkan risiko terjadinya penyakit kronis. Oleh karena itu, penanganan gangguan tidur pada lansia perlu menjadi perhatian penting dalam asuhan keperawatan (Ohayon, 2013; Jan Djik, 2026; Bloom et al., 2009).

Gangguan tidur pada lansia juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain yang saling berkaitan. Faktor fisik seperti nyeri kronis dan penyakit degeneratif sering kali menjadi pemicu utama. Di sisi lain, faktor psikologis seperti kecemasan, depresi, dan perasaan kesepian turut memperburuk kondisi tersebut. Faktor lingkungan, seperti kebisingan, pencahayaan yang tidak sesuai, serta kenyamanan tempat tidur, juga berperan dalam menurunkan kualitas tidur. Kompleksitas faktor-faktor ini menuntut perawat untuk melakukan pengkajian secara komprehensif agar intervensi yang diberikan dapat tepat sasaran (Patel et al., 2018; Bloom et al., 2009; Griffin et al., 2020).

Dampak gangguan tidur pada lansia tidak hanya terbatas pada penurunan kondisi fisik, tetapi juga memengaruhi kualitas hidup secara menyeluruh. Lansia yang mengalami gangguan tidur sering melaporkan kelelahan, penurunan konsentrasi, serta keterbatasan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari (*activities of daily living*). Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat meningkatkan risiko jatuh, gangguan suasana hati seperti

depresi, serta penurunan fungsi kognitif. Hal ini menegaskan bahwa kualitas tidur merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kesejahteraan lansia (Bloom et al., 2009; Ju et al., 2014; Stone et al., 2015).

2. Faktor utama meliputi kondisi fisiologis (nyeri, penyakit kronis), psikologis (kecemasan, depresi), dan lingkungan (cahaya, kebisingan).

Gangguan tidur pada lansia merupakan permasalahan yang umum dijumpai dan tidak dapat dipisahkan dari berbagai faktor yang saling berinteraksi, baik dari aspek fisiologis, psikologis, maupun lingkungan. Dari perspektif fisiologis, lansia sering kali menghadapi kondisi kronis seperti osteoarthritis, penyakit kardiovaskular, serta gangguan respirasi yang dapat mengganggu kontinuitas tidur. Kondisi tersebut menyebabkan lansia lebih mudah terbangun pada malam hari dan mengalami kesulitan untuk kembali tidur, sehingga kualitas tidur secara keseluruhan menurun. Selain itu, proses penuaan juga disertai perubahan pada sistem hormonal dan neuroendokrin yang berperan dalam regulasi tidur, yang pada akhirnya memperburuk pola tidur pada kelompok usia lanjut (Patel et al., 2018; Bloom et al., 2009; Pitaningrum. et al., 2002).

Aspek psikologis juga memiliki peran yang tidak kalah penting dalam memengaruhi kualitas tidur lansia. Kondisi emosional seperti kecemasan, stres, dan depresi sering muncul sebagai respons terhadap perubahan kehidupan, termasuk berkurangnya peran sosial, kehilangan pasangan hidup, maupun penurunan kondisi kesehatan. Sejumlah penelitian menunjukkan adanya keterkaitan yang kuat antara gangguan emosional dengan kejadian insomnia pada lansia, sehingga

mempertegas bahwa kesehatan mental merupakan determinan utama dalam kualitas tidur (Fang et al., 2019;Alvaro et al., 2011). Dengan demikian, gangguan tidur pada lansia tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi fisik, tetapi juga sangat erat kaitannya dengan keadaan psikologis individu.

Faktor lingkungan juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kualitas tidur lansia. Lingkungan tidur yang kurang kondusif, seperti pencahayaan yang terlalu terang, tingkat kebisingan yang tinggi, suhu ruangan yang tidak nyaman, serta kondisi tempat tidur yang kurang mendukung, dapat menghambat proses tidur secara optimal. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kualitas lingkungan tidur memiliki hubungan yang bermakna dengan kualitas tidur lansia, sehingga pengelolaan lingkungan menjadi salah satu aspek penting dalam asuhan keperawatan (Irish et al., 2016;Patel et al., 2018). Oleh karena itu, upaya menciptakan lingkungan yang nyaman dan mendukung sangat diperlukan untuk membantu lansia memperoleh tidur yang lebih berkualitas.

Hubungan antara faktor fisiologis, psikologis, dan lingkungan bersifat saling memengaruhi dan membentuk suatu kondisi yang kompleks. Sebagai contoh, nyeri kronis tidak hanya berdampak secara fisik, tetapi juga dapat memicu kecemasan yang kemudian memperburuk kualitas tidur. Sebaliknya, lingkungan yang tidak nyaman dapat meningkatkan ketegangan psikologis, yang pada akhirnya memperpanjang gangguan tidur. Interaksi yang dinamis ini menunjukkan bahwa gangguan tidur pada lansia tidak dapat dipahami secara parsial, melainkan memerlukan pendekatan yang komprehensif dan

terintegrasi dalam praktik keperawatan (Alvaro et al., 2011;Mander et al., 2017;Baglioni et al., 2017).

3. Penggunaan terapi farmakologis berisiko efek samping, sehingga diperlukan pendekatan nonfarmakologis.

Pendekatan farmakologis telah lama menjadi salah satu strategi yang lazim digunakan dalam mengatasi gangguan tidur pada lansia di berbagai layanan kesehatan. Obat-obatan dari kelompok sedatif-hipnotik sering diresepkan untuk membantu mempercepat proses inisiasi tidur serta memperpanjang durasi istirahat. Meskipun demikian, pada kelompok lanjut usia, penggunaan obat tidur tidak dapat dilakukan secara sederhana tanpa pertimbangan yang matang. Proses penuaan membawa perubahan fisiologis, terutama pada fungsi hati dan ginjal, yang berperan dalam metabolisme dan eliminasi obat. Perubahan ini berpotensi menyebabkan akumulasi obat di dalam tubuh, sehingga meningkatkan risiko timbulnya efek samping yang tidak diharapkan (Glass et al., 2005;Baglioni et al., 2017;Mangoni & Jackson, 2003).

Dalam praktik klinis efek samping dari penggunaan obat tidur pada lansia menjadi perhatian yang cukup signifikan. Gejala seperti pusing, kantuk berlebihan, gangguan keseimbangan, hingga penurunan fungsi kognitif sering dilaporkan, dan kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko jatuh serta cedera. Mengingat lansia merupakan kelompok yang rentan terhadap komplikasi fisik, dampak ini tidak dapat diabaikan. Selain itu, penggunaan jangka panjang obat sedatif juga dapat menyebabkan toleransi dan ketergantungan, yang pada akhirnya menurunkan efektivitas terapi seiring waktu (Billioti et al., 2012;Glass et al., 2018;Holbrook et al., 2000).

Oleh karena itu, pemilihan terapi farmakologis harus mempertimbangkan secara cermat antara manfaat yang diharapkan dan potensi risiko yang mungkin timbul.

Dampak penggunaan obat tidur juga dapat dirasakan pada dimensi psikologis dan sosial lansia. Ketergantungan terhadap obat dapat membentuk persepsi bahwa kualitas tidur yang baik hanya dapat dicapai melalui bantuan farmakologis. Hal ini berpotensi menurunkan rasa percaya diri lansia dalam mengelola pola tidurnya secara mandiri. Di sisi lain, fenomena penggunaan banyak obat secara bersamaan (*polypharmacy*), yang umum terjadi pada lansia dengan penyakit kronis, meningkatkan risiko interaksi obat yang tidak diinginkan dan dapat memperburuk kondisi kesehatan secara keseluruhan (Robert, et al., 2014; Morin et al., 2004; Wastesson et al., 2018). Kondisi ini semakin menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam penggunaan terapi farmakologis pada populasi ini.

Sejalan dengan berbagai keterbatasan tersebut pendekatan nonfarmakologis semakin mendapat perhatian sebagai alternatif yang lebih aman dan berkelanjutan. Intervensi seperti pengaturan lingkungan tidur, penerapan prinsip *sleep hygiene*, teknik relaksasi, serta terapi perilaku kognitif telah terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas tidur tanpa menimbulkan efek samping yang signifikan (Song et al., 2026; Chen et al., 2022; Wang et al., 2026). Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada perbaikan gejala, tetapi juga berupaya mengatasi faktor-faktor yang mendasari gangguan tidur secara lebih komprehensif, sehingga manfaat yang diperoleh cenderung lebih bertahan dalam jangka panjang.

Terapi farmakologis tetap memiliki peran dalam penatalaksanaan gangguan tidur, penggunaannya pada lansia perlu dilakukan secara selektif dan dengan pengawasan yang ketat. Pendekatan nonfarmakologis menjadi pilihan yang lebih sejalan dengan prinsip asuhan keperawatan yang berpusat pada pasien. Dalam konteks ini, perawat memiliki peran strategis, tidak hanya dalam memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga, tetapi juga dalam merancang serta mengimplementasikan intervensi yang sesuai dengan kebutuhan individu. Melalui pendekatan yang holistik dan berbasis bukti, peningkatan kualitas tidur lansia diharapkan dapat dicapai tanpa menambah risiko terhadap kondisi kesehatan mereka.

4. Pengkajian harus komprehensif dan berorientasi geriatri.

Pengkajian keperawatan pada lansia yang mengalami gangguan tidur merupakan fondasi utama dalam menentukan arah intervensi yang tepat. Pada kelompok usia lanjut, proses penuaan membawa perubahan yang kompleks, sehingga pendekatan yang digunakan tidak dapat disamakan dengan kelompok usia lainnya. Oleh karena itu, pengkajian perlu dilakukan secara komprehensif dengan pendekatan yang berorientasi geriatri. Fokus pengkajian tidak hanya terbatas pada keluhan tidur yang dirasakan, tetapi juga harus mencakup berbagai dimensi yang memengaruhi, termasuk kondisi fisik, psikologis, sosial, serta lingkungan. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *geriatric assessment* yang menekankan pentingnya evaluasi multidimensional untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang kondisi kesehatan lansia (Fernandes et al., 2024; Dimitriadou et al., 2025).



Gambar 3.1

Pengkajian aspek fisiologis menjadi langkah awal yang penting. Perawat perlu menelusuri adanya kondisi medis yang berpotensi mengganggu kualitas tidur,

seperti nyeri kronis, gangguan kardiovaskular, masalah respirasi, maupun gangguan neurologis. Selain itu, penggunaan berbagai jenis obat secara bersamaan (*polypharmacy*) juga perlu diperhatikan, mengingat adanya risiko interaksi obat yang dapat memengaruhi pola tidur serta meningkatkan kemungkinan efek samping. Kondisi fisik lansia yang cenderung kronis menuntut evaluasi yang lebih teliti, karena apabila tidak ditangani secara tepat, dapat memperburuk gangguan tidur yang dialami (Rostamzadeh et al., 2024).

Aspek psikologis tidak dapat diabaikan dalam proses pengkajian. Lansia sering menghadapi berbagai perubahan emosional yang berkaitan dengan kehilangan, penurunan kemampuan fungsional, maupun berkurangnya interaksi sosial. Kondisi tersebut dapat memicu munculnya kecemasan dan depresi, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas tidur. Oleh karena itu, pengkajian terhadap kondisi mental perlu dilakukan secara sistematis, termasuk mengidentifikasi tingkat stres, kecemasan, serta gejala depresi yang mungkin muncul. Pendekatan ini penting agar intervensi yang dirancang tidak hanya berfokus pada gejala tidur, tetapi juga menyoroti faktor psikologis yang mendasarinya (Baglioni, Nanovska, et al., 2017).

Kondisi lingkungan dan sosial juga memiliki peran yang tidak kalah penting. Lingkungan tidur yang kurang nyaman, seperti pencahayaan yang tidak sesuai, tingkat kebisingan yang tinggi, serta suhu ruangan yang kurang mendukung, dapat mengganggu proses tidur lansia. Di samping itu, keberadaan dukungan sosial, khususnya dari keluarga, berperan dalam menciptakan rasa aman dan kenyamanan emosional. Dengan memahami aspek

lingkungan dan sosial ini, perawat dapat merancang intervensi yang lebih kontekstual dan sesuai dengan kondisi nyata pasien (Halperin, 2014).

Pengkajian pada lansia dengan gangguan tidur harus dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi. Pendekatan yang berorientasi geriatri memungkinkan perawat untuk memahami berbagai faktor yang saling berinteraksi dalam memengaruhi kualitas tidur. Perawat tidak hanya berperan sebagai pengumpul data, tetapi juga sebagai pengintegrasi informasi untuk merancang intervensi yang tepat, efektif, dan berpusat pada pasien. Dengan pengkajian yang komprehensif serta didukung oleh praktik berbasis bukti, diharapkan kualitas tidur lansia dapat ditingkatkan secara optimal, sekaligus memberikan kontribusi positif terhadap kualitas hidup mereka secara keseluruhan.

B. Intervensi Nonfarmakologis pada Lansia

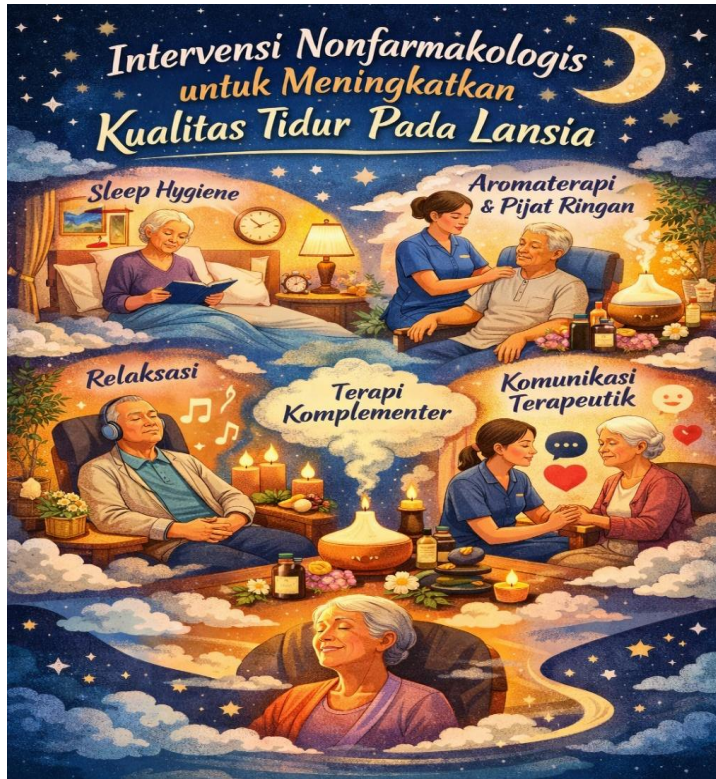
1. Dilakukan secara individual dan holistik, meliputi:
 - a. Modifikasi lingkungan (pencahayaan, kebisingan, suhu)

Modifikasi lingkungan merupakan salah satu intervensi nonfarmakologis yang penting dalam meningkatkan kualitas tidur pada lansia. Lingkungan tidur yang kondusif berperan signifikan dalam mendukung proses fisiologis tidur, terutama pada lansia yang mengalami perubahan sensitivitas terhadap rangsangan eksternal. Pencahayaan, kebisingan, dan suhu ruangan menjadi faktor utama yang perlu diperhatikan dalam menciptakan suasana yang nyaman. Lansia cenderung lebih sensitif terhadap cahaya dan suara, sehingga lingkungan yang tidak terkontrol dapat dengan mudah

mengganggu proses inisiasi maupun pemeliharaan tidur (Yin et al., 2021).

Pengaturan intensitas cahaya yang sesuai sangat penting untuk mendukung ritme sirkadian lansia. Paparan cahaya yang terlalu terang pada malam hari dapat menghambat produksi melatonin, hormon yang berperan dalam mengatur siklus tidur-bangun. Sebaliknya, pencahayaan yang redup dan hangat dapat membantu tubuh memasuki fase relaksasi yang diperlukan untuk tidur. Oleh karena itu, intervensi keperawatan dapat mencakup pengurangan cahaya buatan pada malam hari serta pemanfaatan cahaya alami pada siang hari untuk membantu menjaga keseimbangan ritme biologis lansia (Id et al., 2022).

Faktor kebisingan juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas tidur. Lingkungan yang bising dapat menyebabkan lansia lebih sering terbangun dan sulit mencapai fase tidur yang dalam. Bahkan, suara dengan intensitas rendah sekalipun dapat mengganggu tidur pada individu yang sensitif. Oleh karena itu, perawat perlu mengidentifikasi sumber kebisingan di lingkungan sekitar pasien dan melakukan upaya untuk meminimalkan gangguan tersebut, seperti mengatur jadwal aktivitas, menutup pintu atau jendela, serta menciptakan suasana yang lebih tenang pada malam hari (Basner, 2018).



Gambar 3.2

Suhu ruangan juga berperan dalam menciptakan kenyamanan tidur bagi lansia. Suhu yang terlalu panas atau terlalu dingin dapat menyebabkan ketidaknyamanan fisik yang menghambat proses tidur. Lansia umumnya memiliki kemampuan adaptasi suhu tubuh yang menurun, sehingga lebih rentan terhadap perubahan suhu lingkungan. Oleh karena itu, pengaturan suhu ruangan yang optimal, sekitar 18–24°C, dapat membantu menciptakan kondisi yang

mendukung tidur yang lebih nyenyak (Harding et al., 2019). Intervensi sederhana seperti penggunaan selimut yang sesuai atau ventilasi yang baik dapat memberikan dampak yang signifikan.

Modifikasi lingkungan merupakan pendekatan yang efektif dan relatif mudah diterapkan dalam praktik keperawatan untuk meningkatkan kualitas tidur lansia. Intervensi ini tidak hanya bersifat suportif, tetapi juga berkontribusi dalam mengurangi ketergantungan terhadap terapi farmakologis. Perawat memiliki peran penting dalam melakukan pengkajian lingkungan serta mengedukasi pasien dan keluarga mengenai pentingnya menciptakan lingkungan tidur yang nyaman. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan berbasis bukti, modifikasi lingkungan dapat menjadi strategi yang berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas tidur dan kualitas hidup lansia.

b. Teknik relaksasi (napas dalam, relaksasi otot, musik)

Teknik relaksasi merupakan salah satu intervensi nonfarmakologis yang banyak digunakan dalam upaya meningkatkan kualitas tidur pada lansia. Pendekatan ini berorientasi pada penurunan ketegangan fisik dan psikologis yang sering menjadi pemicu utama gangguan tidur. Pada lansia, kondisi seperti kecemasan, stres, serta ketegangan otot kerap muncul sebagai bagian dari perubahan fisiologis maupun psikososial, yang pada akhirnya dapat menghambat proses inisiasi tidur. Oleh karena itu, penerapan teknik

relaksasi menjadi strategi yang relevan untuk membantu tubuh mencapai kondisi yang lebih tenang dan siap beristirahat. Selain itu, intervensi ini dinilai relatif aman karena tidak menimbulkan efek samping seperti yang sering ditemukan pada terapi farmakologis (Fernandes et al., 2024).

Salah satu teknik relaksasi yang mudah dipelajari dan diterapkan adalah latihan pernapasan dalam (*deep breathing*). Teknik ini dilakukan dengan mengatur pola napas secara perlahan dan terkontrol, sehingga mampu menekan aktivitas sistem saraf simpatis dan meningkatkan respons relaksasi tubuh. Pada lansia, latihan ini terbukti efektif dalam menurunkan kecemasan serta menciptakan rasa nyaman menjelang waktu tidur. Keunggulan lain dari teknik ini adalah kemudahannya untuk dipraktikkan secara mandiri setelah pasien memperoleh edukasi yang memadai dari perawat. Dengan demikian, latihan pernapasan dalam menjadi pilihan intervensi yang sederhana namun memiliki dampak klinis yang bermakna (Russo et al., 2017).

Relaksasi otot progresif (*progressive muscle relaxation*) juga merupakan metode yang banyak direkomendasikan untuk meningkatkan kualitas tidur. Teknik ini dilakukan melalui kontraksi dan relaksasi kelompok otot secara sistematis, sehingga membantu mengurangi ketegangan fisik yang terakumulasi. Lansia, khususnya yang mengalami nyeri kronis atau

ketidaknyamanan otot, dapat memperoleh manfaat signifikan dari metode ini karena membantu tubuh mencapai kondisi relaksasi yang lebih menyeluruh. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa relaksasi otot progresif mampu menurunkan tingkat insomnia serta meningkatkan durasi dan kualitas tidur pada lansia (Chen et al., 2019).

Terapi musik juga dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari strategi relaksasi yang mendukung kualitas tidur. Musik dengan tempo lambat dan ritme yang teratur dapat merangsang sistem saraf parasimpatis, sehingga membantu menurunkan denyut jantung, tekanan darah, serta tingkat kecemasan. Lansia yang terbiasa mendengarkan musik sebelum tidur umumnya menunjukkan peningkatan kualitas tidur, baik dari segi durasi maupun kontinuitas tidur. Selain memberikan efek fisiologis, terapi musik juga memberikan manfaat psikologis, seperti meningkatkan rasa nyaman dan mengurangi perasaan kesepian (Hertenstein et al., 2022). Oleh karena itu, intervensi ini dapat menjadi pilihan yang sederhana namun efektif dalam praktik keperawatan.

Berbagai teknik relaksasi seperti latihan pernapasan dalam, relaksasi otot, dan terapi musik, merupakan intervensi yang aman dan efektif dalam meningkatkan kualitas tidur pada lansia. Pendekatan ini tidak hanya membantu mengurangi gejala gangguan tidur, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan

kesejahteraan fisik dan psikologis secara menyeluruh. Dalam konteks ini, perawat memiliki peran penting dalam memberikan edukasi, membimbing pelaksanaan teknik, serta mengevaluasi efektivitas intervensi yang dilakukan. Dengan penerapan yang konsisten dan berbasis bukti, teknik relaksasi dapat menjadi bagian integral dari asuhan keperawatan yang berpusat pada pasien dan berkelanjutan.

- c. Sleep hygiene (jadwal tidur konsisten, pembatasan tidur siang)

Sleep hygiene merupakan salah satu pendekatan nonfarmakologis yang memiliki peranan penting dalam upaya meningkatkan kualitas tidur pada lansia. Konsep ini merujuk pada serangkaian kebiasaan sehari-hari yang dirancang untuk mendukung terbentuknya pola tidur yang sehat dan teratur. Pada lansia, proses penuaan sering kali disertai perubahan fisiologis yang memengaruhi ritme sirkadian, sehingga individu menjadi lebih rentan mengalami gangguan dalam mempertahankan pola tidur yang stabil. Dalam konteks tersebut, penerapan sleep hygiene menjadi strategi yang relevan untuk membantu menyeimbangkan kembali siklus tidur-bangun serta meningkatkan kualitas istirahat secara keseluruhan (Irish et al., 2016).

Prinsip mendasar dalam sleep hygiene adalah menjaga konsistensi waktu tidur dan bangun setiap hari. Lansia dianjurkan untuk mempertahankan jadwal tidur yang

teratur, termasuk pada akhir pekan, guna menjaga kestabilan ritme biologis tubuh. Keteraturan ini berfungsi memperkuat mekanisme internal yang mengatur siklus tidur, sehingga tubuh lebih mudah mengenali kapan saatnya beristirahat dan beraktivitas. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pola tidur yang terstruktur dapat meningkatkan efisiensi tidur sekaligus menurunkan risiko insomnia pada lansia (Phillips et al., 2017). Oleh karena itu, pembentukan rutinitas tidur yang konsisten menjadi salah satu aspek penting dalam intervensi keperawatan.

Pengaturan tidur siang juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari praktik sleep hygiene. Meskipun tidur siang dapat membantu mengurangi kelelahan, durasi yang terlalu panjang atau waktu yang tidak tepat justru dapat mengganggu kualitas tidur malam. Lansia yang tidur siang dalam waktu lama, terutama melebihi satu jam atau dilakukan mendekati waktu tidur malam, cenderung mengalami kesulitan untuk tertidur pada malam hari. Oleh karena itu, edukasi mengenai durasi dan waktu tidur siang yang optimal perlu diberikan agar tidak mengganggu pola tidur utama (J. Wang, 2025).

Penerapan sleep hygiene juga mencakup kebiasaan lain yang mendukung proses tidur, seperti mengurangi paparan rangsangan sebelum tidur, membatasi konsumsi zat stimulan seperti kafein, serta membangun rutinitas relaksasi menjelang waktu

istirahat. Aktivitas sederhana yang bersifat menenangkan, seperti membaca atau mendengarkan musik dengan tempo lambat, dapat membantu tubuh dan pikiran memasuki kondisi relaksasi. Pendekatan ini bertujuan mempersiapkan individu secara fisiologis dan psikologis sebelum tidur. Sejumlah studi menunjukkan bahwa penerapan sleep hygiene secara konsisten dapat memberikan dampak positif terhadap kualitas tidur serta kesejahteraan lansia secara umum (Irish et al., 2016).

Sleep hygiene merupakan intervensi yang relatif sederhana namun memiliki efektivitas yang tinggi dalam meningkatkan kualitas tidur pada lansia. Pendekatan ini tidak hanya berkontribusi dalam mengatasi gangguan tidur, tetapi juga mendukung keseimbangan ritme biologis dan kesehatan secara menyeluruh. Dalam praktik keperawatan, perawat memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi, mendorong perubahan perilaku, serta mengevaluasi keberhasilan penerapan kebiasaan ini. Melalui pendekatan yang berkelanjutan dan berbasis bukti, lansia diharapkan mampu mencapai pola tidur yang lebih teratur dan berkualitas, sehingga berdampak positif terhadap kualitas hidup mereka.

d. Terapi komplementer (aromaterapi, pijat ringan)

Terapi komplementer semakin mendapat perhatian sebagai salah satu pendekatan nonfarmakologis dalam meningkatkan kualitas tidur pada lansia. Pendekatan

ini memanfaatkan metode alami yang bertujuan menciptakan kondisi relaksasi sekaligus meningkatkan kenyamanan fisik dan psikologis. Pada populasi lansia, gangguan tidur umumnya bersifat multifaktorial, dipengaruhi oleh ketegangan otot, kecemasan, hingga ketidaknyamanan tubuh akibat kondisi kronis. Dalam konteks tersebut, terapi komplementer seperti aromaterapi dan pijat ringan menjadi alternatif yang relevan, karena relatif aman serta memiliki risiko efek samping yang lebih rendah dibandingkan penggunaan obat tidur (Salamung & Elmiyanti, 2023).

Aromaterapi merupakan salah satu intervensi yang cukup banyak digunakan dalam praktik keperawatan. Terapi ini memanfaatkan minyak esensial untuk menghasilkan efek menenangkan melalui stimulasi indra penciuman. Minyak seperti lavender, chamomile, dan sandalwood diketahui memiliki sifat relaksatif yang dapat memengaruhi sistem saraf pusat. Mekanisme ini berkaitan dengan aktivasi sistem limbik yang berperan dalam pengaturan emosi dan respons stres. Pada lansia, penggunaan aromaterapi sebelum tidur telah terbukti membantu menurunkan tingkat kecemasan sekaligus memperbaiki kualitas tidur, baik dari segi durasi maupun kontinuitas tidur (Kooijmans et al., 2025). Dengan demikian, aromaterapi dapat menjadi intervensi yang sederhana namun bermakna dalam mendukung kualitas istirahat.

Pijat ringan (*gentle massage*) juga merupakan metode yang efektif dalam membantu lansia mencapai tidur yang lebih berkualitas. Teknik ini bekerja melalui peningkatan sirkulasi darah, pengurangan ketegangan otot, serta stimulasi pelepasan endorfin yang memberikan efek relaksasi. Pada lansia yang mengalami nyeri kronis atau kekakuan otot, pijat ringan dapat membantu mengurangi ketidaknyamanan fisik yang sering mengganggu tidur. Penelitian menunjukkan bahwa terapi pijat yang dilakukan secara teratur berkontribusi dalam meningkatkan kualitas tidur sekaligus menurunkan tingkat kecemasan (Finan et al., 2014). Oleh karena itu, pijat ringan dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari intervensi keperawatan yang bersifat suportif. Kombinasi antara aromaterapi dan pijat ringan dapat memberikan efek yang lebih optimal. Penggunaan minyak esensial selama proses pijat tidak hanya memberikan manfaat fisik, tetapi juga memperkuat efek relaksasi melalui stimulasi sensorik yang lebih menyeluruh. Pendekatan ini memungkinkan lansia mencapai kondisi relaksasi yang lebih dalam sebelum tidur. Selain itu, intervensi ini juga berkontribusi dalam membangun hubungan terapeutik antara perawat dan pasien, karena melibatkan sentuhan serta interaksi yang bersifat personal. Hal tersebut penting dalam menciptakan rasa aman dan kenyamanan selama proses perawatan (Ashery et al., 2021).

Terapi komplementer seperti aromaterapi dan pijat ringan merupakan intervensi yang efektif, aman, dan mudah diterapkan untuk meningkatkan kualitas tidur pada lansia. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pengurangan gejala gangguan tidur, tetapi juga mendukung kesejahteraan fisik dan psikologis secara menyeluruh. Dalam praktik keperawatan, perawat memiliki peran penting dalam memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga, serta memastikan bahwa intervensi dilakukan secara tepat sesuai kebutuhan individu. Dengan pendekatan yang berbasis bukti dan berorientasi pada pasien, terapi komplementer dapat menjadi bagian integral dalam asuhan keperawatan yang berkelanjutan.

e. Komunikasi terapeutik

Komunikasi terapeutik merupakan salah satu aspek kunci dalam praktik keperawatan yang berkontribusi penting terhadap peningkatan kualitas tidur pada lansia. Pendekatan ini menekankan interaksi interpersonal yang terarah, empatik, dan berpusat pada kebutuhan individu pasien. Pada lansia, gangguan tidur tidak semata-mata disebabkan oleh faktor fisik, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi emosional seperti kecemasan, ketakutan, dan perasaan kesepian. Dalam situasi ini, komunikasi terapeutik berperan sebagai media yang memungkinkan lansia mengekspresikan perasaan serta mengurangi tekanan

psikologis yang dapat mengganggu proses tidur (Sepahvand et al., 2014).

Komunikasi terapeutik melibatkan berbagai teknik yang dirancang untuk membangun hubungan yang bermakna antara perawat dan pasien. Teknik seperti mendengarkan secara aktif, memberikan respons empatik, serta penggunaan pertanyaan terbuka memungkinkan perawat menggali pengalaman dan perasaan pasien secara lebih mendalam. Melalui proses ini, faktor psikologis yang memengaruhi kualitas tidur lansia dapat diidentifikasi secara lebih komprehensif. Ketika lansia merasa didengar dan dihargai, tingkat kecemasan biasanya menurun, sehingga tubuh lebih mudah memasuki kondisi relaksasi yang mendukung tidur. Temuan penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif antara tenaga kesehatan dan pasien berperan dalam meningkatkan kenyamanan psikologis sekaligus kualitas tidur (Palagini et al., 2024).

Komunikasi terapeutik juga memiliki peran strategis dalam membangun hubungan saling percaya antara perawat dan pasien. Kepercayaan ini menjadi dasar penting dalam pemberian asuhan keperawatan, terutama pada lansia yang mungkin mengalami keterbatasan dalam mengungkapkan kebutuhan atau keluhannya. Interaksi yang dilakukan secara konsisten dengan pendekatan empatik mampu menciptakan rasa aman secara emosional. Rasa aman ini sangat

penting, karena merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap tercapainya kualitas tidur yang optimal (Wong et al., 2024).

Komunikasi terapeutik juga berfungsi sebagai sarana edukasi bagi lansia dalam memahami pentingnya kebiasaan tidur yang sehat. Perawat dapat menyampaikan informasi terkait sleep hygiene, teknik relaksasi, serta strategi koping terhadap kecemasan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Pendekatan komunikasi yang efektif tidak hanya meningkatkan pemahaman, tetapi juga mendorong keterlibatan aktif lansia dalam menjalankan anjuran yang diberikan. Selain itu, keterlibatan keluarga dalam proses komunikasi turut memperkuat dukungan sosial yang dibutuhkan lansia untuk mempertahankan kualitas tidur yang baik (Kwame & Petrucka, 2021).

Komunikasi terapeutik tidak hanya berkontribusi pada aspek psikologis, tetapi juga berperan nyata dalam meningkatkan kualitas tidur pada lansia. Pendekatan ini memungkinkan perawat memahami kebutuhan pasien secara holistik serta merancang intervensi yang lebih tepat dan individual. Dalam praktik keperawatan, keterampilan komunikasi terapeutik merupakan kompetensi esensial yang perlu dimiliki oleh setiap perawat. Dengan penerapan komunikasi yang efektif, empatik, dan berbasis bukti, kualitas tidur lansia dapat ditingkatkan sekaligus mendukung kesejahteraan mereka secara menyeluruh.

2. Dukungan keluarga penting untuk menjaga konsistensi intervensi.

Peran keluarga merupakan salah satu faktor kunci dalam menunjang keberhasilan intervensi nonfarmakologis untuk meningkatkan kualitas tidur pada lansia. Dalam praktik keperawatan gerontik, keluarga sering kali menjadi sumber dukungan utama yang membantu lansia menjalankan berbagai anjuran perawatan secara konsisten. Seiring dengan proses penuaan, lansia cenderung mengalami penurunan kemampuan fisik dan kognitif, yang dapat memengaruhi kemandirian dalam mempertahankan pola tidur yang sehat. Dalam situasi ini, keterlibatan keluarga menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa intervensi yang telah dirancang dapat diterapkan secara berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari (Gwaza & Msiska, 2022).



Gambar 3.3

Dukungan keluarga juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kondisi psikologis lansia. Kehadiran anggota keluarga yang menunjukkan perhatian, empati, dan kepedulian dapat membantu menurunkan tingkat kecemasan serta mengurangi perasaan kesepian yang sering dialami pada usia lanjut. Kondisi emosional yang lebih stabil akan mempermudah lansia memasuki fase relaksasi sebelum tidur. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa dukungan sosial, khususnya yang berasal dari keluarga, berkaitan erat dengan peningkatan kualitas tidur pada lansia (Zhang et al., 2021). Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi keluarga tidak hanya bersifat fisik, tetapi

juga mencakup dimensi emosional yang sangat berpengaruh.

Keluarga juga berperan aktif dalam membantu lansia mempertahankan konsistensi penerapan berbagai intervensi nonfarmakologis. Intervensi tersebut meliputi penerapan sleep hygiene, latihan relaksasi, serta pengaturan lingkungan tidur agar tetap nyaman dan kondusif. Sebagai contoh, anggota keluarga dapat membantu menetapkan jadwal tidur yang teratur, meminimalkan gangguan lingkungan, serta mengingatkan lansia untuk melakukan aktivitas relaksasi sebelum tidur. Konsistensi dalam menjalankan kebiasaan ini merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas tidur. Tanpa dukungan keluarga, lansia berpotensi mengalami kesulitan dalam mempertahankan rutinitas tersebut, terutama jika terdapat keterbatasan fisik atau kognitif (Mccarthy & Guerin, 2022).

Keterlibatan keluarga juga memiliki peran strategis dalam proses edukasi kesehatan yang diberikan oleh perawat. Dalam hal ini, keluarga tidak hanya berfungsi sebagai pendamping, tetapi juga sebagai mitra aktif dalam asuhan keperawatan. Melalui komunikasi yang efektif, keluarga dapat memahami tujuan serta manfaat dari setiap intervensi yang dilakukan, sehingga mereka lebih termotivasi untuk berpartisipasi secara aktif. Selain itu, keluarga juga dapat memberikan informasi terkait kondisi lansia di lingkungan rumah, yang dapat menjadi

dasar bagi perawat dalam melakukan evaluasi serta penyesuaian intervensi (Gwaza & Msiska, 2022).

Dukungan keluarga merupakan faktor esensial dalam menjaga keberlanjutan dan efektivitas intervensi nonfarmakologis pada lansia. Peran keluarga mencakup berbagai aspek, mulai dari membantu pelaksanaan intervensi, memberikan dukungan emosional, hingga melakukan pengawasan terhadap kondisi lansia. Oleh karena itu, dalam praktik keperawatan, penting bagi perawat untuk melibatkan keluarga dalam setiap tahapan asuhan, mulai dari pengkajian hingga evaluasi. Melalui pendekatan yang kolaboratif dan berorientasi pada keluarga, kualitas tidur lansia diharapkan dapat meningkat secara optimal sekaligus mendukung kualitas hidup mereka secara menyeluruh.

C. Evaluasi dan Outcome

1. Respons lansia bersifat bertahap dan dipengaruhi komorbid, fungsi kognitif, serta kebiasaan tidur.

Respons lansia terhadap intervensi nonfarmakologis dalam meningkatkan kualitas tidur pada umumnya tidak terjadi secara instan, melainkan berkembang secara bertahap sesuai dengan karakteristik individu masing-masing. Proses penuaan membawa perubahan fisiologis dan psikologis yang kompleks, sehingga respons terhadap berbagai intervensi sering kali membutuhkan waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan kelompok usia yang lebih muda. Dalam konteks ini,

perawat perlu memahami bahwa perbaikan kualitas tidur pada lansia merupakan proses yang gradual, yang menuntut konsistensi, kesabaran, serta pendekatan yang berkelanjutan (Hood & Amir, 2017).

Keberadaan komorbiditas menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi variasi respons lansia terhadap intervensi yang diberikan. Sebagian besar lansia hidup dengan kondisi kronis, seperti penyakit kardiovaskular, diabetes, nyeri berkepanjangan, maupun gangguan pernapasan, yang dapat memengaruhi kualitas tidur baik secara langsung maupun tidak langsung. Kondisi-kondisi tersebut tidak hanya memperburuk pola tidur, tetapi juga berpotensi memperlambat efektivitas intervensi nonfarmakologis. Bukti ilmiah menunjukkan bahwa lansia dengan komorbiditas multipel cenderung mengalami gangguan tidur yang lebih kompleks, sehingga memerlukan pendekatan yang lebih individual dan komprehensif (Eggmann et al., 2020). Oleh karena itu, pengkajian kesehatan secara menyeluruh menjadi langkah awal yang esensial dalam menentukan strategi intervensi yang tepat.

Fungsi kognitif juga memiliki peran yang tidak kalah penting dalam menentukan keberhasilan intervensi. Penurunan fungsi kognitif, seperti yang terjadi pada demensia atau gangguan memori, dapat memengaruhi kemampuan lansia dalam memahami, mengingat, dan melaksanakan instruksi yang diberikan oleh perawat. Dampak dari kondisi ini sering terlihat pada kurangnya

konsistensi dalam menjalankan intervensi, seperti penerapan sleep hygiene atau teknik relaksasi. Oleh karena itu, perawat perlu menyesuaikan metode edukasi dengan pendekatan yang lebih sederhana, repetitif, serta melibatkan keluarga sebagai sistem pendukung utama (Sparks et al., 2020).



Gambar 3.4

Kebiasaan tidur yang telah terbentuk dalam jangka waktu lama juga menjadi faktor penting yang memengaruhi respons terhadap intervensi. Lansia sering kali memiliki pola tidur tertentu yang telah berlangsung

bertahun-tahun, seperti tidur siang berlebihan atau paparan stimulasi sebelum tidur. Perubahan terhadap kebiasaan tersebut tidak dapat dilakukan secara cepat, melainkan membutuhkan proses adaptasi yang bertahap. Penelitian menunjukkan bahwa intervensi berbasis perilaku, seperti sleep hygiene, memerlukan penguatan yang berulang serta waktu yang cukup untuk menghasilkan perubahan yang bermakna (Hertenstein et al., 2022). Oleh karena itu, pendekatan yang realistis dan bertahap menjadi kunci dalam praktik keperawatan.

Respons lansia terhadap intervensi nonfarmakologis merupakan hasil dari interaksi kompleks antara kondisi komorbid, fungsi kognitif, serta kebiasaan tidur yang telah terbentuk sebelumnya. Hal ini menegaskan bahwa pendekatan yang bersifat individual dan holistik sangat diperlukan dalam meningkatkan kualitas tidur pada lansia. Perawat memiliki peran strategis dalam melakukan pengkajian komprehensif, menyesuaikan intervensi dengan kondisi pasien, serta melakukan evaluasi secara berkelanjutan. Dengan pendekatan yang konsisten, sabar, dan berbasis bukti, intervensi yang diberikan diharapkan mampu memberikan hasil yang optimal dalam meningkatkan kualitas tidur sekaligus kualitas hidup lansia.

2. Evaluasi meliputi peningkatan durasi dan kualitas tidur serta penurunan gangguan tidur.

Evaluasi merupakan tahap esensial dalam proses asuhan keperawatan yang bertujuan untuk menilai

efektivitas intervensi nonfarmakologis dalam meningkatkan kualitas tidur pada lansia. Tahap ini tidak hanya berperan sebagai alat ukur keberhasilan, tetapi juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan klinis terkait kelanjutan atau penyesuaian rencana perawatan. Dalam konteks keperawatan gerontik, evaluasi perlu dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, mengingat respons lansia terhadap intervensi cenderung berlangsung secara bertahap serta dipengaruhi oleh berbagai faktor individu (Fang et al., 2019).

Salah satu indikator utama dalam proses evaluasi adalah perubahan durasi tidur. Lansia yang sebelumnya mengalami gangguan tidur umumnya mulai menunjukkan peningkatan waktu tidur malam setelah intervensi diterapkan. Peningkatan ini dapat menjadi indikasi awal bahwa intervensi memberikan dampak positif terhadap pola istirahat pasien. Namun demikian, perawat perlu melakukan interpretasi secara cermat, karena lamanya waktu tidur tidak selalu mencerminkan kualitas tidur yang optimal atau bersifat restorative (Salamung & Elmiyanti, 2023).

Kualitas tidur juga menjadi aspek penting yang perlu dievaluasi secara menyeluruh. Penilaian kualitas tidur dapat dilakukan melalui beberapa indikator, seperti kemudahan dalam memulai tidur, frekuensi terbangun di malam hari, serta kondisi subjektif saat bangun di pagi hari. Lansia yang mengalami perbaikan kualitas tidur umumnya melaporkan tidur yang lebih nyenyak,

berkurangnya gangguan selama malam hari, serta perasaan lebih segar saat bangun. Bukti ilmiah menunjukkan bahwa intervensi nonfarmakologis, seperti penerapan sleep hygiene dan teknik relaksasi, berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi tidur serta kualitas istirahat secara keseluruhan (Buysse, 2014). Oleh karena itu, evaluasi perlu mempertimbangkan baik data subjektif maupun temuan observasi klinis.

Penurunan gangguan tidur juga menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan intervensi. Gangguan tidur pada lansia dapat berupa insomnia, sering terbangun, atau kesulitan mempertahankan tidur. Apabila terjadi penurunan frekuensi atau intensitas gangguan tersebut, hal ini menunjukkan bahwa intervensi yang diberikan mampu mengatasi faktor-faktor yang mendasari masalah tidur. Selain itu, perbaikan pada gejala terkait, seperti berkurangnya kecemasan atau ketegangan fisik, juga dapat menjadi indikator tidak langsung dari keberhasilan intervensi (Hertenstein et al., 2022). Dengan demikian, evaluasi tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada dinamika perubahan kondisi pasien.

Evaluasi terhadap intervensi nonfarmakologis pada lansia perlu mencakup berbagai indikator yang saling berkaitan, yaitu peningkatan durasi tidur, perbaikan kualitas tidur, serta penurunan gangguan tidur. Perawat memiliki peran penting dalam mengintegrasikan seluruh hasil evaluasi untuk menentukan langkah selanjutnya dalam asuhan keperawatan. Dengan pendekatan evaluasi

yang komprehensif, sistematis, dan berbasis bukti, diharapkan intervensi yang diberikan dapat meningkatkan kualitas tidur secara optimal serta memberikan dampak positif terhadap kesehatan dan kualitas hidup lansia secara menyeluruh.

3. Outcome utama adalah peningkatan kualitas hidup lansia melalui tidur yang lebih adekuat.

Outcome dalam asuhan keperawatan pada lansia dengan gangguan tidur tidak seharusnya dipahami secara sempit sebagai sekadar berkurangnya keluhan insomnia atau gangguan tidur lainnya. Sebaliknya, outcome perlu ditempatkan dalam kerangka yang lebih komprehensif, yaitu peningkatan kualitas hidup secara menyeluruh. Intervensi nonfarmakologis yang diberikan tidak hanya bertujuan memperbaiki pola tidur, tetapi juga mendukung keseimbangan fungsi fisik, psikologis, dan sosial pada lansia. Dalam konteks ini, tidur yang adekuat berperan sebagai fondasi penting bagi stabilitas berbagai sistem tubuh, sehingga keberhasilan intervensi tercermin pada meningkatnya kemampuan lansia dalam menjalani aktivitas sehari-hari secara lebih mandiri dan optimal (Buysse, 2014).

Perbaikan kualitas tidur memiliki implikasi langsung terhadap kondisi fisik lansia. Individu yang memperoleh tidur yang cukup cenderung menunjukkan peningkatan energi, daya tahan tubuh, serta kemampuan fungsional dalam menjalankan aktivitas harian (*activities of daily living*). Selain itu, tidur yang memadai berkontribusi

terhadap pemeliharaan sistem imun dan dapat mengurangi risiko komplikasi penyakit kronis yang sering menyertai proses penuaan. Bukti empiris menunjukkan bahwa kualitas tidur yang baik berhubungan dengan penurunan kelelahan, peningkatan mobilitas, serta berkurangnya risiko jatuh pada lansia (Kline et al., 2025). Dengan demikian, peningkatan kualitas tidur tidak hanya berdampak pada kenyamanan, tetapi juga pada kesehatan fisik secara keseluruhan.

Dimensi psikologis juga sangat dipengaruhi oleh kualitas tidur. Lansia yang mengalami gangguan tidur sering kali lebih rentan terhadap kecemasan, depresi, dan ketidakstabilan emosi. Sebaliknya, ketika kualitas tidur membaik, lansia cenderung menunjukkan kondisi emosional yang lebih stabil, kemampuan koping yang lebih adaptif, serta peningkatan kesejahteraan psikologis. Hal ini mengindikasikan bahwa intervensi yang berfokus pada perbaikan tidur juga berkontribusi secara signifikan terhadap kesehatan mental lansia (Hertenstein et al., 2022). Oleh karena itu, outcome yang diharapkan perlu mencakup aspek psikologis sebagai bagian integral dari keberhasilan asuhan keperawatan.

Kualitas tidur yang baik juga memberikan dampak pada aspek sosial kehidupan lansia. Lansia yang mampu tidur dengan baik cenderung lebih aktif dalam berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, memiliki hubungan interpersonal yang lebih positif, serta menunjukkan tingkat kepercayaan diri yang lebih baik.

Kondisi ini memungkinkan lansia untuk tetap berpartisipasi dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. World Health Organization (WHO) menegaskan bahwa kualitas hidup lansia dipengaruhi oleh berbagai dimensi, termasuk kesehatan fisik, kondisi psikologis, tingkat kemandirian, serta hubungan sosial, yang semuanya berkaitan erat dengan kualitas tidur (Buysse, 2014). Dengan demikian, tidur yang adekuat memiliki peran strategis dalam menunjang kesejahteraan secara holistik.

Outcome utama dari intervensi nonfarmakologis pada lansia dengan gangguan tidur adalah tercapainya kualitas hidup yang lebih baik melalui pemenuhan kebutuhan tidur yang adekuat dan berkualitas. Dalam praktik keperawatan, perawat memiliki peran strategis dalam mengintegrasikan berbagai indikator outcome, baik yang bersifat fisik, psikologis, maupun sosial, dalam proses evaluasi. Pendekatan yang berpusat pada pasien serta didukung oleh bukti ilmiah menjadi kunci dalam memastikan keberlanjutan manfaat intervensi. Dengan demikian, peningkatan kualitas tidur tidak hanya menjadi target jangka pendek, tetapi juga merupakan bagian dari upaya jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan lansia secara menyeluruh.

4. Pendekatan menekankan *patient-centered care* dan *evidence-based practice*.

Pendekatan dalam asuhan keperawatan pada lansia dengan gangguan tidur saat ini semakin menekankan pentingnya integrasi *patient-centered care* dan *evidence-*

based practice sebagai fondasi dalam pengambilan keputusan klinis. Pendekatan *patient-centered care* menempatkan lansia sebagai pusat perhatian dalam seluruh proses perawatan, dengan mempertimbangkan kebutuhan, preferensi, nilai, serta kondisi unik setiap individu. Sementara itu, *evidence-based practice* menuntut perawat untuk menggabungkan bukti ilmiah terbaik dengan keahlian klinis serta nilai-nilai yang dianut pasien. Integrasi kedua pendekatan ini menjadi landasan penting untuk memastikan bahwa intervensi yang diberikan tidak hanya efektif secara klinis, tetapi juga relevan dan bermakna bagi lansia (Kwame & Petrucka, 2021).

Penerapan *patient-centered care* mengharuskan perawat untuk memahami lansia secara menyeluruh. Pendekatan ini tidak terbatas pada aspek medis semata, tetapi juga mencakup dimensi psikologis, sosial, dan spiritual. Lansia sering kali memiliki kebutuhan yang khas, termasuk pengalaman hidup yang panjang, pola tidur yang telah terbentuk dalam waktu lama, serta preferensi tertentu terkait lingkungan dan rutinitas harian. Dengan melibatkan lansia secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, perawat dapat merancang intervensi yang lebih sesuai dengan kondisi individu. Selain itu, pendekatan ini juga berperan dalam membangun hubungan terapeutik yang kuat antara perawat dan pasien, yang pada akhirnya mendukung keberhasilan intervensi (Mccance & McCormack, 2025).

Penerapan *evidence-based practice* dalam intervensi nonfarmakologis menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan memiliki dasar ilmiah yang kuat. Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa intervensi seperti *sleep hygiene*, teknik relaksasi, serta terapi komplementer efektif dalam meningkatkan kualitas tidur pada lansia. Oleh karena itu, perawat dituntut untuk mampu mengakses, mengevaluasi, dan mengintegrasikan hasil penelitian terkini ke dalam praktik klinik. Dengan demikian, keputusan yang diambil tidak hanya bertumpu pada pengalaman klinis, tetapi juga didukung oleh bukti ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan (Chays-amania et al., 2025).

Integrasi antara *patient-centered care* dan *evidence-based practice* memungkinkan perawat untuk memberikan asuhan yang lebih adaptif dan individual. Dalam praktiknya, pemilihan intervensi dapat disesuaikan dengan preferensi lansia sekaligus mempertimbangkan efektivitas yang telah terbukti secara ilmiah. Pendekatan ini juga memberikan ruang fleksibilitas dalam menyesuaikan intervensi berdasarkan respons pasien yang bersifat dinamis. Selain itu, keterlibatan keluarga sebagai sistem pendukung dapat dioptimalkan dalam kerangka ini untuk menjaga konsistensi dan keberlanjutan intervensi, terutama dalam konteks perawatan di rumah (Engle et al., 2021).

Penerapan *patient-centered care* dan *evidence-based practice* dalam asuhan keperawatan lansia dengan gangguan tidur merupakan strategi yang esensial dalam mencapai hasil yang optimal. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efektivitas intervensi, tetapi juga memastikan bahwa perawatan yang diberikan selaras dengan kebutuhan dan nilai pasien. Dalam praktik keperawatan modern, kemampuan untuk mengintegrasikan kedua pendekatan tersebut menjadi kompetensi inti yang harus dimiliki oleh perawat. Dengan demikian, peningkatan kualitas tidur lansia dapat dicapai secara berkelanjutan, sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup mereka secara menyeluruh.

5. Peran monitoring dan dokumentasi dalam evaluasi intervensi tidur pada lansia

Monitoring dan dokumentasi merupakan komponen integral dalam proses evaluasi asuhan keperawatan, khususnya pada lansia dengan gangguan tidur. Dalam konteks keperawatan gerontik, monitoring tidak hanya berfungsi untuk mengamati perubahan kondisi pasien, tetapi juga sebagai sarana untuk menilai efektivitas intervensi yang telah diberikan secara berkelanjutan. Lansia memiliki respons yang cenderung bertahap terhadap intervensi nonfarmakologis, sehingga diperlukan pemantauan yang sistematis dan konsisten untuk menangkap perubahan kecil yang bermakna. Oleh karena itu, peran monitoring menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa intervensi yang diberikan

berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Dimitriadou et al., 2025).

Proses monitoring pada lansia dengan gangguan tidur mencakup pengamatan terhadap berbagai indikator, seperti durasi tidur, kualitas tidur, frekuensi terbangun di malam hari, serta kondisi fisik dan emosional saat bangun. Pengumpulan data ini dapat dilakukan melalui wawancara, observasi langsung, maupun penggunaan alat ukur seperti *sleep diary* atau skala penilaian tidur. Dengan adanya data yang terstruktur, perawat dapat mengidentifikasi pola tidur pasien secara lebih akurat serta mengevaluasi perkembangan yang terjadi dari waktu ke waktu. Pendekatan ini memungkinkan perawat untuk mendeteksi lebih dini apabila intervensi yang diberikan belum memberikan hasil yang optimal (Buysse, 2014).

Dokumentasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses monitoring. Dokumentasi yang baik mencerminkan kualitas asuhan keperawatan yang diberikan serta menjadi bukti tertulis mengenai kondisi pasien, intervensi yang dilakukan, dan hasil yang dicapai. Dalam praktik keperawatan, dokumentasi harus dilakukan secara sistematis, akurat, dan berkesinambungan, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan klinis. Selain itu, dokumentasi juga berfungsi sebagai sarana komunikasi antar tenaga kesehatan, yang memungkinkan adanya koordinasi yang efektif dalam pemberian perawatan (Groot et al., 2022).

Dokumentasi yang komprehensif memungkinkan perawat untuk melakukan evaluasi yang lebih mendalam terhadap efektivitas intervensi nonfarmakologis. Dengan membandingkan data sebelum dan sesudah intervensi, perawat dapat menilai sejauh mana perubahan yang terjadi pada kualitas tidur lansia. Informasi ini sangat penting dalam menentukan apakah intervensi perlu dipertahankan, dimodifikasi, atau diganti dengan pendekatan lain yang lebih sesuai. Selain itu, dokumentasi juga dapat menjadi sumber data untuk pengembangan praktik berbasis bukti, sehingga meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan secara keseluruhan (Davis et al., 2024).

Monitoring dan dokumentasi memiliki peran yang sangat penting dalam evaluasi intervensi tidur pada lansia. Kedua aspek ini saling melengkapi dalam menyediakan informasi yang akurat dan komprehensif mengenai kondisi pasien serta respons terhadap intervensi yang diberikan. Perawat sebagai tenaga profesional memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan monitoring secara konsisten dan mendokumentasikan setiap temuan secara sistematis. Dengan pendekatan yang terstruktur dan berbasis bukti, proses evaluasi dapat dilakukan secara optimal, sehingga mendukung peningkatan kualitas tidur dan kualitas hidup lansia secara berkelanjutan.

D. Implikasi Praktik Keperawatan dan Pendekatan Interdisiplin

1. Pendekatan interdisiplin & implementasi klinik

Pendekatan interdisiplin dalam asuhan keperawatan lansia dengan gangguan tidur kini semakin diakui sebagai kebutuhan mendasar dalam praktik klinik modern. Permasalahan tidur pada usia lanjut tidak muncul secara tunggal, melainkan merupakan hasil interaksi berbagai faktor, seperti kondisi fisik, aspek psikologis, serta dinamika lingkungan sosial. Kompleksitas ini menuntut penanganan yang tidak bersifat parsial. Oleh karena itu, kolaborasi lintas profesi menjadi krusial untuk menghasilkan intervensi yang komprehensif dan berkelanjutan. Dalam situasi ini, perawat memegang peran strategis sebagai koordinator yang menjembatani berbagai profesi kesehatan guna memastikan kesinambungan dan keterpaduan asuhan (Kongkar et al., 2025).

Pendekatan interdisiplin melibatkan beragam tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan spesifik lansia. Dokter berfokus pada pengelolaan kondisi medis dan komorbiditas, psikolog berperan dalam menangani aspek emosional seperti kecemasan dan depresi, sedangkan fisioterapis membantu meningkatkan relaksasi serta fungsi fisik melalui intervensi latihan yang tepat. Selain itu, kontribusi ahli gizi dalam mengatur pola makan yang mendukung kualitas tidur juga tidak dapat diabaikan. Sinergi antarprofesi ini memungkinkan penanganan faktor-faktor yang memengaruhi kualitas tidur dilakukan secara lebih menyeluruh. Sejumlah studi

menunjukkan bahwa pendekatan berbasis tim interdisiplin berkontribusi signifikan terhadap peningkatan luaran klinis dan kualitas hidup lansia (Reeves et al., 2017).



Gambar 3.6

Efektivitas pendekatan ini sangat ditentukan oleh kualitas komunikasi antar anggota tim kesehatan. Pertukaran informasi yang akurat, jelas, dan tepat waktu menjadi fondasi dalam menyelaraskan rencana perawatan yang diberikan kepada pasien. Dalam konteks ini,

dokumentasi keperawatan memiliki peran penting sebagai media komunikasi profesional yang menjamin kontinuitas pelayanan. Perawat dituntut untuk memiliki kemampuan koordinasi yang baik agar mampu mengintegrasikan berbagai rekomendasi dari tim menjadi rencana asuhan yang utuh dan berorientasi pada kebutuhan individu pasien (Reeves et al., 2017).

Implementasi pendekatan interdisiplin perlu disesuaikan dengan setting pelayanan kesehatan. Pada pelayanan berbasis komunitas, keterlibatan keluarga dan caregiver menjadi bagian integral dari tim perawatan, terutama dalam menjaga konsistensi intervensi di lingkungan rumah. Sebaliknya, di rumah sakit, koordinasi biasanya dilakukan melalui mekanisme formal seperti diskusi kasus atau *case management*. Pendekatan ini memungkinkan evaluasi dilakukan secara berkala serta memberikan ruang untuk penyesuaian intervensi sesuai dengan respons lansia yang cenderung dinamis (Reeves et al., 2017).

Penerapan pendekatan interdisiplin dalam praktik klinik merupakan strategi yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas tidur lansia. Kolaborasi antarprofesi memungkinkan penanganan yang lebih komprehensif terhadap berbagai faktor yang mendasari gangguan tidur. Dalam hal ini, perawat memiliki peran sentral dalam mengoordinasikan asuhan, memastikan integrasi intervensi, serta menjaga kesinambungan pelayanan. Dengan pendekatan yang kolaboratif, sistematis, dan berbasis bukti, peningkatan kualitas tidur lansia diharapkan dapat dicapai secara optimal, sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup mereka secara menyeluruh.

E. Kesimpulan

Gangguan tidur pada lansia dapat dipandang sebagai kondisi yang kompleks dan multidimensional, yang muncul akibat interaksi berbagai faktor biologis, psikologis, dan lingkungan. Proses penuaan yang disertai perubahan fungsi tubuh, keberadaan penyakit kronis, serta dinamika emosional membuat lansia lebih rentan mengalami penurunan kualitas tidur. Oleh karena itu, dalam praktik keperawatan, pendekatan yang digunakan tidak dapat bersifat parsial, melainkan harus berlandaskan pada pengkajian yang komprehensif dengan perspektif geriatri, sehingga kondisi pasien dapat dipahami secara menyeluruh dan intervensi yang diberikan menjadi lebih tepat dan kontekstual.

Intervensi nonfarmakologis memiliki peran penting sebagai strategi yang aman dan efektif dalam meningkatkan kualitas tidur lansia. Berbagai upaya seperti pengaturan lingkungan tidur, penerapan teknik relaksasi, pembiasaan *sleep hygiene*, penggunaan terapi komplementer, serta komunikasi terapeutik terbukti mampu membantu memperbaiki pola tidur tanpa menimbulkan risiko efek samping yang signifikan. Meskipun demikian, keberhasilan intervensi tersebut sangat ditentukan oleh konsistensi pelaksanaan, dukungan keluarga sebagai sistem pendamping, serta kemampuan perawat dalam menerapkan pendekatan yang berpusat pada pasien dan berbasis bukti. Di samping itu, respons lansia yang cenderung berkembang secara bertahap menegaskan pentingnya monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan.

Tujuan utama dari asuhan keperawatan pada lansia dengan gangguan tidur tidak hanya berfokus pada perbaikan gejala, tetapi juga pada peningkatan kualitas

hidup secara menyeluruh. Tidur yang adekuat berkontribusi terhadap kestabilan kondisi fisik, keseimbangan psikologis, serta kemampuan lansia untuk tetap berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Dalam hal ini, perawat memegang peran strategis sebagai koordinator dalam pendekatan interdisiplin guna memastikan integrasi intervensi berjalan secara optimal. Dengan pendekatan yang kolaboratif, sistematis, dan berkesinambungan, upaya peningkatan kualitas tidur diharapkan mampu memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan lansia secara holistik.

F. Referensi:

- Adam, P., Stone, K. L., & Kaufmann, C. N. (2023). *Sleep , Circadian Rhythms , and Aging: Advancing Knowledge to Promote Older Adults ' Health*. 78, 1812–1815.
- Alvaro, P. K., Honors, B. P., Roberts, R. M., Hons, B. A., Clinical, M., Harris, J. K., Hons, B., & Psych, C. (2011). *REVIEW OF SLEEP DISTURBANCES , ANXIETY AND DEPRESSION A Systematic Review Assessing Bidirectionality between Sleep Disturbances , Anxiety , and Depression*.
- Ashery, R. E. A., Ibrahim, S. A., Ghazi, G. A., & ... (2021). Effectiveness of Progressive Muscle Relaxation Technique on Anxiety and Sleep Pattern among Newly Women with Breast Cancer. *Assiut Scientific*
https://journals.ekb.eg/article_179057.html
- Baglioni, C., Bassetti, C., Groselj, L. D., Ellis, J. G., Espie, C. A., Garcia-borreguero, D., Gjerstad, M., & S, A. L. V. E. (2017). *European insomnia guideline European*

- guideline for the diagnosis and treatment of insomnia.* 675–700.
<https://doi.org/10.1111/jsr.12594>
- Baglioni, C., Nanovska, S., Regen, W., & Spiegelhalter, K. (2017). *HHS Public Access*. 142(9), 969–990.
<https://doi.org/10.1037/bul0000053>.SLEEP
- Basner, M. (2018). *WHO Environmental Noise Guidelines for the European Region: A Systematic Review on Environmental Noise and Effects on Sleep*.
<https://doi.org/10.3390/ijerph15030519>
- Billioti, S., Gage, D., Bégaud, B., & Bazin, F. (2012). *Benzodiazepine use and risk of dementia: prospective*. 6231(September), 1–12.
<https://doi.org/10.1136/bmj.e6231>
- Bloom, H. G., Ahmed, I., Alessi, C. A., Ancoli-israel, S., Buysse, D. J., Kryger, M. H., Phillips, B. A., Thorpy, M. J., Vitiello, M. V, & Zee, P. C. (2009). *Evidence-Based Recommendations for the Assessment and Management of Sleep Disorders in Older Persons*. 761–789.
<https://doi.org/10.1111/j.1532-5415.2009.02220.x>
- Buyse, D. J. (2014). *Sleep Health: Can We Define It? Does It Matter?*
- Chays-amania, A., Schwingrouber, J., & Mazurek, B. (2025). *Mapping Implementation Strategies and Outcomes When Using Evidence Based Practice Implementation Models in Nursing Settings: A Scoping Review*.
<https://doi.org/10.1111/wvn.70050>

- Chen, X., Cai, H., & Guo, J. (2022). Effect of TEAS combined with general anesthesia on early postoperative cognitive function in elderly patients undergoing single-port thoracoscopic lobectomy. In *Pakistan Journal of Medical Sciences*. ncbi.nlm.nih.gov. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9676590/>
- Davis, J., Nsg, B., Hons, B., & Shephard, J. (2024). *Clinical documentation integrity: Its role in health data integrity , patient safety and quality outcomes and its impact on clinical coding and health information management*. <https://doi.org/10.1177/18333583231218029>
- Dimitriadou, I., Sini, E., Šteinmiller, J., Saridi, M., Lundberg, A., Häger, M., Hjaltadottir, I., Skuladottir, S. S., Korsström, N., Mört, S., Tuori, H., & Fradelos, E. C. (2025). *Comprehensive Geriatric Health Assessment Core Competencies and Skills for Primary Care Nurses : A Scoping Review*. 1–17.
- Eggmann, S., Luder, G., Verra, M. L., Irincheeva, I., Bastiaenen, C. H. G., & Jakob, S. M. (2020). Functional ability and quality of life in critical illness survivors with intensive care unit acquired weakness: A secondary analysis of a randomised controlled trial. *PLoS ONE*, 15(3). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0229725>
- Engle, R. L., Mohr, D. C., Holmes, S. K., Nealon, M., Melissa, S., Jenniffer, A., & Mark, L. (2021). *Doing both well*. 46(3). <https://doi.org/10.1097/HMR.0000000000000254>

- Fang, H., Tu, S., Sheng, J., & Shao, A. (2019). *Depression in sleep disturbance: A review on a bidirectional relationship , mechanisms and treatment. December 2018,* 2324–2332.
<https://doi.org/10.1111/jcmm.14170>
- Fernandes, M., Antonucci, M., Sc, B., Capecci, F., Mercuri, N. B., Della-morte, D., & Liguori, C. (2024). Prevalence of sleep disorders in geriatrics: an exploratory study using sleep questionnaires. *Geriatric Nursing, 60,* 107–113.
<https://doi.org/10.1016/j.gerinurse.2024.08.032>
- Glass, J., Lanctôt, K. L., Herrmann, N., Sproule, B. A., & Busto, U. E. (2005). *risks and benefits. 47*(November), 6–12.
<https://doi.org/10.1136/bmj.38623.768588.47>
- Griffin, S. C., Williams, A. B., Ravyts, S. G., Mladen, S. N., & Rybarczyk, B. D. (2020). *Loneliness and sleep: A systematic review and meta-analysis.*
<https://doi.org/10.1177/2055102920913235>
- Groot, K. De, Veer, A. J. E. De, Munster, A. M., Francke, A. L., & Paans, W. (2022). *Nursing documentation and its relationship with perceived nursing workload: a mixed- methods study among community nurses.* 1–12.
- Gwaza, E., & Msiska, G. (2022). *Family Involvement in Caring for Inpatients in Acute Care Hospital Settings: A Systematic Review of Literature.*
<https://doi.org/10.1177/23779608221089541>
- Halperin, D. (2014). Environmental noise and sleep disturbances : A threat to health ? *Sleep Science,*

- 7(4), 209–212.
<https://doi.org/10.1016/j.slsi.2014.11.003>
- Harding, E. C., Franks, N. P., & Wisden, W. (2019). *The Temperature Dependence of Sleep*. 13(April), 1–16. <https://doi.org/10.3389/fnins.2019.00336>
- Hertenstein, E., Trinca, E., Wunderlin, M., Schneider, C. L., Su, T., Berger, T., Züst, M. A., Feh, K. D., Baglioni, C., Johann, A., Spiegelhalder, K., Riemann, D., Feige, B., & Nissen, C. (2022). *Cognitive behavioral therapy for insomnia in patients with mental disorders and comorbid insomnia: A systematic review and*. 62.
<https://doi.org/10.1016/j.smr.2022.101597>
- Holbrook, A. M., Crowther, R., Lotter, A., Cheng, C., & King, D. (2000). *in the treatment of insomnia*. 162(2), 10–15.
- Hood, S., & Amir, S. (2017). *The aging clock: circadian rhythms and later life*. 127(2), 437–446.
- Id, T. M. B., Id, G. C. B., Cajochen, C., Czeisler, C. A., Hanifin, J. P., Lockley, S. W., Id, R. J. L., Mu, M., Zee, P. C., & Wright, K. P. (2022). *Recommendations for daytime , evening , and nighttime indoor light exposure to best support physiology, sleep , and wakefulness in healthy adults*. 1–24.
<https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3001571>
- Irish, L. A., Kline, C. E., Gunn, H. E., Buysse, D. J., & Martica, H. (2016). *of Empirical Evidence*. 701, 23–36.
<https://doi.org/10.1016/j.smr.2014.10.001>
- Ju, Y. S., Mclelland, J. S., Toedebusch, C. D., Xiong, C., Fagan,

- A. M., Duntley, S. P., Morris, J. C., & David, M. (2014). *NIH Public Access*. 70(5), 587–593. <https://doi.org/10.1001/jamaneurol.2013.2334.Sleep>
- Kline, C. E., Knutson, K. L., Redeker, N., & Grandner, M. A. (2025). *Multidimensional Sleep Health: Definitions and Implications for Cardiometabolic Health: May*, 443–456. <https://doi.org/10.1161/HCQ.0000000000000139>
- Kongkar, R., Ruksakulpiwat, S., Phianhasin, L., Benjasirisan, C., Niyomyart, A., Ahmed, B. H., Puwarawuttipanit, W., Chuenkongkaew, W. L., & Adams, J. (2025). *The Impact of Interdisciplinary Team-Based Care on the Care and Outcomes of Chronically Ill Patients: A Systematic Review. January*, 445–457.
- Kooijmans, E. C. M., Hoogendijk, E. O., Drapa, N., Antonenko, O., Burchell, G. L., Mphil, H. P. J. V. H., & Joling, K. J. (2025). *De fi ning and Categorizing Nonpharmacologic Interventions in the Older Population: A Systematic Review Ilona Bara n. 26*. <https://doi.org/10.1016/j.jamda.2024.105306>
- Kwame, A., & Petrucka, P. M. (2021). *A literature-based study of patient-centered care and communication in nurse-patient interactions: barriers, facilitators, and the way forward*. 1–10.
- León-barriera, R., Chaplin, M. M., & Modesto-low, V. (n.d.). *Insomnia in older adults*: 43–50. <https://doi.org/10.3949/ccjm.92a.24073>
- Mander, B. A., Winer, J. R., & Walker, M. P. (2017). Sleep and

- Human Aging. *Neuron*, 94(1), 19–36.
<https://doi.org/10.1016/j.neuron.2017.02.004>
- Mangoni, A. A., & Jackson, S. H. D. (2003). *Age-related changes in pharmacokinetics and pharmacodynamics: basic principles and practical applications*.
<https://doi.org/10.1046/j.1365-2125.2003.02007.x>
- Mccance, T., & McCormack, B. (2025). *The Person-centred Nursing Framework: a mid-range theory for nursing practice*.
<https://doi.org/10.1177/17449871241281428>
- Mccarthy, E., & Guerin, S. (2022). *Family-centred care in early intervention: A systematic review of the processes and outcomes of family-centred care and impacting factors* (Nomor August 2020).
<https://doi.org/10.1111/cch.12901>
- Morin, C. M., Bootzin, R. R., Buysse, D. J., Edinger, J. D., Espie, C. A., & Lichstein, K. L. (2004). *Psychological And Behavioral Treatment Of Insomnia: Update Of The Recent Evidence (1998-2004)*.
- Palagini, L., Miniati, M., Caruso, V., Alfi, G., Alexis, P., Domschke, K., Riemann, D., Gemignani, A., & Pini, S. (2024). Neuroscience Applied Insomnia , anxiety and related disorders: a systematic review on clinical and therapeutic perspective with potential mechanisms underlying their complex link. *Neuroscience Applied*, 3(July 2023), 103936.
<https://doi.org/10.1016/j.nsa.2024.103936>

- Patel, D., Steinberg, J., & Patel, P. (2018). *Insomnia in the Elderly: A Review*.
- Phillips, A. J. K., Clerx, W. M., Brien, C. S. O., Akane, S., Laura, K., Picard, R. W., Steven, W. L., Klerman, E. B., & Charles, A. (2017). *Irregular sleep / wake patterns are associated with poorer academic performance and delayed circadian and sleep / wake timing*. December 2016, 1–13. <https://doi.org/10.1038/s41598-017-03171-4>
- Reeves, S., Pelone, F., Harrison, R., Goldman, J., Zwarenstein, M., Reeves, S., Pelone, F., Harrison, R., Goldman, J., & Zwarenstein, M. (2017). *Interprofessional collaboration to improve professional practice and healthcare outcomes (Review)*. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD000072.pub3>. www.cochranelibrary.com
- Rhythm, C. (2026). *highlighted topics*. 852–862.
- Rostamzadeh, F., Joukar, S., & Yeganeh-hajahmadi, M. (2024). The role of Klotho and sirtuins in sleep- related cardiovascular diseases: a review study. *npj Aging*. <https://doi.org/10.1038/s41514-024-00165-1>
- Salamung, N., & Elmiyanti, N. K. (2023). *IJNHS Effect of Aromatherapy on Sleep Quality: A*. 6(5), 292–302.
- Sepahvand, E., Jalali, R., Khaledi Paveh, B., & Rezaei, M. (2014). Development and Validation of Sleep Disturbance Questionnaire in Patients with Acute Coronary Syndrome. *International Scholarly Research Notices*, 2014, 1–8. <https://doi.org/10.1155/2014/978580>

- Song, J., Dong, H., Wang, C., Zheng, Y., Huang, Y., Wei, Y., Zhang, K., Qing, H., Xiong, Z., Pan, Y., Chen, M., Kang, R., Ghose, B., Tang, D., Wang, R., Long, C., Li, Y., & Tang, S. (2026). *Effects of non - pharmacological interventions on sleep quality in older adults: a systematic review and network meta - analysis of randomized controlled trials.*
- Sparks, D. S., Saifzadeh, S., Savi, F. M., Dlaska, C. E., & ... (2020). A preclinical large-animal model for the assessment of critical-size load-bearing bone defect reconstruction. *Nature* <https://www.nature.com/articles/s41596-019-0271-2>
- Stone, K. L., Blackwell, T. L., Ancoli-israel, S., Cauley, J. A., Redline, S., Marshall, L. M., & Ensrud, K. E. (2015). *NIH Public Access*. 62(2), 299–305. <https://doi.org/10.1111/jgs.12649>.Sleep
- Tatineny, P., Shafi, F., Gohar, A., & Bhat, A. (2020). Science of Medicine sleep in the elderly. *Missouri Medicine*, 117(5), 490–495. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7723148/>
- The physiological effects of slow breathing in the healthy human.* (n.d.). 13(4), 298–309.
- Wang, J. (2025). *Daytime napping and nighttime sleep and motoric cognitive risk syndrome among Chinese older adults: a nationwide cohort study.*
- Wang, Z., Xiong, Z., Yang, Y., & Zhuang, J. (2026). *Archives of Public Health Article in Press Non-pharmacological interventions for improving*

sleep quality in adults aged 50 years and older: a systematic review and network IN AR IN. 0–36.

- Wastesson, J. W., Morin, L., Tan, E. C. K., Johnell, K., Wastesson, J. W., Morin, L., Tan, E. C. K., & Johnell, K. (2018). *Expert Opinion on Drug Safety An update on the clinical consequences of polypharmacy in older adults: a narrative review review.* 0338.
<https://doi.org/10.1080/14740338.2018.1546841>
- Wong, S. S. S., Liu, T. W., & Ng, S. S. M. (2024). Effects of a tailor-made yoga program on upper limb function and sleep quality in women with breast cancer: A pilot randomized controlled trial. In *Heliyon*. cell.com.
[https://www.cell.com/heliyon/fulltext/S2405-8440\(24\)11914-7](https://www.cell.com/heliyon/fulltext/S2405-8440(24)11914-7)
- Yin, N., Joey, C., Yan, W., Shirley, C., Li, X., & Wing, Y. K. (2021). Non - pharmacological Approaches for Management of Insomnia. *Neurotherapeutics*, 32–43. <https://doi.org/10.1007/s13311-021-01029-2>
- Zhang, Y., Xie, B., Chen, X., Zhang, J., & Yuan, S. (2021). A key role of gut microbiota-vagus nerve/spleen axis in sleep deprivation-mediated aggravation of systemic inflammation after LPS administration. *Life sciences*.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0024320520314892>

PROFIL PENULIS



Resa Livia Nica, S.Kep., Ns., M.Kes Lahir di Menggala, 20 Desember 1990. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Mitra Indonesia tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Mitra Indonesia dan lulus pada tahun 2015. Lalu pada tahun 2021 melanjutkan Program Profesi Ners di Universitas Mitra Indonesia lulus tahun 2022. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2015. Saat ini penulis bekerja di Universitas Mitra Indonesia mengampu mata kuliah Sistem Informasi Keperawatan, Biostatistik. Promosi Kesehatan, Metodologi Penelitian, Komunikasi Dasar Keperawatan, Falsafah dan Teori Keperawatan, Psikososial dan Budaya dalam Keperawatan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: resalivianica@umitra.ac.id. Motto: "Ilmu Yang Bermanfaat Adalah Warisan Terbaik."

SINOPSIS

Bunga rampai **“Asuhan Keperawatan pada Lansia dengan Gangguan Tidur”** merupakan karya yang membahas secara komprehensif mengenai permasalahan tidur pada lanjut usia serta peran penting perawat dalam memberikan asuhan yang tepat, aman, dan berpusat pada kebutuhan lansia. Gangguan tidur merupakan salah satu masalah yang sering dialami lansia sebagai akibat dari proses menua, perubahan fisiologis, kondisi kesehatan, faktor psikologis, lingkungan, maupun kebiasaan hidup sehari-hari. Apabila tidak ditangani dengan baik, gangguan tidur dapat berdampak pada penurunan kualitas hidup, kelelahan, gangguan konsentrasi, perubahan emosi, peningkatan risiko jatuh, serta menurunnya kemampuan lansia dalam menjalankan aktivitas harian.

Pembahasan dalam buku ini diawali dengan **konsep dasar proses menua dan perubahan pola tidur lansia**. Bagian ini menguraikan bagaimana proses penuaan memengaruhi kebutuhan istirahat dan tidur, termasuk perubahan durasi tidur, kualitas tidur, siklus tidur, serta kecenderungan lansia untuk lebih mudah terbangun pada malam hari. Pemahaman ini menjadi dasar penting bagi perawat dalam mengenali perubahan tidur yang bersifat normal maupun yang mengarah pada gangguan kesehatan.

Selanjutnya, buku ini membahas **faktor-faktor yang memengaruhi gangguan tidur pada lansia**, baik dari aspek fisik, psikologis, sosial, lingkungan, maupun penyakit penyerta. Faktor seperti nyeri kronis, kecemasan, depresi, penggunaan obat-obatan, kurang aktivitas fisik, kebisingan lingkungan,

pencapaian yang kurang sesuai, serta perubahan rutinitas harian dapat berkontribusi terhadap menurunnya kualitas tidur lansia. Melalui pembahasan ini, pembaca diharapkan mampu memahami pentingnya pengkajian keperawatan yang menyeluruh dalam mengidentifikasi penyebab gangguan tidur.

Bunga rampai ini juga menyajikan berbagai **intervensi nonfarmakologis dalam meningkatkan kualitas tidur pada lansia**. Pendekatan seperti sleep hygiene, relaksasi, terapi musik, aktivitas fisik ringan, pengaturan lingkungan tidur, teknik napas dalam, dukungan psikososial, serta edukasi kepada lansia dan keluarga menjadi bagian penting dalam asuhan keperawatan. Intervensi nonfarmakologis dipandang sebagai pilihan yang aman, mudah diterapkan, dan sesuai dengan prinsip keperawatan gerontik yang menekankan kenyamanan, kemandirian, serta kualitas hidup lansia.

Secara keseluruhan, buku ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa keperawatan, perawat, dosen, peneliti, caregiver, serta tenaga kesehatan lainnya dalam memahami dan menerapkan asuhan keperawatan pada lansia dengan gangguan tidur. Dengan pendekatan yang holistik, humanis, dan berbasis kebutuhan individu, bunga rampai ini memberikan kontribusi dalam meningkatkan mutu pelayanan keperawatan gerontik serta mendukung lansia agar dapat menjalani kehidupan yang lebih sehat, nyaman, dan bermakna.

Bunga rampai “Asuhan Keperawatan pada Lansia dengan Gangguan Tidur” merupakan karya yang membahas secara komprehensif mengenai permasalahan tidur pada lanjut usia serta peran penting perawat dalam memberikan asuhan yang tepat, aman, dan berpusat pada kebutuhan lansia. Gangguan tidur merupakan salah satu masalah yang sering dialami lansia sebagai akibat dari proses menua, perubahan fisiologis, kondisi kesehatan, faktor psikologis, lingkungan, maupun kebiasaan hidup sehari-hari. Apabila tidak ditangani dengan baik, gangguan tidur dapat berdampak pada penurunan kualitas hidup, kelelahan, gangguan konsentrasi, perubahan emosi, peningkatan risiko jatuh, serta menurunnya kemampuan lansia dalam menjalankan aktivitas harian.

Pembahasan dalam buku ini diawali dengan konsep dasar proses menua dan perubahan pola tidur lansia. Bagian ini menguraikan bagaimana proses penuaan memengaruhi kebutuhan istirahat dan tidur, termasuk perubahan durasi tidur, kualitas tidur, siklus tidur, serta kecenderungan lansia untuk lebih mudah terbangun pada malam hari. Pemahaman ini menjadi dasar penting bagi perawat dalam mengenali perubahan tidur yang bersifat normal maupun yang mengarah pada gangguan kesehatan.

Selanjutnya, buku ini membahas faktor-faktor yang memengaruhi gangguan tidur pada lansia, baik dari aspek fisik, psikologis, sosial, lingkungan, maupun penyakit penyerta. Faktor seperti nyeri kronis, kecemasan, depresi, penggunaan obat-obatan, kurang aktivitas fisik, kebisingan lingkungan, pencahayaan yang kurang sesuai, serta perubahan rutinitas harian dapat berkontribusi terhadap menurunnya kualitas tidur lansia. Melalui pembahasan ini, pembaca diharapkan mampu memahami pentingnya pengkajian keperawatan yang menyeluruh dalam mengidentifikasi penyebab gangguan tidur.

Bunga rampai ini juga menyajikan berbagai intervensi nonfarmakologis dalam meningkatkan kualitas tidur pada lansia. Pendekatan seperti sleep hygiene, relaksasi, terapi musik, aktivitas fisik ringan, pengaturan lingkungan tidur, teknik napas dalam, dukungan psikososial, serta edukasi kepada lansia dan keluarga menjadi bagian penting dalam asuhan keperawatan. Intervensi nonfarmakologis dipandang sebagai pilihan yang aman, mudah diterapkan, dan sesuai dengan prinsip keperawatan gerontik yang menekankan kenyamanan, kemandirian, serta kualitas hidup lansia.

Secara keseluruhan, buku ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa keperawatan, perawat, dosen, peneliti, caregiver, serta tenaga kesehatan lainnya dalam memahami dan menerapkan asuhan keperawatan pada lansia dengan gangguan tidur. Dengan pendekatan yang holistik, humanis, dan berbasis kebutuhan individu, bunga rampai ini memberikan kontribusi dalam meningkatkan mutu pelayanan keperawatan gerontik serta mendukung lansia agar dapat menjalani kehidupan yang lebih sehat, nyaman, dan bermakna.

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620



ISBN 978-634-7756-44-2 (PDF)



9

786347

756442